

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
CENTRO DE CIÊNCIAS MÉDICAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**

MIRELLY DA SILVA BARROS

**REPERCUSSÕES DA MEDIAÇÃO DE HISTÓRIAS NOS ASPECTOS EMOCIONAIS DE
CRIANÇAS HOSPITALIZADAS: ESTUDO MULTIMÉTODO**

**RECIFE
2026**



MIRELLY DA SILVA BARROS

REPERCUSSÕES DA MEDIAÇÃO DE HISTÓRIAS NOS ASPECTOS EMOCIONAIS DE CRIANÇAS HOSPITALIZADAS: ESTUDO MULTIMÉTODO

Tese submetida à banca do Programa de Pós-Graduação em Saúde da Criança e do Adolescente, da Universidade Federal de Pernambuco, como requisito parcial para a obtenção do título de Doutor em Saúde da Criança e do Adolescente.

Área de concentração: saúde da criança e do adolescente.

Linha de pesquisa: educação e saúde.

Orientadora: Prof^a. Dr^a. Maria Wanderleya de Lavor Coriolano-Marinus

Coorientadora: Prof^a. Dr^a. Soraya Vieira Santos

RECIFE
2026



.Catalogação de Publicação na Fonte. UFPE - Biblioteca Central

Barros, Mirelly da Silva.

Repercussões da mediação de histórias nos aspectos emocionais de crianças hospitalizadas: estudo multimétodo / Mirelly da Silva Barros. - Recife, 2026.
186f.: il.

Tese (Doutorado) - Universidade Federal de Pernambuco, Centro de Ciências Médicas, Programa de Pós-Graduação em Saúde da Criança e do Adolescente, 2026.

Orientação: Maria Wanderleya de Lavor Coriolano-Marinus.

Coorientação: Soraya Vieira Santos.

Inclui Referências, Apêndices e Anexos.

1. Criança Hospitalizada; 2. Contação de Histórias; 3. Literatura Infantil Digital; 4. Tecnologia em Saúde; 5. Beleza; 6. Tecnologia Educacional. I. Coriolano-Marinus, Maria Wanderleya de Lavor. II. Santos, Soraya Vieira. III. Título.

UFPE-Biblioteca Central

MIRELLY DA SILVA BARROS

REPERCUSSÕES DA MEDIAÇÃO DE HISTÓRIAS NOS ASPECTOS EMOCIONAIS DE CRIANÇAS HOSPITALIZADAS: ESTUDO MULTIMÉTODO

Tese submetida à banca do Programa de Pós-Graduação em Saúde da Criança e do Adolescente, da Universidade Federal de Pernambuco, como requisito parcial para a obtenção do título de Doutor em Saúde da Criança e do Adolescente.

Área de concentração: saúde da criança e do adolescente.

Linha de pesquisa: educação e saúde.

Aprovado em: 06/02/2026

BANCA EXAMINADORA

Maria Wanderleya de Lavor Coriolano-Marinus (Presidente)
Universidade Federal de Pernambuco - UFPE

Joseph Dimas de Oliveira (Examinador externo)
Universidade Regional do Cariri - URCA

Fernanda Machado Silva-Rodrigues (Examinador externo)
Universidade de São Paulo - USP

Tatiana Cristina Vasconcelos Maia (Examinador externo)
Universidade Federal de Pará – UFPA

Estela Maria Leite Meirelles Monteiro (Examinador interno)
Universidade Federal de Pernambuco - UFPE



AGRADECIMENTOS

Ao bom Deus, por sua presença constante em minha vida e por fazer o meu caminhar ter sempre o seu terno e eterno amor.

A Maria Santíssima, por ser uma estrela guia, por enviar seus anjos, por ser meu perpétuo socorro e por vir em meu auxílio. Santa Maria, mãe de Deus e minha.

Ao meu esposo, Ítalo, por ser uma presença de alegria e canção em todos os dias. E por ter me ajudado com os desenhos e ilustrações carinhosamente em diferentes momentos dessa construção.

Aos meus pais, pelo apoio e compreensão. Em especial à minha mãe, Mauriceia, por seu amor sem limites.

Às minhas irmãs, Michelly e Milleny, por acreditarem em mim, por nossa amizade, por nosso amor. Vocês me ensinam todos os dias.

Aos demais familiares, por me incentivarem e rezarem sempre pelos meus projetos.

Aos amigos, próximos e mais distantes, pelas palavras de carinho e conforto em diversos momentos. Vocês tornaram os dias mais bonitos.

Às doutorandas da turma DO-17, mulheres fortes, cujas trajetórias são fonte constante de inspiração.

À minha orientadora, professora Wanderleya, por sua gentileza e cuidado durante esses seis anos de caminhada e formação. Mais que uma orientadora, tornou-se uma querida amiga, por quem tenho afeto e admiração. Obrigada por todos os ensinamentos.

À minha coorientadora, professora Soraya, por caminhar conosco e tecer valiosas contribuições, sempre amável e solícita. Agradeço por todo o apoio, conversas e pelo acolhimento em terras goianas.





A Adélia e Matheus, por todas as construções, descobertas e aventuras que vivemos juntos durante toda a caminhada do NaveghiBook.

Ao professor João Vilian, pela ajuda inicial e pelo apoio nos primeiros passos do NaveghiBook.

A Maria Beatriz Tabosa, ilustradora de livros que nos ajudou com belíssimos desenhos e ilustrações.

A Isabela, irmã de Matheus, por permitir que sua voz estivesse tão docemente em nosso vídeo de propaganda do NaveghiBook.

A Lucas Soares, sobrinho de Adélia, por colaborar na construção de histórias encantadoras e permitir que elas estivessem nesse projeto.

Aos professores e amigos da Universidade Federal de Campina Grande, Alan e Gilvânia, por terem me introduzido na pesquisa científica, despertando-me também para a docência. Vocês são fontes de inspiração enquanto profissionais e seres humanos.

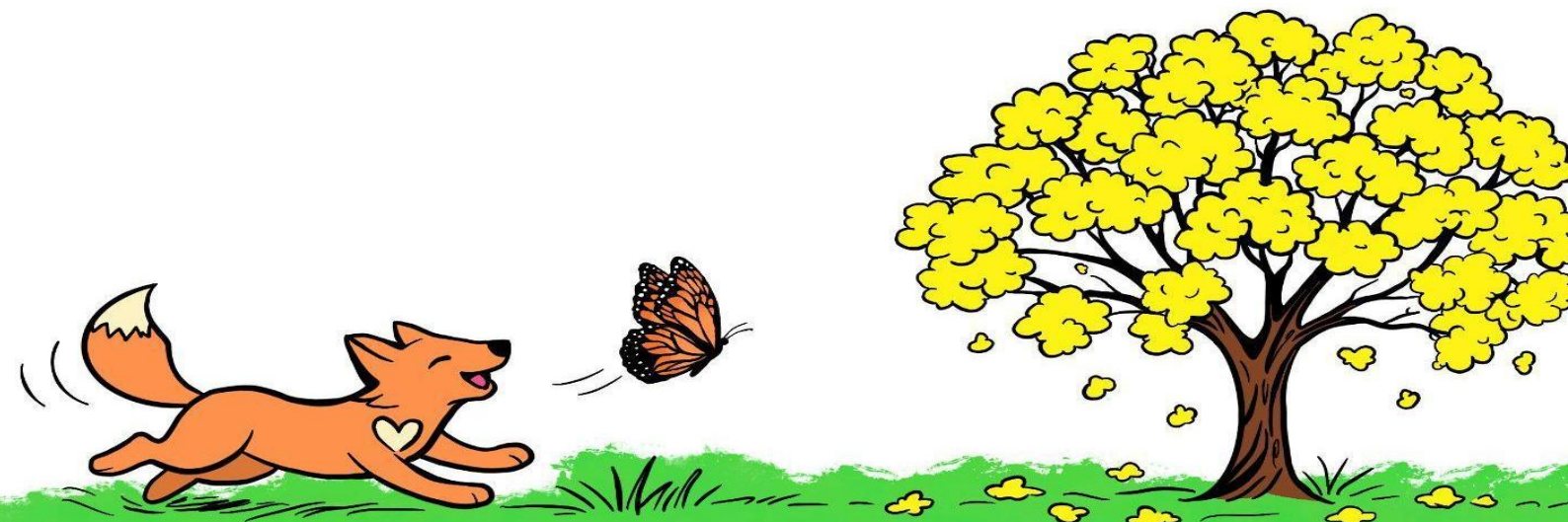
À Dr^a. Lusmaia Damaceno, que, com receptividade e zelo, possibilitou a realização da III etapa do projeto na Unidade de Pediatria do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás.

Aos professores do Programa de Pós-Graduação em Saúde da Criança e Adolescente, pela disponibilidade e ensinamentos durante a minha trajetória na formação como docente e pesquisadora.

Aos professores da pré-banca/banca, pelas contribuições e construções essenciais para o aperfeiçoamento deste estudo.

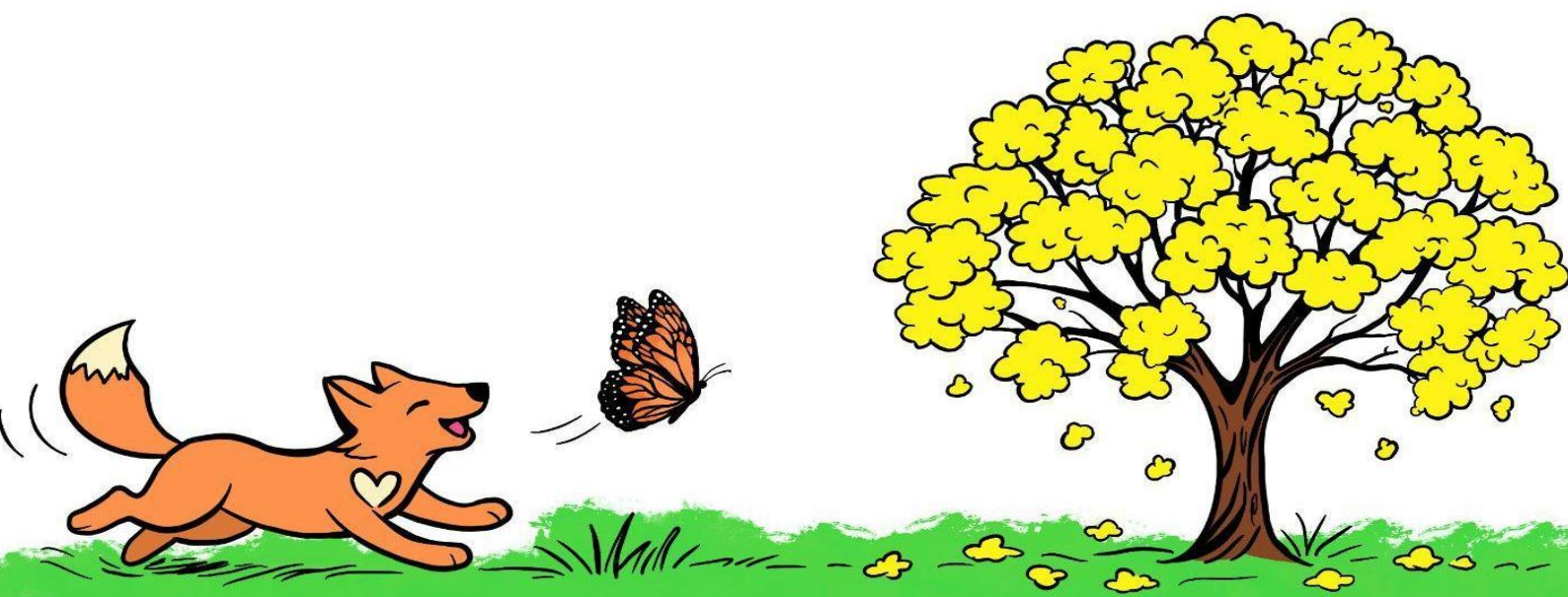
À coordenação e secretaria do Programa de Pós-Graduação em Saúde da Criança e Adolescente, pela solicitude e zelo em acolher/solucionar dúvidas e dificuldades.

Às crianças que participaram do estudo. Vocês tornaram tudo possível e reacenderam a esperança em meu coração.





Eu penso renovar o homem usando borboletas.”
(BARROS, 2013, p. 347)





RESUMO

Introdução: a hospitalização infantil é um cenário que reduz as possibilidades da criança de brincar. Afastada do contexto familiar e escolar, sofre impactos no seu crescimento e desenvolvimento, solicitando cuidados direcionados às suas enfermidades e um olhar sensível para suas necessidades enquanto ser em processo de desenvolvimento. **Objetivo:** o presente estudo visa analisar as repercussões emocionais da mediação de histórias (digitais e com livros físicos) com crianças hospitalizadas. **Método:** estudo multimétodo, desenvolvido em três etapas, com dados qualitativos e quantitativos. Na etapa I, foi realizado um estudo metodológico, através das etapas: a) validação do problema; b) validação das histórias e de versões iniciais do aplicativo NaveghiBook; e c) desenvolvimento inicial do aplicativo NaveghiBook. Na etapa II, foi realizado um estudo de validação: primeira validação do aplicativo NaveghiBook (protótipo I); e validação da versão subsequente (protótipo II) em contextos de emergência e enfermaria pediátrica. Na etapa III, foi realizado um estudo de intervenção com mediação das histórias com recursos físicos e recursos digitais no Serviço de Urgência Clínica Pediátrica e na enfermaria pediátrica do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás. Na etapa III, foram realizados dois grupos de intervenção, intitulados de “grupo de intervenção I” e “grupo de intervenção II”. Os dois grupos de intervenção acessaram as mesmas histórias, em diferentes formatos, com livros físicos e livros digitais. Os livros digitais foram disponibilizados por meio do aplicativo NaveghiBook. Ambas as intervenções foram realizadas pela pesquisadora principal. Os instrumentos de coleta de dados foram a escala *Child Drawing: Hospital* (CD:H), a escala de faces (Turma da Mônica), a escala de Likert, narrativas e produções de desenhos livres e estruturados realizados durante a entrevista com as crianças, além de anotações da observação participante. A análise de dados qualitativos foi realizada com a técnica de análise de conteúdo de Bardin. Para a análise quantitativa, adotou-se uma abordagem fundamentada em estatística descritiva e inferencial simples. Os resultados subsidiaram seis categorias, articuladas ao referencial teórico de Vygotsky. **Resultados:** os resultados do estudo evidenciaram que a mediação de histórias infantis em diferentes formatos (digitais e com livros físicos) melhora os níveis de ansiedade das crianças hospitalizadas ao proporcionar uma experiência estética que permite a expressão da criatividade e da imaginação, transformando os cenários da hospitalização em ambientes mais belos e divertidos. Ao mesmo tempo, a mediação de histórias infantis favorece a interação humana entre cuidadores, crianças, mediadores e livros, promovendo o estabelecimento de vínculos e a construção de novas relações empáticas no contexto da hospitalização. Observou-se também, a partir da escala CD:H, que a média das pontuações de ansiedade diminuiu de 111,17, no primeiro dia, para 95,50, no segundo dia, o que indica uma redução geral da ansiedade ao longo do período. O teste t pareado mostrou que essa diferença foi estatisticamente significativa ($t=3,51$; $p=0,017$). **Considerações finais:** as histórias infantis utilizadas neste estudo foram uma forma de entretenimento sensível e adequada à criança hospitalizada, pois apresentam conteúdos compatíveis com as diferentes faixas etárias, abordando temas relacionados ao contexto hospitalar, que favorecem a participação da criança no seu cuidado e nas relações que permeiam o processo de hospitalização. As

narrativas empregadas demonstraram-se uma potente ferramenta estética, capaz de favorecer o desenvolvimento integral da criança, ao considerar a saúde emocional durante o tratamento de enfermidades físicas. Este estudo convida à reflexão sobre a importância de incorporar, de maneira contínua, intervenções mediadas por histórias infantis no ambiente hospitalar, à medida que amplia o diálogo acerca da presença da beleza e do cuidado sensível no cotidiano do adoecimento infantil.

DESCRITORES: Criança Hospitalizada; Contação de Histórias; Literatura Infantil; Literatura Infantil Digital; Tecnologia Educacional; Tecnologia em Saúde; Estética; Beleza.



ABSTRACT

Introduction: pediatric hospitalization is a context that limits children's opportunities to play. Removed from their family and school environments, children experience impacts on their growth and development, requiring care directed to their illnesses as well as a sensitive perspective toward their needs as beings in the process of development. **Objective:** this study aims to analyze the emotional repercussions of story mediation (digital and printed books) with hospitalized children. **Method:** this multi-method study, developed in three stages, used both qualitative and quantitative data. In stage I, a methodological study was conducted through the following steps: a) problem validity; b) validity of the stories and initial versions of the NaveghiBook application; and c) initial development of the NaveghiBook application. In stage II, a validity study was carried out: the first validity of the NaveghiBook application (prototype I); and validity of the subsequent version (prototype II) in pediatric emergency and inpatient settings. In stage III, an intervention study was conducted with the mediation of stories using physical and digital resources in the Pediatric Clinical Emergency Service and the pediatric inpatient ward of the *Hospital das Clínicas* of *Universidade Federal de Goiás*. In stage III, two intervention groups were conducted, designated as "intervention group I" and "intervention group II". Both intervention groups accessed the same stories in different formats, with physical and digital books. The digital books were made available through the NaveghiBook application. Both interventions were conducted by the principal researcher. The data collection instruments were the Child Drawing: Hospital (CD:H) scale, the faces scale (*Turma da Mônica*), Likert scale, narratives and productions of free and structured drawings made during the interview with children, in addition to notes from participant observation. Qualitative data analysis was performed using Bardin's content analysis technique. For quantitative analysis, an approach based on descriptive and simple inferential statistics was adopted. The results supported six categories, articulated with Vygotsky's theoretical framework. **Results:** the study results showed that mediating children's stories in different formats (digital and physical books) improves anxiety levels in hospitalized children by providing an aesthetic experience that allows for the expression of creativity and imagination, transforming hospital settings into more beautiful and fun environments. At the same time, mediating children's stories fosters human interaction between caregivers, children, mediators, and books, promoting the establishment of bonds and the construction of new empathetic relationships in the context of hospitalization. It was also observed, using the CD:H scale, that the mean anxiety score decreased from 111.17 on the first day to 95.50 on the second day, indicating an overall reduction in anxiety over the period. A paired t-test showed that this difference was statistically significant ($t=3.51$; $p=0.017$). **Final considerations:** the children's stories used in this study were a sensitive and appropriate form of entertainment for hospitalized children, as they presented content compatible with

different age groups, addressing themes related to hospital settings, which encourage child participation in their care and in the relationships that permeate the hospitalization process. The narratives employed proved to be a powerful aesthetic tool, capable of promoting children's full development, considering emotional health during the treatment of physical illnesses. This study invites reflection on the importance of continuously incorporating interventions mediated by children's stories in the hospital environment, as it broadens the dialogue about the presence of beauty and sensitive care in the daily life of childhood illness.

KEYWORDS: Hospitalized Child; Storytelling; Children's Literature; Digital Children's Literature; Educational Technology; Health Technology; Aesthetics; Beauty.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Mapa visual do estudo. Recife, Pernambuco, Brasil, 2025	34
Figura 2 - Participantes do estudo na etapa III e sua participação nas atividades de intervenção propostas.....	37
Figura 3 - Primeira versão do aplicativo NaveghiBook, versão Figma. Recife, Pernambuco, Brasil, 2023.....	144
Figura 4 - Capa dos livros que serão utilizadas no estudo no formato digital disponibilizadas no aplicativo NaveghiBook e em livro físico. Recife, Pernambuco, Brasil, 2025.....	146
Figura 5 - Evolução do aplicativo NaveghiBook: programação do protótipo I (etapa II). Recife, Pernambuco, Brasil, 2023.....	149
Figura 6 - Versão atual do aplicativo NaveghiBook. Recife, Pernambuco, Brasil, 2025.....	153
Figura 7 - Fluxograma das etapas da coleta de dados na intervenção I. Recife, Pernambuco, Brasil 2025.....	41
Figura 8 - Livros com todas as páginas plastificadas e com encadernamento	42
Figura 9 - Livros distribuídos sobre a mesa de atividades utilizada na intervenção I.....	42
Figura 10 - Fluxograma das etapas da coleta de dados na intervenção II. Recife, Pernambuco, Brasil, 2025.....	43
Figura 11 - Dispositivo celular com aplicativo NaveghiBook sobre a mesa de atividades utilizada na intervenção II. Recife, Pernambuco, Brasil, 2025	44
Figura 12 - Escala de faces da Turma da Mônica e escala de Likert em material plastificado	45
Figura 13 - Percurso da coleta de dados	49
Figura 14 - Mapa visual dos resultados.....	54
Figura 15 - Caracterização de crianças participantes: existe beleza em cada história	55
Figura 16 - Hábitos de ler/ouvir histórias infantis.....	56
Figura 17 - Atividade de entretenimento durante a hospitalização e em domicílio	57
Figura 18 - Setor de intervenção.....	58
Figura 19 - Escala de faces	58
Figura 20 - Escala <i>Child Drawing: Hospital</i> comparando o nível de ansiedade dos dois grupos em colunas pareadas após o 1º dia de intervenção	61
Figura 21 - Comparação do nível de ansiedade no 1º dia x 2º dia dos dois grupos	61
Figura 22 - Escala de Likert nos dois grupos de intervenção	63
Figura 23 - Necessidade de auxílio para o uso do aplicativo.....	64
Figura 24 - Comparação entre escolhas de histórias do grupo controle e do grupo experimental	65
Figura 25 - Benjamin Bunny (1º dia/intervenção I).....	69
Figura 26 - Benjamin Bunny (2º dia/intervenção I).....	69
Figura 27 - Tom Kitten (1º dia/intervenção I).....	70
Figura 28 - Tom Kitten (2º dia/intervenção I).....	70
Figura 29 - Peter Rabbit (1º dia/intervenção I).....	70
Figura 30 - Peter Rabbit (2º dia/intervenção I).....	70
Figura 31 - Mrs. Tiggy-Winkle (1º dia/intervenção II).....	71
Figura 32 - Mrs. Tiggy-Winkle (2º dia/intervenção II).....	71

Figura 33 - Samuel Whiskers (1º dia/intervenção II).....	71
Figura 34 - Samuel Whiskers (2º dia/intervenção II).....	71
Figura 35 - Jane (1º dia/intervenção II).....	72
Figura 36 - Jane (2º dia/intervenção II).....	72
Figura 37 - Flopsy (1º dia/intervenção I)	73
Figura 38 - Miss Rose (1º dia/intervenção II).....	73
Figura 39 - Mopsy (1º dia/intervenção I).....	73
Figura 40 - Appley Dapply (1º dia/intervenção II).....	73
Figura 41 - Mrs. Jeremy-Fischer(1º dia/intervenção I).....	74
Figura 42 - Lucinda (1º dia/intervenção II)	73
Figura 43 - Mr. Drake Puddle-Duck.....	73
Figura 44 - Jemina Puddle-Duck.....	73
Figura 45 - Cotton-tail (1º dia/intervenção I).....	75
Figura 46 - Simpkin (1º dia/intervenção I)	74
Figura 47 - Timmy Tiptoes (1º dia/intervenção I).....	75
Figura 48 - Miss Moppet (1º dia/intervenção II).....	74
Figura 49 - Mopsy (grupo de intervenção I)..	75
Figura 50 - Samuel Whiskers (grupo de intervenção II)	76
Figura 51 - Jane (grupo de intervenção II)	78
Figura 52 - Flopsy (intervenção I).....	79
Figura 53 - Cotton-tail (intervenção I).....	79
Figura 54 - Tom Kitten (intervenção I).....	79
Figura 55 - Peter Rabbit (intervenção I).....	80
Figura 56 - Appley Dapply (intervenção II)	80
Figura 57 - Jane (intervenção II)	80
Figura 58 - Timmy Tiptoes (intervenção I).....	82
Figura 59 - Peter Rabbit (intervenção I)	81
Figura 60 - Simpkin (intervenção I)	81
Figura 61 - Mrs. Tiggy-Winkle (intervenção II).....	83
Figura 62 - Benjamin Bunny (intervenção I)	82
Figura 63 - Jane (intervenção II)	83
Figura 64 - Samuel Whiskers (intervenção II).....	84
Figura 65 - Miss Rose (intervenção II)	83
Figura 66 - Miss Moppet (intervenção II).....	85
Figura 67 - Appley Dapply (intervenção II)	84
Figura 68 - Samuel Whiskers (intervenção II).....	85
Figura 69 - Jane (intervenção II)	85
Figura 70 - Mrs. Tiggy-Winkle (intervenção II).....	85
Figura 71 - Mrs. Jeremy-Fischer (intervenção I).....	86
Figura 72 - Peter Rabbit (intervenção I)	87
Figura 73 - Benjamin Bunny (intervenção I)	88
Figura 74 - Jemina Puddle-Duck (intervenção II)	89
Figura 75 - Jemina Puddle-Duck (intervenção II)	90
Figura 76 - Miss Moppet (intervenção II).....	91
Figura 77 - Peter Rabbit (intervenção I)	92
Figura 78 - Miss Rose (intervenção II)	93

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 - Resumo das histórias utilizadas neste estudo.....	148
--	-----

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Estatísticas descritivas dos escores totais da escala <i>Child Drawing: Hospital</i> nos dois dias.....	60
Tabela 2 - Resultado do teste t pareado para os escores totais da escala <i>Child Drawing: Hospital</i>	61
Tabela 3 - Todos os participantes dos dois grupos com a escala <i>Child Drawing: Hospital</i> ...	61

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	16
1.1 Justificativa	19
1.2 Pressuposto teórico/pergunta condutora	20
1.3 Objetivos	21
1.4 Estrutura da tese	21
2 REVISÃO DE LITERATURA	23
2.1 Impactos da hospitalização no desenvolvimento integral da criança	23
2.2 Contação de histórias no contexto do desenvolvimento infantil	25
2.3 Tecnologias educativas com histórias digitais para crianças hospitalizadas	27
2.4 Vygotsky: aprendizagem estética e desenvolvimento infantil	29
3 MÉTODO	33
3.1 Tipo de estudo	33
3.2 Local do estudo	35
3.3 Participantes do estudo	36
3.4 Etapa I. Estudo metodológico: validação do problema, criação de histórias e desenvolvimento inicial do aplicativo NaveghiBook e avaliação inicial	38
3.5 Etapa II: Estudo de validação do aplicativo NaveghiBook	39
3.6 Etapa III. Estudo de intervenção	40
3.6.1 Descrição das intervenções	40
3.7 Coleta de dados	45
3.7.1 Compreendendo os sentimentos e emoções antes e após o uso do aplicativo	45
3.7.2 Entrevista com a criança a partir de método criativo	47
3.7.3 Respostas em desenhos/outras formas de dialogar com a criança	48
3.7.4 Observação participante	48
3.7.5 Diário de campo	49
3.8 Análise de dados	49
3.9 Aspectos éticos e legais	52
4 RESULTADOS	54
4.1 Caracterização da amostra	54
4.2 Caracterização de hábitos da criança hospitalizada	55
4.3 Nível de ansiedade das crianças (escala de faces e <i>Child Drawing: Hospital</i>) durante a hospitalização	58
4.4 Análise de propriedades de multimídia do aplicativo NaveghiBook	62
4.5 Nossas observações vespertinas: análise de aspectos que envolvem o processo de mediação do aplicativo NaveghiBook	66
4.6 Análise comparativa de desenhos da escala <i>Child Drawing: Hospital</i> entre os dois grupos no primeiro dia e segundo dia de intervenções	68
4.7 Desenhos referentes à escala <i>Child Drawing: Hospital</i> : os dois grupos	72
4.8 As histórias do outro e as nossas histórias: um mural de delicadezas	75
4.9 Memórias de um sonho: desenhando os personagens das histórias	79
4.10 A presença do outro: um encontro de ternuras	87
4.11 Encantamento e a beleza na infância: traços de pequenas mãos	90
4.12 Duas formas de mediar histórias: um só encontro	92
4.13 Recontando histórias: inferências das crianças sobre as histórias	94
5 DISCUSSÃO	96
5.1 Um ambiente sociocultural: hospitalização infantil na contemporaneidade	96

5.1.1 Desenvolvimento infantil no período contemporâneo: repercussões para a hospitalização	96
5.1.2 Caminhos para o brincar no hospital se tornar efetivo	100
5.2 Emoções e sentimentos: olhares e percepções infantis sobre o aplicativo	102
5.2.1 Emoções e sentimentos durante a hospitalização infantil	102
5.2.2 Fatores que influenciam o uso do aplicativo para crianças	106
5.3 A arte enquanto ferramenta de comunicação para a criança hospitalizada	111
5.3.1 Desenhos da criança durante a hospitalização: diferentes maneiras de comunicar.....	111
5.3.2 O encontro de si: as histórias dos outros e as nossas histórias	114
5.4 Desenvolvimento infantil e a hospitalização	116
5.4.1 A imaginação e os rabiscos da criatividade.....	116
5.5 O mediador: um encontro de beleza e cuidado	118
5.5.1 A presença enquanto essência do cuidado humano à criança hospitalizada.....	118
5.6 Diálogo entre as diferentes vias de mediar histórias	120
5.6.1 A estética enquanto ferramenta de cuidado à criança hospitalizada.....	120
5.6.2 Diferentes vias para contar histórias: o mediador e a criança	122
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS	125
REFERÊNCIAS.....	130
APÊNDICES	141
APÊNDICE A - Figura 3 - Primeira versão do aplicativo NaveghiBook, versão Figma. Recife, Pernambuco, Brasil, 2023.....	141
APÊNDICE B - Figura 4 - Capa dos livros que serão utilizadas no estudo no formato digital disponibilizadas no aplicativo NaveghiBook e em livro físico. Recife, Pernambuco, Brasil, 2025.....	143
APÊNDICE C - Quadro 1 - Resumo das histórias autorais desenvolvidas para o aplicativo NaveghiBook. Recife, Pernambuco, Brasil, 2025.....	144
APÊNDICE D - Figura 5 - Evolução do aplicativo NaveghiBook: programação do protótipo I (etapa II). Recife, Pernambuco, Brasil, 2023.....	146
APÊNDICE E - Figura 6 - Versão atual do aplicativo NaveghiBook. Recife, Pernambuco, Brasil, 2025.....	150
APÊNDICE F - Roteiro de entrevista para grupo de intervenção II.....	152
APÊNDICE G - Roteiro de entrevista para grupo de intervenção I.....	154
APÊNDICE H - Roteiro da observação participante	156
ANEXOS	158
ANEXO A - Aprovação Comitê de Ética em Pesquisa.....	158
ANEXO B - Child Drawing: Hospital – Versão Brasileira (Campos, F.V. Adaptação cultural do instrumento Child Drawing: Hospital. 199 f. Dissertação. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2018.)	166

1 INTRODUÇÃO

As crianças, durante a hospitalização, vivenciam impactos significativos em seu crescimento e desenvolvimento. Dessa forma, necessitam ser consideradas em sua integralidade. Ao mesmo tempo, torna-se fundamental um olhar sensível que reconheça as suas necessidades emocionais, sociais e cognitivas enquanto sujeitos em pleno processo de desenvolvimento (Ustuner-Top; Cam, 2023).

O processo de hospitalização insere as crianças em um contexto de ruptura de rotinas do seu ambiente domiciliar e social, enfrentando uma diversidade de sentimentos e emoções diante da imprevisibilidade dos desfechos clínicos, o que torna essa vivência ainda mais desafiadora (Ceribelli *et al.*, 2009)

Assim, estratégias de cuidado baseadas nas necessidades das crianças e no seu processo de desenvolvimento podem contribuir de forma mais efetiva para um cuidado humanizado (Aniceto; Bombarda, 2020; Esteves, Antunes, Caires, 2014). A implementação de intervenções lúdicas durante esse período permite que as crianças vivenciem a hospitalização com mais autonomia, favorecendo a compreensão do processo de adoecimento.

Além disso, as intervenções lúdicas podem ajudar as crianças a lidarem com seus sentimentos e emoções¹ durante o processo de adoecimento, contribuindo para o entendimento das ações de cuidado no cenário hospitalar (Godino-láñez *et al.*, 2020). A compreensão da importância da aplicabilidade de estratégias de cuidado lúdicas durante o atendimento pediátrico deve ser considerada uma prática essencial de cuidado.

Ao pensar na capacidade socioemocional da criança, consideramos o seu desenvolvimento integral. Assim como no contexto escolar, é necessário, durante a hospitalização, promover a curiosidade, a imaginação criativa, o interesse artístico, a empatia, a tolerância ao estresse e à frustração, a determinação, a persistência e a assertividade. Todos esses aspectos ajudarão a criança no enfrentamento do processo de adoecimento e na sua formação humana (Brasil, 2018; Instituto Ayrton Senna, 2020).

Nesse sentido, a principal via de aprendizado para a criança é o brincar (Vygotsky, 1999). Através do brincar estruturado, caracterizado como uma atividade

conduzida por um mediador e realizada com ou sem o uso de objetos lúdicos previamente definidos, a criança é orientada a explorar caminhos que favorecem o desenvolvimento cognitivo e emocional. Além disso, esse tipo de brincadeira potencializa o desenvolvimento no contexto relacional, uma vez que possibilita à criança fortalecer vínculos, exercitar habilidades de interação social e consolidar relações interpessoais significativas (Etokabeka, 2024; Medina; Soebel, 2019).

Embora o brincar esteja presente em contextos de hospitalização infantil, através de diferentes práticas, como jogos, brinquedo terapêutico e contação de histórias, há necessidade de investigação sobre a eficácia das diferentes intervenções a partir do olhar da própria criança enquanto sujeito (Aniceto; Bombarda, 2020; Godino-láñez *et al.*, 2020). Diversos impactos da hospitalização têm sido descritos na literatura, como os aspectos relacionados ao bem-estar emocional, especialmente no que se refere ao manejo das emoções¹ e à sua influência sobre a saúde mental.

A partir desses aspectos, acredita-se que uma estratégia potencial para a mediação e qualificação dos cuidados durante a hospitalização é a contação de histórias. A contação de histórias/literatura infantil é uma ferramenta da educação dos sentimentos, sendo considerada por Vygotsky uma ferramenta da arte. Acredita-se que uma via para construir conhecimentos significativos é utilizar ferramentas que proporcionem a estimulação emocional (Vygotsky, 2010).

Vygotsky acredita que todo processo educativo deve conciliar “as potencialidades não só da mente como também dos sentimentos” (Vygotsky, 2010, p. 195). A contação de histórias tem sido relacionada a desfechos satisfatórios no desenvolvimento infantil, como melhora na linguagem, habilidades de letramento e relações de apego entre cuidadores e crianças.

No cenário da hospitalização, esta pode ser uma ferramenta que conecta aspectos emocionais e cognitivos que contribuem para reduzir o medo infantil, potencializando as chances de as crianças desenvolverem resiliência diante das adversidades. O processo de desenvolvimento infantil envolve criar um mundo lúdico, no qual a arte da contação de histórias tem lugar de destaque (Archibaldi *et al.*, 2018)

Ademais, no cenário atual, o uso de recursos educativos mediados pela tecnologia favorece o alcance para outros contextos de atenção à saúde da criança. Esses recursos educativos podem favorecer o seu aprendizado, a qualidade de vida

¹**Emoções:** São respostas afetivas imediatas, expressas por meio de reações psicológicas e fisiológicas, envolvendo alterações corporais, expressões faciais, mudanças autonômicas e impulsos comportamentais.

Sentimentos: São experiências internas, subjetivas e interpretativas, resultantes da forma como o indivíduo atribui significado às próprias vivências emocionais (Cezar; Jucá-Vasconcelos, 2016).

e o bem-estar, respondendo aos desafios dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável em relação à saúde, ao bem-estar e à garantia da educação de qualidade (Nações Unidas, 2018; Reddy *et al.*, 2020)

Nesse sentido, existe a necessidade de observar/escutar a perspectiva das crianças sobre a utilização de tecnologias educativas no cenário do cuidado em saúde. Estudo realizado por Santos *et al.* (2020) aponta que o uso de tecnologias por crianças amplia o universo de possibilidades de aprendizado, principalmente pelo fato de existir, no cenário atual, o uso predominante de celulares, computadores e *tablets*.

Além disso, enfatiza a necessidade da criação de conteúdos e materiais direcionados para cada faixa etária, de modo que esses materiais contribuem para o desenvolvimento da criança, em especial quando o uso dessas tecnologias possui supervisão adequada (Santos *et al.*, 2020).

A contação de histórias é, portanto, uma ferramenta que contribui para a participação ativa da criança, favorecendo a compreensão de diferentes conteúdos e de si mesma, e conduzindo à compreensão dos próprios sentimentos e emoções. Esse aprendizado, mediado pela contação de histórias, inova a dimensão do cuidado, considerando cada criança em sua integralidade (Brondani; Pedro, 2019).

A oportunidade de oferecer às crianças hospitalizadas uma comunicação acessível e lúdica conforme cada faixa etária é um direito da criança. Essa ação corrobora o acesso à informação e ao conhecimento, otimizando a apropriação de sua autonomia durante o processo de cuidado (Suitsu, 2016).

Assim, a nova cultura digital vem atualizando as vias de comunicação. Dessa forma, a intitulada literatura infantil digital surge enquanto ferramenta que utiliza diferentes alternativas tecnológicas para disponibilizar obras com narrativas literárias e poéticas para crianças, e de forma interativa, transmite conteúdos e conhecimentos (Itaú Social, 2020).

No contexto atual, o uso de tecnologias tem sido comum entre o público pediátrico no contexto educacional, possuindo efeitos sobre a relação com outras pessoas e a capacidade motora e criativa, favorecendo o entretenimento, a aquisição e a progressão de habilidades linguísticas (Yadav; Chakraborty, 2022).

Portanto, com um profícuo planejamento, o uso das tecnologias no ambiente educacional parece apontar possibilidades para o seu uso em contextos de cuidado,

havendo a necessidade de investigar a aplicabilidade dessas alternativas na qualificação e humanização da assistência.

1.1 Justificativa

Os resultados desta dissertação nos direcionaram para a necessidade de investigar as potencialidades da contação de histórias, incitando-nos a compreender ainda mais seu caráter estético e pedagógico como ferramenta de ensino e aprendizagem em diferentes contextos (Barros *et al.*, 2024).

Durante o estudo, o processo de ensino e aprendizagem dos estudantes do ensino superior foi mediado pela contação de histórias, que os despertou para o encantamento e a sensibilização em relação à primeira infância, destacando a importância de instantes de beleza como uma necessidade essencial para a saúde e o bem-estar das crianças (Barros *et al.*, 2024).

Dessa forma, o presente estudo reconhece o papel pedagógico da contação de histórias, evidenciando a necessidade de um viés investigativo sobre a contação de histórias enquanto ferramenta para o bem-estar das crianças hospitalizadas. Isso ocorre especialmente no que se refere à necessidade de compreensão da função da contação de histórias/literatura infantil nos aspectos linguísticos e suas disposições ilustrativas, além de sua capacidade de modelar a saúde emocional infantil.

Outro aspecto relevante evidenciado na experiência prática vivida durante a coleta de dados da dissertação foi a limitação de alguns cenários clínicos, que impossibilitaram a contação de histórias com crianças, utilizando livros físicos, pois as crianças que estavam isoladas em enfermarias para precaução de contato não foram visitadas, devido ao risco de infecção cruzada ao manusear ou tocar os livros de papel. Essa situação vivenciada nos despertou também para a reflexão sobre a construção de ferramentas alternativas que pudessem nos ajudar na mediação da contação de histórias considerando essas especificidades.

Em março de 2023, de forma colaborativa, com outra doutoranda e um acadêmico de medicina, participamos do programa *Campus Mobile*, que é um concurso de ideias e soluções para *mobile*. No programa, construímos o aplicativo

NaveghiBook, que foi criado para ser utilizado por crianças hospitalizadas. Por meio dele, as crianças poderão acessar histórias infantis que abordam o contexto da hospitalização, fortalecendo seu conhecimento sobre si mesmas, o autocuidado e a autonomia, e reduzindo o estresse e melhorando o enfrentamento da hospitalização. Somado a isso, levamos também a beleza através das histórias que abordam temáticas sobre saúde, esperança, sentimentos e emoções.

Embora o uso de tecnologias por crianças esteja cada vez mais presente no cotidiano, exige-se diligência, pois o acesso precoce e sem orientação pode expô-las a conteúdos inadequados, riscos à privacidade, estímulos excessivos e impactos no desenvolvimento socioemocional (Haidt, 2024).

Nesse sentido, torna-se fundamental a presença de um supervisor responsável, de uma curadoria de conteúdos e de limites bem definidos, para que as experiências digitais sejam mais seguras e correspondam a aspectos de cada faixa etária. Portanto, quando adequadamente planejados, os aplicativos para o público infantil podem oferecer benefícios significativos, favorecendo a aprendizagem, a criatividade e o desenvolvimento de habilidades cognitivas e sociais, desde que utilizados de forma intencional e supervisionada.

Dessa forma, esta tese de doutorado tem como propósito compreender as repercussões emocionais do aplicativo NaveghiBook, no contexto da contação de histórias em meio digital, a partir do olhar da própria criança hospitalizada. Para isso, optou-se por descrever o processo de criação e validação do aplicativo e, na etapa final, com estudo de intervenção, compreender os apontamentos que surgiram a partir do uso de histórias em livros físicos e histórias infantis digitais através do aplicativo.

1.2 Pressuposto teórico/pergunta condutora

O livro infantil (digital e físico), através de suas ferramentas de educação estética², melhora os aspectos emocionais de crianças hospitalizadas. A pergunta condutora foi: quais as repercussões da mediação de histórias (físicas e digitais) nos aspectos emocionais de crianças hospitalizadas?

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo geral:

- ❖ Analisar as repercussões emocionais da mediação de histórias (digitais e com livros físicos) de crianças hospitalizadas.

1.3.2 Objetivos específicos:

- ❖ Avaliar o nível de ansiedade da criança hospitalizada a partir da escala *Child Drawing: Hospital* (CD:H);
- ❖ Descrever as emoções e sentimentos das crianças em cenário de hospitalização sobre a contação de histórias mediadas pelo aplicativo NaveghiBook e livros físicos;
- ❖ Identificar as percepções das crianças sobre a sua participação ativa no processo de cuidado a partir da contação de histórias mediadas pelo aplicativo NaveghiBook;
- ❖ Comparar as percepções das crianças hospitalizadas no que se refere aos seus sentimentos e emoções antes e depois da contação de histórias mediada pelo aplicativo NaveghiBook em relação ao livro físico tradicional.

1.4 Estrutura da tese

A tese compreende os seguintes capítulos: “Introdução”, “Revisão de literatura e referencial teórico”, “Percurso metodológico”, “Resultados”, “Discussão” e “Considerações finais”. No capítulo um, realizamos uma introdução sobre a temática do estudo. Em seguida, no capítulo dois, foi apresentada uma revisão de literatura com uma abordagem contendo evidências sobre o impacto da hospitalização no desenvolvimento integral da criança, apontamentos a respeito da contação de histórias no desenvolvimento infantil e delineamentos sobre o uso de tecnologias com histórias digitais para crianças hospitalizadas. Por fim, no último tópico da revisão, tecemos alguns aspectos da teoria de Vygotsky que dialogam com nosso objeto de

²**Educação estética:** “conjunto de experiências educativas intencionalmente organizadas com o propósito de estimular vivências atravessadas pelas dimensões afetivas de percepção, expressão e criação artísticas.”(Silva;Pulino, 2023, p.1)

estudo. O capítulo três contém o percurso metodológico, com o tipo de estudo, a caracterização do cenário e participantes do estudo, a descrição das três etapas realizadas, um tópico sobre coleta de dados, análise de dados e os aspectos éticos do estudo.

O capítulo quatro contém os resultados da pesquisa. O capítulo cinco traz a discussão, sendo dividido em seis categorias, que foram articuladas ao referencial teórico de Vygotsky. Por fim, as considerações finais do estudo são apresentadas no capítulo seis.

2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1 Impactos da hospitalização no desenvolvimento integral da criança

A vivência da hospitalização durante a infância é um processo complexo. A criança durante a hospitalização precisa se adaptar ao novo contexto e realidade. Neste espaço, afasta-se da convivência comunitária, escolar e parental, solicitando da criança um processo adaptativo no que se refere às relações interpessoais, à estrutura física e à estrutura organizacional (Morais; Costa, 2017; Barros, 1998).

Nesse novo ambiente, a criança precisará ser submetida a exames laboratoriais e avaliações de condição física. Os estímulos aos quais ela será exposta e vivenciará repercutirão em seu desenvolvimento de forma integral (Pereira; Rolim, 2022). O adoecimento na infância pode comprometer o crescimento e desenvolvimento infantil, tendo em vista o rápido processo de maturação ao longo da infância. A ausência de experiências próprias desse período pode interferir no aperfeiçoamento e formação de funções motoras, socioemocionais, cognitivas e de linguagem (Morais; Costa, 2017).

A hospitalização afeta também o contexto familiar, tendo em vista que existirá a necessidade de acompanhamento da criança por um dos cuidadores. Esse fato repercute em diversos âmbitos, como emocionais, físicos e financeiros, e, consequentemente, no próprio cuidado à criança (Rodrigues, Fernandes, Marques, 2020; Barros, 1998).

Os sentimentos e as emoções dos familiares podem gerar repercussões na forma como a criança irá responder às intervenções de cuidado e no próprio enfrentamento do processo de adoecimento. Os cuidadores têm papel essencial no apoio e suporte emocional durante o internamento (Rodrigues, Fernandes, Marques, 2020; Barros, 1998).

Eles podem também ser mediadores da comunicação entre crianças e profissionais, contribuindo neste cuidado que deve ser centrado na criança. Ademais, podem corroborar informando a respeito das características específicas da criança e suas individualidades, a fim de otimizar a qualidade da assistência oferecida (Morais; Costa, 2017).

Entretanto, não se pode esquecer que, no cuidado centrado na criança, a comunicação deve permitir que elas tenham conhecimentos e informações adequados à sua idade e desenvolvimento, para que possam participar, de forma acessível, do exercício de sua autonomia (Warren, 2019).

O uso de ferramentas pelos profissionais de saúde para melhorar o diálogo e mediar o conhecimento sobre o adoecimento e a respeito da própria hospitalização infantil, por meio de uma linguagem apropriada e recursos lúdicos, é uma das formas de tornar esse processo menos traumático (Pereira; Rolim, 2022; Silva, 2010).

Conforme o desenvolvimento, cada criança, de forma individual, compreende o contexto no qual está inserida. Dessa forma, são diferentes as experiências e vivências durante esse período (Pereira; Rolim, 2022; Silva, 2010). As crianças tendem a ter dificuldade em entender o processo de adoecimento e as intervenções às quais serão submetidas, sendo necessário um planejamento adequado em relação às ações de cuidado e tratamento.

O uso de ferramentas que favoreçam o desenvolvimento motor, socioemocional, cognitivo e linguagem durante a hospitalização é essencial, pois tornará o ambiente de cuidado e intervenção em cenário de promoção da saúde, sendo o lúdico a via principal para a mediação e o alcance de um cuidado integral à criança hospitalizada (Pereira; Rolim, 2022).

A hospitalização infantil ocasiona alterações nos sentimentos e emoções, assim como pode interferir na realização de atividades físicas, motoras e escolares, gerando impactos no desenvolvimento da criança. Esse conhecimento é essencial para direcionar intervenções específicas para esse público no cenário hospitalar.

A criança hospitalizada solicita cuidados de saúde para otimizar a melhora clínica e qualidade de vida durante esse período. Entretanto, suas necessidades específicas da infância relacionadas ao próprio processo de desenvolvimento devem existir dentro do plano de cuidados, pois, afinal, ela continua sendo criança.

2.2 Contação de histórias no contexto do desenvolvimento infantil

Na primeira infância, a contação de histórias é uma ferramenta milenar de transmissão de conhecimentos que, durante anos, foi muito utilizada como meio para transmissão de costumes e práticas culturais, servindo para divulgar eventos e fatos históricos (Brasil, 2021).

Por anos, contribuiu para a formação humana, sendo os livros fonte de registros para as descobertas e dados científicos. O conhecimento de diferentes áreas e até mesmo o conhecimento empírico teve como ferramenta de armazenamento e disseminação o livro físico (Brasil, 2021).

A contação de histórias permite que a criança entre em contato com o vocabulário e diversos conhecimentos sobre a vida, a cultura, a natureza, elementos mágicos e espaciais, desenvolvendo sua parte neurolinguística e cognitiva (Brasil, 2021; SBP, 2015). Ao ouvir uma história, pode relacionar as narrações às suas próprias experiências, sentimentos e emoções. Isso facilita o processo de identificação e empatia com os personagens, através do que chamamos de “espelhos”, pois verá sua realidade refletida na história, e isso permitirá a compreensão e a resolução de conflitos subjetivos (Melo *et al.*, 2020; Peres; Naves; Borges, 2018).

Outro aspecto importante para o desenvolvimento infantil mediado pela contação de histórias é o estímulo à imaginação e à criatividade. A contação de histórias utiliza o lúdico para fazer as crianças viajarem pelo mundo da fantasia e da ficção. Essas habilidades são essenciais para o aprendizado e para a vida adulta (Peres; Naves; Borges, 2018; Brasil, 2021).

Ao folhear os livros, a criança desenvolve a coordenação motora, pois utiliza habilidades manuais e entra em contato com diferentes texturas. Da mesma forma, ela pode ser estimulada a realizar tarefas práticas no cotidiano. Além disso, o desenvolvimento dessa habilidade amplia-se quando ocorre, de forma simultânea, o uso do brinquedo terapêutico (Souza, 2014; Felício; Seabra Junior; Rodrigues, 2019).

Através da contação de histórias, a criança é inserida no universo das palavras, tendo contato com um novo vocabulário a cada história. Dessa forma, poderá aumentar seu repertório linguístico e desenvolver aspectos da comunicação oral e

escrita. Com o seu crescimento, terá mais facilidade em realizar os diferentes tipos de leitura (Araujo; Sperb; Bitencourt, 2016; Simões, 2000).

Livros são, simultaneamente, fontes de conhecimento e entretenimento para as crianças, ao passo que possuem conteúdo relevante e informativo. Em segundo plano, apresentam a característica de “janelas”, ampliando os horizontes da imaginação e da criatividade (SBP, 2015). As histórias, com suas narrativas, geram repercussões reflexivas a respeito dos fatos descritos, permitindo que a criança realize interpretações, questionamentos, hipóteses e, a partir disso, crie suas próprias inferências, reconstruindo/inventando suas próprias histórias (Cedac, 2018).

A contação de histórias favorece a relação interpessoal, fortalecendo vínculos entre as crianças e os cuidadores/familiares. Essa relação de afeto é essencial para o desenvolvimento da competência emocional, pois ajuda a criança a experimentar sentimentos e emoções que envolvem o processo de compreensão de si e do outro (SBP, 2015).

A Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) (2015) utiliza uma frase de Rubem Alves que diz: “Um livro é um brinquedo feito com letras. Ler é brincar”. Através dessa frase, o autor resume a importância da contação de história enquanto ferramenta que contribui para o neurodesenvolvimento e descreve que colaborar com a disseminação de histórias para crianças é garantir um direito, em especial, na primeira infância.

A SBP (2015) elenca alguns benefícios da prática de ler para crianças:

- Fortalece o vínculo com quem lê para a criança, como pais e outros familiares;
- Desenvolve a atenção, a concentração, o vocabulário, a memória e o raciocínio;
- Estimula a curiosidade, a imaginação e a criatividade;
- Ajuda a criança a perceber e a lidar com os sentimentos e as emoções;
- Possibilita à criança conhecer mais sobre o mundo e as pessoas;
- Favorece a aquisição do hábito de ouvir e ler histórias;
- Auxilia no desenvolvimento da empatia (a capacidade de colocar-se no lugar do outro);
- Desenvolve a extroversão, a amabilidade e a conscienciosidade (autoeficácia);

- Ajuda a minimizar problemas comportamentais, como agressividade, hiperatividade e comportamento arredo;
- Auxilia na boa qualidade do sono;
- Desenvolve a linguagem oral. (SBP, 2015, p. 13)

O contato com livros e a literatura infantil potencializa a capacidade de formação e desenvolvimento das crianças em diversos aspectos, sendo uma ferramenta versátil que pode ser utilizada em vários cenários, como pedagógicos, hospitalares e domiciliares.

2.3 Tecnologias educativas com histórias digitais para crianças hospitalizadas

O uso de tecnologias na saúde ganhou espaço no cenário nacional, sendo alvo de estudos nos centros de pesquisa para garantir a otimização da qualidade do cuidado e da assistência em saúde. A implementação de tecnologia ampliou o universo de possibilidades na gestão em saúde e o redirecionamento do planejamento de políticas públicas de saúde (Novaes; De Soárez, 2020).

No cuidado à criança hospitalizada, as tecnologias têm se tornado uma ferramenta complementar que favorece e amplia as alternativas lúdicas para uma assistência humanizada. Em revisão sistemática, evidenciou-se que interações mediadas por robôs produzem interação e engajamento por parte de crianças hospitalizadas, favorecendo a realização de procedimentos e a compreensão a respeito de diversos processos que envolvem o adoecimento infantil (Triantafyllidis *et al.*, 2023).

O uso dessas ferramentas também ajudou alcançar metas clínicas estabelecidas, diminuindo os índices de ansiedade e de sofrimento, favorecendo a qualidade da saúde mental das crianças durante a hospitalização (Triantafyllidis *et al.*, 2023).

A intervenção “*Child Life*” obteve resultados positivos nos sintomas de dor, ansiedade, fadiga e distúrbios do sono em crianças com leucemia aguda submetidas à quimioterapia. O programa utilizou múltiplas ferramentas lúdicas e tecnológicas para

mediar o diálogo e favorecer o entendimento das crianças a respeito do processo de hospitalização (Li *et al.*, 2023).

As intervenções foram organizadas por uma equipe multiprofissional que foi previamente treinada para aplicar um conjunto de intervenções de forma paulatina durante o internamento infantil. Foram utilizados bonecos e a narração em áudio/vídeo de eventos/procedimentos, visando inserir as crianças em contextos que seriam posteriormente experienciados. Desse modo, antecipou-se o preparo emocional e cognitivo das crianças através da narração e simulação das funções profissionais a respeito de eventos reais de cuidado (Li *et al.*, 2023).

As tecnologias surgem como ferramentas complementares no cenário assistencial para o público pediátrico. Efeitos significativos são produzidos por essa ferramenta: interações mediadas por um robô humanoide favorecem o bem-estar de crianças hospitalizadas na clínica pediátrica; e a distração e o envolvimento melhoram o humor das crianças, melhorando a qualidade de sua saúde mental. Este estudo aponta a necessidade de mais pesquisas para investigar a respeito do uso de tecnologias (Beyer-Wunsch; Reichstein, 2020).

O uso de ferramentas tecnológicas para mediar a comunicação com a criança em contextos hospitalares tem favorecido a relação profissional-paciente. O uso de *smartphones* otimizou o oferecimento de histórias e canções a crianças hospitalizadas em uma Unidade de Terapia Intensiva, gerando na criança uma fisionomia de alegria após esse tipo de intervenção lúdica (Sabeti *et al.*, 2021).

A contação de histórias pode ser uma via alternativa para um cuidado sensível para crianças hospitalizadas, através das histórias as crianças podem ser inseridas em contextos reais que envolvem o processo de adoecimento e hospitalização, com isso, tornam-se capazes de elaborar suas reações previamente e, dessa maneira, viverem melhor cada situação (Sekhavatpour *et al.*, 2019).

Sabeti *et al.* (2021) evidenciaram que, após uma intervenção inicial utilizando a contação de histórias, as crianças se mostram mais colaborativas nos cuidados subsequentes. Essas medidas lúdicas, aliadas a tecnologias educativas, contribuem para o tratamento da dor, reduzindo a ansiedade, o estresse, o medo e a insegurança das crianças e fornecendo a elas conhecimento e autonomia no contexto do cuidado (Sekhavatpour *et al.*, 2019).

O ato de ouvir e contar histórias é uma via que permite a participação criativa e ativa das crianças no cenário de cuidado (Wilson *et al.*, 2010). Essa possibilidade favorece o respeito pela criança em sua essência. Com base nesse entendimento, o uso de ferramentas tecnológicas que auxiliem o cuidado com a saúde tem se popularizado cada vez mais no cenário mundial, principalmente devido ao avanço das tecnologias e à sua capacidade adaptativa nos mais diferentes contextos (Strauss *et al.*, 2022).

Entretanto, apesar dos avanços, fazem-se necessários estudos que ajudem a compreender melhor a eficácia do uso dessas tecnologias em diferentes contextos, suas implicações e impactos na saúde sob a perspectiva de profissionais e usuários (Strauss *et al.*, 2022).

A utilização de recursos tecnológicos no processo de mediação de diálogo e comunicação com crianças tem mostrado eficazes resultados, pois evidencia que o uso de recursos ilustrados e audiovisuais estimula a expressão de sentimentos e desejos. Isso ocorre porque eles se apropriam de uma linguagem lúdica, capaz de mediar diálogos acessíveis e interativos, considerando as individualidades do público infantil (Pérez, 2022).

2.4 Vygotsky: aprendizagem estética e desenvolvimento infantil

O meio em que a criança vive exerce papel essencial em seu desenvolvimento biológico, físico, cognitivo e emocional, uma vez que, na perspectiva sociocultural, é nas interações sociais mediadas que se produzem os sentidos e os significados que repercutem no desenvolvimento infantil (Vygotsky, 1991). Com base nesse entendimento, Vygotsky (2014, p. 25) descreve que: “O que a criança vê e ouve constitui desse modo os primeiros pontos de apoio para a sua criatividade futura. A criança acumula material a partir do qual, posteriormente, irá construir suas fantasias.”

Para Vygotsky, é necessário compreender o mundo que envolve cada criança e colaborar para a construção de novos espaços que otimizem o processo de desenvolvimento, pois a capacidade individual de cada um repercutirá tanto individualmente quanto coletivamente na sociedade (Vygotsky, 2010).

Cada criança viverá sua experiência de forma pessoal, e suas ações podem impactar o contexto social em que está inserida. Ao mesmo tempo, a educação é uma via de aperfeiçoamento humano que é favorecida/influenciada por todos os indivíduos que estão no meio (Vygotsky, 2010).

Dessa maneira, ao pensar no desenvolvimento infantil em um contexto colaborativo e na importância da mediação durante o desenvolvimento infantil, Vygotsky descreve:

O aprendizado desperta vários processos internos de desenvolvimento que são capazes de operar somente quando a criança interage com pessoas e seu ambiente e quando em cooperação com seus companheiros. Uma vez internalizados, esses processos tornam-se parte das aquisições do desenvolvimento independente das crianças (Vygotsky, 1991, p. 60).

Para Vygotsky, as reações emocionais geradas, criadas ou mediadas pelo meio podem contribuir para a construção pessoal de cada ser. Sobretudo, ele enfatiza que os sentimentos e emoções possuem papel fundamental no processo de construção desses conhecimentos (Vygotsky, 2010).

Dessa maneira, ele destaca que a arte é uma ferramenta multifacetada que pode ajudar no desenvolvimento infantil de diferentes maneiras (Vygotsky, 2010). A arte, em suas diferentes formas, expressa-se através da estética, sendo este um elemento facilitador no processo de ensino e aprendizagem, pois direciona a um aprendizado que permite a contemplação da beleza e o despertar de sentimentos/emoções, conduzindo para a compreensão de aspectos emocionais e de conhecimentos (Vygotsky, 2010).

Sob a perspectiva de Vygotsky, a educação estética desempenha um papel essencial no aprimoramento emocional, cognitivo e social das crianças. Vygotsky (2010) sugere que as experiências estéticas favorecem a criatividade, a imaginação e os aspectos emocionais durante o desenvolvimento infantil.

Referindo-se ao papel da criação literária enquanto via que direciona a criança para a imaginação criativa, Vygotsky (2014, p. 85) descreve que “seu significado reside no fato de que permite à criança, ao exercitar seus impulsos e hábitos criativos, dominar a linguagem humana, ferramenta mais sutil e complexa para formular e transmitir pensamentos humanos, seus sentimentos, o mundo interior do homem.”

Para Vygotsky, a intenção principal da arte não é apenas “distrair os nossos sentimentos” (2010, p. 333), mas também “a arte não é uma complementação da vida mas decorre daquilo que no homem é superior à vida” (2010, p. 340). Ao descrever que “o cântico cura o espírito doente”, ele se refere à arte como via de remediação para a alma (2010, p. 340). Dessa maneira, inferimos que a arte deve estar presente em nossas vidas continuamente, pois seus efeitos acontecem no íntimo da subjetividade humana, direcionando-nos a viver o hoje e a construir o futuro.

De acordo com Vygotsky (2010), a experiência estética exerce um papel organizador sobre o comportamento humano, produzindo transformações perceptíveis no estado emocional e na expressão subjetiva do indivíduo. O autor exemplifica essa influência ao afirmar que é possível identificar, pela atitude de uma pessoa ao sair de um concerto: “Pela maneira como uma pessoa sai de um concerto sempre se pode dizer se ela ouviu Beethoven ou Chopin” (Vygotsky, 2010, p. 343). Ele evidenciou que diferentes obras artísticas mobilizam disposições afetivas distintas.

Nesse sentido, o vivenciar da arte opera como um processo de elaboração interna. Ao “expulsar e libertar forças interiores hostis ao organismo” (Vygotsky, 2010, p. 344), promove-se uma forma de resolução de conflitos psicológicos e de reorganização das tensões internas (Vygotsky, 2010).

No ambiente hospitalar, as crianças possuem suas interações limitadas/comprometidas. Esse ambiente afasta as crianças do convívio familiar e escolar. A rotina de hospitalização é permeada por eventos que geram dor, medo e ansiedade, de modo que essa experiência repercute diretamente no desenvolvimento de habilidades cognitivas, emocionais e sociais (Dourado *et al.*, 2022).

Durante a hospitalização, o processo de comunicação e expressão de sentimentos é afetado, impactando diretamente o vivenciamento do processo de adoecimento. O uso de recursos lúdicos permite que a criança estabeleça diálogos com seus próprios sentimentos e emoções, contribuindo para uma melhor compreensão de seu adoecimento. Ambientes conectados à imaginação e à criatividade favorecem uma melhor vivência da hospitalização infantil (Pinto; Müller; Broering, 2022).

Os sentimentos gerados pela vivência estética por meio da literatura infantil evidenciam seu potencial de atuar na educação estética durante o desenvolvimento

infantil, agindo por meio da “dupla expressão”, na qual a criança é direcionada a transformar de forma criativa o contexto em que vive (criatividade), impregnando a realidade de sentimentos e emoções que geram significados práticos no cotidiano (emoções) (Vygotsky, 2010).

O despertar da dimensão criativa e emocional durante o desenvolvimento infantil permite que a criança experimente pequenos recortes de situações que encontrará na vida, de modo que o estilo imaginativo e fantástico, mediado através das histórias infantis, pode colaborar para a formação de significados (Vygotsky, 2010).

O uso de ferramentas da arte aumenta potencialmente as chances da criança de ampliar as possibilidades de aprendizagem, pois uma diversidade de recursos durante a formação/aperfeiçoamento de habilidades pessoais e sociais favorece o conhecimento de si e a integração com os pares (Zhang, 2022).

Assim, a contação de histórias, enquanto ferramenta da arte, favorece o desenvolvimento infantil, permitindo que cada criança explore universos estéticos que impulsionem a socialização, a competência cognitiva e emocional, ampliando a possibilidade de raciocínio e criatividade na infância, por meio de elementos textuais e ilustrativos que atuam no fortalecimento de habilidades (Cremin *et al.*, 2016).

3 MÉTODO

3.1 Tipo de estudo

Trata-se de estudo multimétodo, desenvolvido em três etapas, com abordagem qualitativa-quantitativa. Os autores, Kasirye (2021) e Seawright (2016), descrevem que o estudo multimétodo pode envolver o uso de mais de um método qualitativo e/ou diferentes métodos quantitativos, favorecendo a observação e a compreensão de perspectivas em um mesmo estudo. Os estudos são conduzidos de forma articulada, e seus resultados são triangulados para compor um quadro mais completo do fenômeno investigado. Estudos dessa natureza permitem compreender as pesquisas de outros autores e também consolidar os próprios achados (Kasirye, 2021; Seawright, 2016).

Destaca-se que este estudo está ancorado em revisão integrativa de literatura (Apêndice A). Desse modo, a pesquisa foi organizada em três etapas:

1 - Estudo metodológico (etapa I): validação do problema, criação de histórias, desenvolvimento inicial do aplicativo NaveghiBook e avaliação inicial.

Polit e Beck (2019) descrevem que a pesquisa metodológica pode ser chamada de estudo de desenvolvimento metodológico ou estudos de validação. Ao se referirem às investigações dos métodos de obtenção, organização e análise de dados, consideram também a elaboração, a validação e a avaliação de instrumentos, além de técnicas de pesquisa, objetivando a construção de um instrumento confiável, preciso e utilizável, que possa ser empregado por outros pesquisadores (Polit; Beck, 2019). Polit e Beck (2019) recomendam a organização estudo da seguinte maneira:

A - Desenvolvimento, produção, construção de ferramentas: validação do problema, criação de histórias e desenvolvimento inicial de telas do aplicativo NaveghiBook.

B - Validação: primeira validação do aplicativo NaveghiBook: validações das histórias e de versões iniciais do aplicativo NaveghiBook para teste em contextos de emergência pediátrica do Hospital da Restauração (HR) e enfermaria pediátrica do

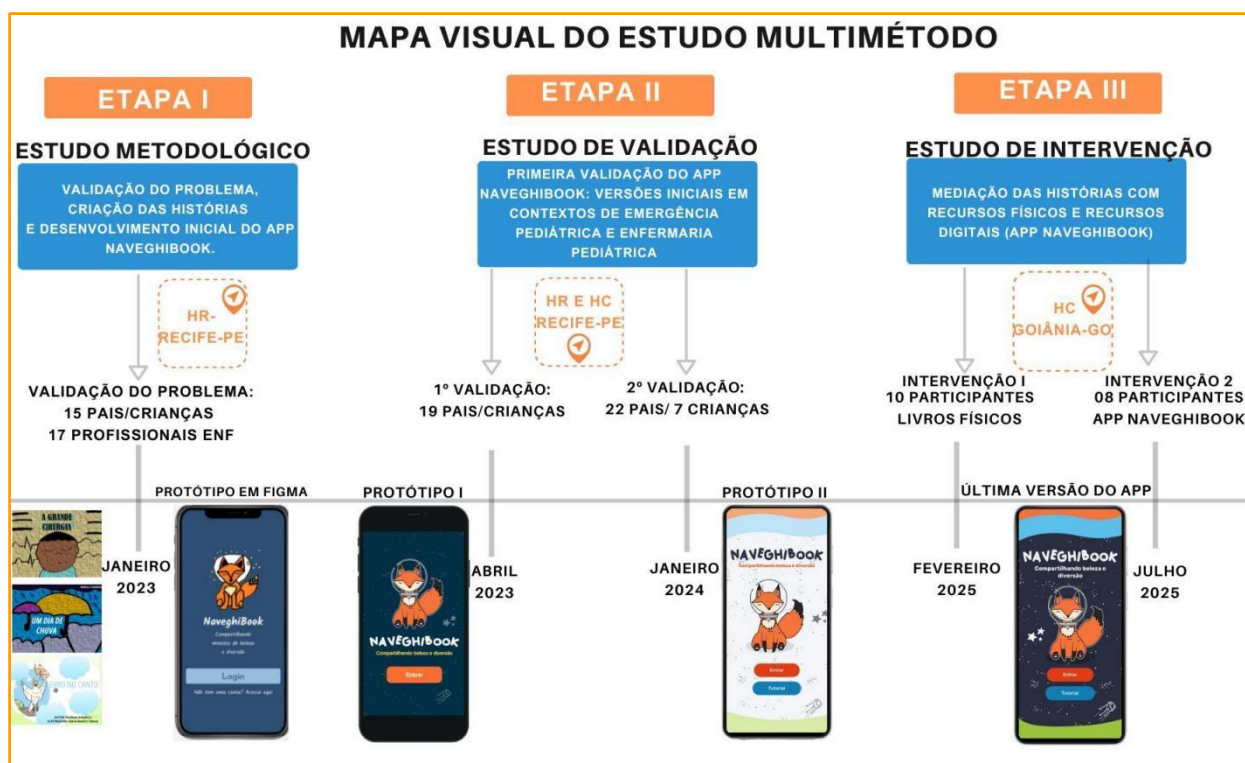
Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco, ambos na cidade de Recife, Pernambuco, Brasil.

C - Avaliação e/ou aplicação: uso do protótipo em Figma em contextos de emergência pediátrica do HR e enfermaria pediátrica do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco, ambos na cidade de Recife, Pernambuco, Brasil.

2 - Estudo de validação (etapa II): primeira validação do aplicativo NaveghiBook, com versões iniciais em contextos de emergência pediátrica do HR e enfermaria pediátrica do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco, ambos na cidade de Recife, Pernambuco, Brasil.

3 - Estudo de intervenção (etapa III): intervenção com mediação das histórias com recursos físicos e recursos digitais no Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Goiás, em Goiânia, Goiás, Brasil. Com o objetivo de apresentar de forma clara os procedimentos adotados neste estudo, elaborou-se a figura a seguir:

Figura 1 - Mapa visual do estudo. Recife, Pernambuco, Brasil, 2025



Fonte: elaborada pela autora (2025).

3.2 Local do estudo

As etapas I e II foram realizadas na emergência pediátrica do HR Governador Paulo Guerra, referência no atendimento a crianças de 0 a 13 anos, 11 meses e 29 dias em situação de emergência. O serviço possui 38 leitos e oferece assistência de média e alta complexidade, referenciado e regulado na rede de saúde no estado de Pernambuco. As especialidades de atendimento são traumatologia, pediatria, neurocirurgia, ortopedia, toxicologia, cirurgia pediátrica, oftalmologia, endoscopia e cirurgia bucomaxilofacial.

A enfermaria pediátrica do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco também foi cenário e local onde foram realizadas validações do aplicativo NaveghiBook. Durante as etapas I e II, a unidade é responsável pelos atendimentos pediátricos no Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco. São classificados como pacientes pediátricos indivíduos de 0 a 17 anos, 11 meses e 29 dias de idade. A unidade possui 30 leitos e está localizada no sexto andar do prédio, setor sul. Atende inúmeras especialidades, como cardiologia, neurologia, dermatologia, pneumologia, endocrinologia, nefrologia, hematologia, gastroenterologia e neurocirurgia.

A etapa III do presente estudo foi realizada no Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Goiás, que é administrado pela Empresa Brasileira de Serviço Hospitalares. Esse hospital é uma instituição de caráter público localizada em Goiânia, Goiás. A pesquisa foi realizada no Setor de Enfermaria Clínica Pediátrica e no Setor de Urgência Pediátrica (SERUPE), vinculados à Unidade de Pediatria (UNIPED).

Esta unidade é responsável pelos atendimentos em pediatria no Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Goiás, classificando indivíduos de 0 a 17 anos, 11 meses de idade e 29 dias como pacientes pediátricos. A UNIPED é formada por diferentes setores que englobam várias especialidades, nomeadamente Enfermaria Clínica Pediátrica, SERUPE, Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica e Unidade de Terapia Intensiva Neonatal.

O Setor de Enfermaria Clínica Pediátrica e SERUPE, escolhidos como locais do estudo, funcionam em um mesmo espaço físico no 11º andar do Hospital das Clínicas

da Universidade Federal de Goiás, contabilizando 21 leitos. A divisão das enfermarias é realizada de acordo com a demanda de internamentos e o perfil dos usuários.

As unidades atendem diversas especialidades pediátricas, nomeadamente cardiologia, neurologia, dermatologia, pneumologia, endocrinologia, otorrinolaringologia, nefrologia, hematologia, gastroenterologia e neurocirurgia.

O Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Goiás dispõe de uma brinquedoteca no Setor de Enfermaria Clínica Pediátrica. A sala não funciona em tempo integral, contando com a presença de uma pedagoga às terças e quintas-feiras, no período da tarde. A brinquedoteca é destinada apenas às crianças desse setor. A unidade também é utilizada ocasionalmente por estudantes ou psicólogos durante atividades de intervenção.

Todas as crianças, das três etapas do estudo, foram abordadas e entrevistadas na beira do leito em suas respectivas enfermarias ou alas de internação.

3.3 Participantes do estudo

Na etapa I, onde ocorreu a validação do problema, participaram 15 pais, 15 crianças e 17 profissionais da equipe de enfermagem, sendo enfermeiros e técnicos de enfermagem. A maior parte dos cuidadores entrevistados era composta por mães com idade de 20 a menos de 50 anos. Já as crianças se encontravam na faixa etária de 6 a 10 anos. Os dados da etapa I foram coletados de janeiro a março de 2023.

Os participantes da etapa II incluíram, inicialmente, 19 pais e suas crianças para avaliação do protótipo I. Na segunda validação, referente ao protótipo II, participaram 22 pais e sete crianças, permitindo comparar a evolução e os ajustes realizados entre as duas versões do protótipo. Nessa etapa, as crianças também se encontravam na faixa etária de 6 a 10 anos. Os dados da etapa II foram coletados de abril de 2023 a janeiro de 2024.

Os participantes na etapa III foram 18 crianças de 6 a 10 anos de idade, sendo dez crianças do grupo de intervenção I e oito crianças do grupo de intervenção II, internadas no Setor de Clínica Pediátrica e SERUPE. Dos 18 participantes, apenas seis crianças concluíram as atividades propostas no primeiro e no segundo dia de

intervenção, distribuídas igualmente entre os grupos de intervenção I (n=3) e intervenção II (n=3), conforme ilustrado na Figura 2:

Figura 2 - Participantes do estudo na etapa III e sua participação nas atividades de intervenção propostas



Fonte: elaborada pela autora (2025).

Os dados da etapa III foram coletados de fevereiro a julho de 2025. O grupo de intervenção II recebeu como intervenção a contação de histórias, mediada pelo aplicativo NaveghiBook, e o grupo de intervenção I recebeu como intervenção a contação de história no formato tradicional, mediado pela pesquisadora principal, usando livros físicos. Os dois grupos tiveram acesso às mesmas histórias (Figura 4 em Apêndice B).

Foram considerados os seguintes critérios para inclusão dos participantes:

- Critérios de inclusão:

- Crianças com idade entre 6 e 10 anos;

- Critérios de exclusão:

- Limitação referida pelo cuidador ou pela criança que inviabilizasse a mediação do aplicativo ou contação de história pela pesquisadora;
- Comprometimentos físicos ou mentais que dificultassem a aplicação da escala CD:H ou a realização da entrevista.

3.4 Etapa I. Estudo metodológico: validação do problema, criação de histórias e desenvolvimento inicial do aplicativo NaveghiBook e avaliação inicial

3.4.1 - Desenvolvimento, produção, construção de ferramentas: as contribuições dos participantes nesta etapa revelaram dificuldades enfrentadas na hospitalização infantil. Os pais destacaram o sofrimento dos filhos, a falta de entretenimento e as dificuldades na comunicação com os profissionais de saúde. A partir desses relatos, criamos histórias baseadas nas experiências das crianças, em realidades observadas e no anseio de proporcionar beleza e diversão durante o adoecimento infantil. Nossas histórias abordam temas e desafios vivenciados durante a hospitalização, com foco no crescimento, no desenvolvimento e nos aspectos emocionais da criança.

Essas contribuições foram essenciais para a construção do esboço inicial do aplicativo NaveghiBook, construído no *Figma* enquanto produto viável mínimo. O *Figma* é um *software* voltado ao desenvolvimento de sistemas de *design* gráfico, prototipagem de interface gráfica de usuário e desenvolvimento do *design* UI/UX (experiência da interface com o usuário). Para a construção do produto viável mínimo, também foi realizado um levantamento na literatura para identificar os principais aplicativos voltados à mediação da contação de histórias nas bases de dados (MEDLINE, PubMed, Scopus e *Web of Science*) e na *Play Store*.

3.4.2 - Primeira validação do aplicativo NaveghiBook: em seguida, foi elaborada a interface do NaveghiBook com as principais funcionalidades, como tela inicial, tela de cadastro, tela de *login*, menu, pesquisa, atividades de contação de histórias, lousa de desenhos, desafios, atividades lúdicas e favoritos. A Figura 3 (Apêndice A) mostra a primeira versão do aplicativo.

3.4.3 - Avaliação e/ou aplicação: as crianças, nesta etapa, avaliaram a versão do protótipo no Figma, que contava com as mesmas funcionalidades citadas anteriormente no tópico 3.4.2 e apenas três histórias.

Na construção das funcionalidades do protótipo, três histórias foram inicialmente desenvolvidas e integradas. Posteriormente, outras nove histórias foram adicionadas de forma progressiva ao aplicativo. Hoje o NaveghiBook possui 12 histórias infantis, em formato de áudio e vídeo, voltadas às crianças/família

hospitalizadas: “Um dia de chuva”; “A grande cirurgia”; “Erro no canto”; “Pequeno viajante estelar”; “A família panda”; “Peter, o tocado pela água”; “Quando sinto saudades”; “Grande heróis”; “Chapéus”; “Penacho”; “Quintal de passarinho”; e “Meg e a viagem no tempo”. Os autores dos contos foram Mirelly Barros, Adélia Falcão e Matheus Simplício. O conteúdo das histórias aborda também temáticas sobre coragem, superação, amor, esperança e empatia. O Quadro 1 (Apêndice C) descreve os resumos das histórias. As capas das histórias inseridas no NaveghiBook e em formato de livro físico também podem ser visualizadas na Figura 4 (Apêndice B).

3.5 Etapa II: Estudo de validação do aplicativo NaveghiBook

A primeira validação do NaveghiBook ocorreu com as versões iniciais em contextos de emergência pediátrica e enfermaria pediátrica, em diferentes ambientes de cuidado à criança. Nesta etapa, utilizamos o protótipo I, correspondente à primeira versão funcional do aplicativo, desenvolvida por um programador. O objetivo foi observar como o aplicativo seria usado nos diversos contextos, avaliando sua utilidade, aceitação e impacto na experiência das crianças e cuidadores/pais. Durante essa etapa, foram coletados *feedbacks* sobre a interface, o conteúdo e a interação, permitindo ajustes para melhor atender às necessidades do público-alvo em situações de hospitalização infantil.

Para as entrevistas com os genitores, utilizou-se um formulário do *Google Forms*®, contendo perguntas abertas e fechadas, com duração média de 20 minutos. Foram avaliadas as opiniões dos pais e cuidadores em relação ao conteúdo, à aparência, à satisfação, à experiência e à usabilidade do aplicativo. Aplicou-se o mesmo formulário às crianças, porém adaptado para critérios de satisfação por meio das “faces de emoções” antes e após o uso do aplicativo, além de permitir que participassem do processo por meio de desenhos.

Na etapa II, inicialmente, 19 pais e suas crianças fizeram a avaliação do protótipo I. Na segunda validação, referente ao protótipo II, participaram 22 pais e sete crianças, permitindo comparar a evolução e os ajustes realizados entre as duas versões do protótipo, conforme Figura 5 (Apêndice D).

A primeira versão do aplicativo foi apresentada na 11ª edição do *Campus Mobile*, na semana imersiva em São Paulo, de 5 a 9 de março de 2023, e avaliada por especialistas em saúde, tecnologia e inovação da Claro. Com o NaveghiBook já programado, nossa equipe participou da etapa final da *Campus Mobile* em maio de 2023, conquistando o primeiro lugar na categoria saúde.

O protótipo II e a última versão do aplicativo foram desenvolvidos por uma equipe vinculada à Universidade Federal de São Carlos especializada em *design* UI/UX, *front-end* e *back-end*. O aplicativo será publicado ainda no primeiro semestre de 2026 na *Play Store*. A validação por profissionais da área da saúde e tecnologia está sendo realizada em outra tese de doutorado, no programa de Pós-Graduação em Enfermagem, intitulado “Construção e validação de aplicativo móvel em formato de “contação de histórias” para o letramento em saúde de crianças hospitalizadas”, da doutoranda Adélia Falcão. A Figura 6 (Apêndice E) mostra a versão atual do NaveghiBook.

3.6 Etapa III. Estudo de intervenção

Estudos de intervenção são pesquisas nas quais o pesquisador introduz uma ação ou programa e observa as mudanças que ela causa nos participantes. Dessa maneira, nesta etapa do estudo, optou-se por realizar duas intervenções, uma intervenção com livros físicos e outra utilizando as histórias digitais, através do aplicativo NaveghiBook, em sua última versão. Ambos os grupos tiveram acesso às mesmas histórias.

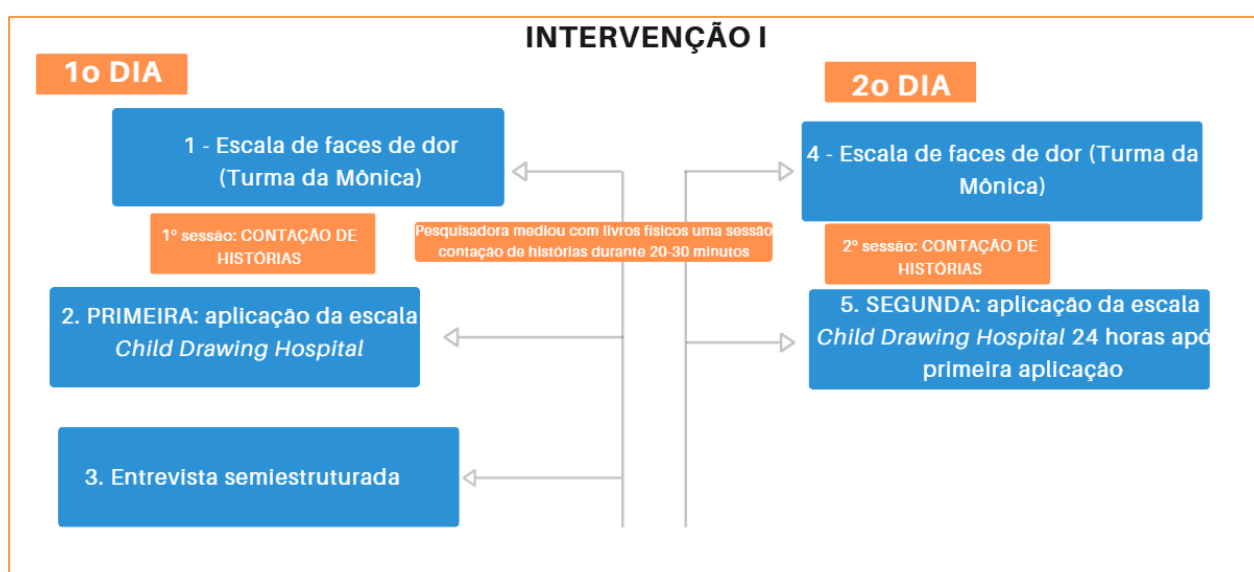
3.6.1 Descrição das intervenções

As crianças foram abordadas, inicialmente, juntamente com seus responsáveis e convidadas a participar do estudo através da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice B) e do Termo de Assentimento Livre e Esclarecido. Os responsáveis e as crianças foram esclarecidos a respeito dos riscos e benefícios da pesquisa antes de decidirem se desejavam participar deste estudo.

Após as assinaturas, a pesquisadora principal, que utilizava o acessório de orelhas de raposa, consultava cada criança participante sobre o interesse em receber um par igual, e a partir desse momento, iniciava-se a intervenção.

Na intervenção I, a pesquisadora utilizou a escala de faces de dor (Turma da Mônica) para avaliação inicial. Sequencialmente, a criança participou de uma sessão de contação de histórias com livros físicos, com duração de 20 a 30 minutos. Nessa sessão, cada criança escolheu de três a quatro histórias. Ao final, foi aplicada a escala CD:H. Em seguida, foi realizada uma entrevista semiestruturada com a criança. Em 24 horas, foi usada escala de faces de dor (Turma da Mônica) para nova avaliação inicial no segundo dia, e a criança teve uma nova sessão de contação de histórias, sendo também feita uma nova aplicação da escala CD:H, conforme esquematizado em fluxograma na Figura 7.

Figura 7 - Fluxograma das etapas da coleta de dados na intervenção I. Recife, Pernambuco, Brasil 2025



Fonte: elaborada pela autora (2025).

Os livros em formato físico foram impressos em papel especial plastificado, o que permite a desinfecção adequada para o ambiente hospitalar, conforme a Figura 8 a seguir:

Figura 8 - Livros com todas as páginas plastificadas e com encadernamento



Fonte: elaborada pela autora (2025).

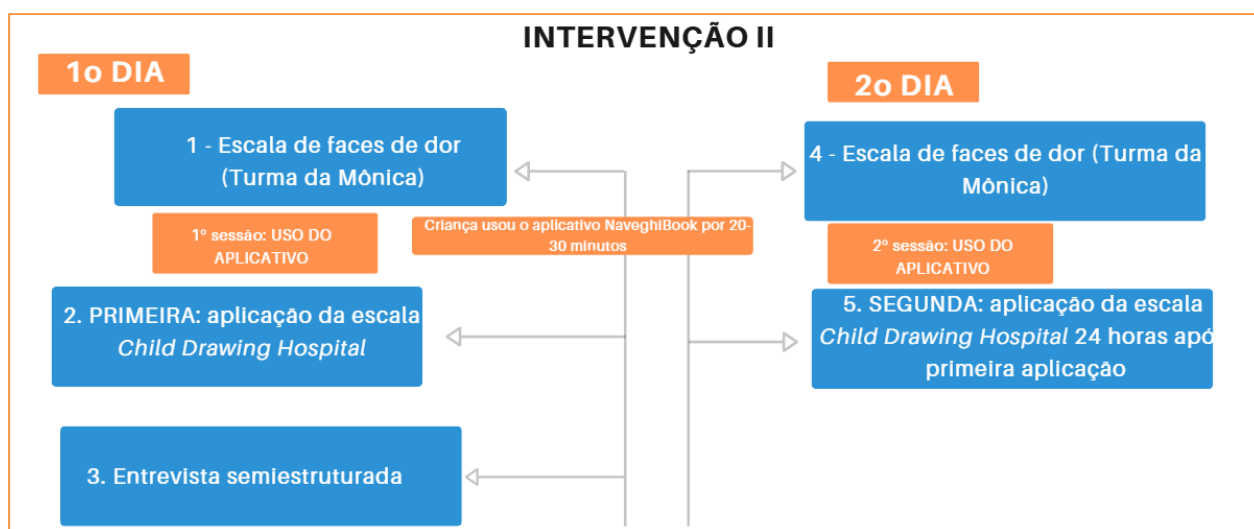
Figura 9 - Livros distribuídos sobre a mesa de atividades utilizada na intervenção I



Fonte: elaborada pela autora (2025).

Na intervenção II, a pesquisadora utilizou a escala de faces de dor (Turma da Mônica) para avaliação inicial. Sequencialmente, a criança usou o NaveghiBook por 20 a 30 minutos, período no qual escolheu entre três e quatro histórias. Esse momento foi concluído com a aplicação da escala CD:H após o uso do aplicativo. Em seguida, a criança participou de uma entrevista semiestruturada. Em 24 horas, foi utilizada a escala de faces de dor (Turma da Mônica) para uma nova avaliação inicial no segundo dia. A criança usou novamente o NaveghiBook, e foi feita uma nova aplicação da escala CD:H, conforme esquematizado no fluxograma da Figura 10. Os dois grupos de intervenção acessaram as mesmas histórias. Em toda a interação com ambos os grupos, a pesquisadora principal usou uma tiara de raposa e ofereceu uma tiara semelhante à criança participante.

Figura 10 - Fluxograma das etapas da coleta de dados na intervenção II. Recife, Pernambuco, Brasil, 2025



Fonte: elaborada pela autora (2025).

Figura 11 - Dispositivo celular com aplicativo NaveghiBook sobre a mesa de atividades utilizada na intervenção II. Recife, Pernambuco, Brasil, 2025

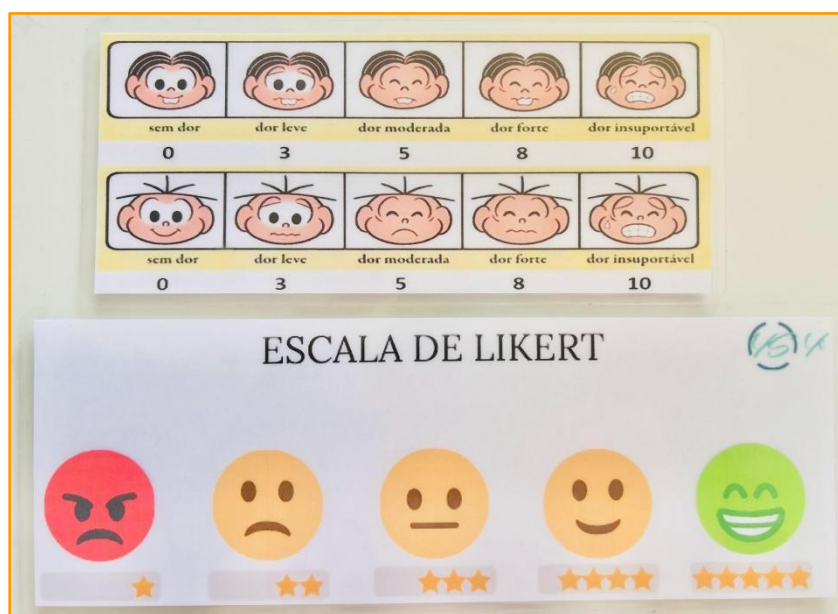


Fonte: elaborada pela autora (2025).

Durante o tempo de uso do aplicativo e contação de histórias no formato tradicional, a pesquisadora esteve disponível para sanar dúvidas e auxiliar no manuseio do equipamento eletrônico. Foi também oferecida a possibilidade de acesso/uso do aplicativo e livros para os genitores/acompanhantes das crianças.

A seguir, são apresentadas a Escala de Faces da Turma da Mônica em material plastificado e a escala de Likert, sendo esta última utilizada durante a entrevista, para obter respostas das crianças sobre a avaliação do aplicativo e da intervenção mediada por livros físicos.

Figura 12 - Escala de faces da Turma da Mônica e escala de Likert em material plastificado



Fonte: elaborada pela autora (2025).

3.7 Coleta de dados

Para melhor compreensão dos diferentes aspectos que envolvem o contexto da pesquisa em questão, foram utilizados diversos instrumentos para garantir a observação de diferentes perspectivas das crianças sobre o uso do aplicativo NaveghiBook para mediação de histórias infantis digitais e para contação de histórias no formato tradicional utilizando os livros físicos, com foco nos sentimentos, nas emoções e no bem-estar das crianças.

3.7.1 Compreendendo os sentimentos e emoções antes e após o uso do aplicativo

Para coleta de dados, foi utilizada a escala de ansiedade, com o intuito de compreender os sentimentos e emoções das crianças antes e depois do uso do aplicativo e da contação de história com os livros físicos.

Por se tratar de uma pesquisa com crianças, optou-se por utilizar estratégia de aproximação. A pesquisadora utilizou uma tiara de orelhas de raposa (Figura 10) nesse momento de interação inicial e distribuiu uma tiara do mesmo tipo para cada criança, como estratégia de identificação lúdica e sensível. Essa estratégia também

teve como objetivo criar uma associação com a mascote “Raposinha”. Não foi possível identificar, na literatura consultada, estudos que utilizassem essa mesma abordagem.

Utilizou-se o quadro de faces infantis (escala de faces ilustrado da Turma da Mônica) com expressões de sentimentos e emoções, visando facilitar a expressão dos sentimentos e de dor antes do uso do aplicativo pelos participantes da intervenção II e da contação de histórias com os livros físicos com os participantes da intervenção I. A escala de faces ilustrada da Turma da Mônica foi impressa no tamanho 50 cm X 50 cm, visando tornar o momento da entrevista mais interativo e divertido para a criança.

Após a realização da intervenção de cada grupo, foi aplicada a escala CD:H. Esse instrumento foi criado pelas enfermeiras Clatworthy, Simon e Tiedeman (1999), sendo usado para mensurar o estado emocional de crianças em idade escolar hospitalizadas. A CD:H é um instrumento prático e de fácil aplicabilidade, no qual a criança é convidada a realizar um desenho de uma pessoa no hospital.

O desenho é avaliado conforme instrumento da escala, que é dividido em três partes: A, B e C (Clatworthy, Simon; Tiedeman, 1999). A parte A é constituída por 14 itens, que avaliam posição, ação, comprimento, largura, tamanho da pessoa, expressão facial e dos olhos, cor predominante, número de cores utilizadas, uso do papel, localização no papel, inclusão e tamanho de equipamentos hospitalares, e nível de desenvolvimento (Clatworthy, Simon; Tiedeman, 1999).

A parte B é composta por oito itens, que observam/identificam índices de ansiedade, considerando e analisando o formato e as disposições do desenho (Clatworthy, Simon; Tiedeman, 1999). A parte C se refere à Gestalt do desenho. Nesta etapa, pontua-se o efeito que o desenho produz no avaliador, variando de agradável a oprimido. A escala CD:H, adaptada na versão brasileira, encontra-se no Anexo A (Clatworthy, Simon; Tiedeman, 1999). A escala CD:H manual foi adaptada culturalmente para o Brasil através de estudo desenvolvido na Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo, o que otimizou o seu uso no presente estudo (Campos, 2018).

Clatworthy, Simon e Tiedeman (1999) sugerem que os níveis de ansiedade avaliados pela escala CD:H variam conforme a pontuação total e indicam intervenções que devem ser feitas com cada pontuação obtida. Pontuações inferiores/igual a 43 indicam ansiedade muito baixa, situação em que intervenções realizadas com os pais

podem favorecer o desenvolvimento de estratégias de enfrentamento da criança (Clatworthy, Simon; Tiedeman, 1999).

Entre 44 e 83 pontos, a ansiedade é considerada baixa, sendo recomendada uma intervenção direta com a criança para prevenir possíveis dificuldades. Pontuações entre 84 e 129 refletem um nível médio de ansiedade, para o qual se aconselha a realização de intervenções diárias utilizando brincadeiras terapêuticas (Clatworthy, Simon; Tiedeman, 1999).

Pontuações entre 130 e 167 indicam ansiedade acima da média, sendo necessária a manutenção da intervenção diária com brincadeira terapêutica e a consulta à equipe de saúde mental. Pontuações iguais ou superiores a 168 indicam ansiedade muito alta, e a criança deve ser encaminhada para uma equipe especializada em saúde mental (Clatworthy, Simon; Tiedeman, 1999).

3.7.2 Entrevista com a criança a partir de método criativo

A entrevista semiestruturada foi realizada ao final da intervenção, técnica que proporciona uma conversação entre o entrevistador e o entrevistado. Esse encontro é direcionado mediante os objetivos inerentes à pesquisa. Durante a entrevista, a pesquisadora utilizou recursos lúdicos (tiara de raposinha) para mediar o diálogo, respeitando as especificidades desse público (Campos-Ramos Barbato, 2014; Carvalho *et al.*, 2004).

Algumas perguntas da entrevista foram respondidas através da escala de Likert (Lucian, 2016; Junior; Costa, 2014; Menegazzi; Sylla, 2023), com o intuito de mensurar a experiência de interação das crianças com aplicativo e o momento de contação de histórias, possibilitando comparação entre os dados dos dois grupos de intervenção. Outras perguntas foram respondidas com desenho gráfico feito pelas crianças, utilizando folha branca de ofício A4 e giz de cera de sete cores.

Os áudios das entrevistas foram registrados com um dispositivo celular, garantindo a preservação fiel do conteúdo para posterior análise.

3.7.3 Respostas em desenhos/outras formas de dialogar com a criança

Os desenhos infantis em pesquisas centradas na criança permitem acessar, de forma inclusiva e respeitosa, suas perspectivas, valores e aspirações, sendo importantes instrumentos de coleta de dados quando analisados com métodos sistemáticos e cuidadosos. Essa é uma abordagem especialmente divertida para as crianças, que proporciona um momento agradável durante a interação, sendo uma fonte de dados para a pesquisa (Merriman; Guerin, 2006).

Nosso estudo utilizou o desenho estruturado, que é caracterizado por Tabatabaey-Mashadi, Sudirman e Khalid (2013) como um desenho que é feito a partir de solicitações específicas, pois envolve uma tarefa com determinadas restrições, na qual o desenho deve seguir regras ou etapas. Em nosso estudo, o pedido feito à criança, “desenhe uma criança no hospital”, recomendado pela a escala CD:H, caracteriza um tipo de desenho estruturado.

Algumas crianças também optaram por realizar o desenho livre, preferindo fazer desenhos sem qualquer instrução específica, tema obrigatório ou estrutura pré-definida. É possível a liberdade para escolher o que desenhar, como desenhar e quais elementos incluir (Souza; Iriart, 2022).

Ademais, os desenhos como resposta a perguntas também compuseram os resultados do estudo, uma vez que, durante a entrevista, a criança pôde responder às perguntas formuladas pela pesquisadora principal por meio de desenhos escolhidos e imaginados por ela própria, sem interferência de terceiros. As descrições realizadas pelas crianças sobre cada desenho foram gravadas e posteriormente transcritas, sendo utilizadas como legendas nos resultados apresentados.

3.7.4 Observação participante

Durante todo o processo, foi realizada a observação participante, que trata do ato de perceber, de forma empírica, a realidade. Minayo (2014) descreve que se manterá “a presença de um observador que participa da vida dos observados na medida em que se relacionam dentro do cenário”.

A pesquisadora esteve presente em todos os encontros de medição do uso do aplicativo NaveghiBook e mediu a contação de histórias com os livros físicos. Ela buscou observar aspectos relacionados à temática em investigação para alcançar os objetivos da pesquisa. Nenhum profissional adicional foi treinado para executar as sessões. A condução de todas as intervenções foi feita unicamente pela pesquisadora responsável, mantendo o mesmo padrão de abordagem em todas as crianças.

3.7.5 Diário de campo

As observações e reflexões que foram feitas pela pesquisadora durante a coleta de dados foram registradas em diário de campo. Essa ferramenta permitiu a construção de inferências a partir de comentários, impressões, dificuldades ou breves lembretes registrados de forma organizada (Cachado, 2021). Dessa forma, a Figura 13 ilustra, de maneira resumida, o percurso da coleta de dados:

Figura 13 - Percurso da coleta de dados



Fonte: elaborada pela autora (2025).

3.8 Análise de dados

3.8.1 Dados qualitativos

Optou-se pela técnica de análise de conteúdo, possuindo as seguintes etapas definidas por Bardin (2016): pré-análise; exploração do material ou codificação; e tratamento dos resultados, inferência e interpretação. Esse recurso permitiu analisar as entrevistas realizadas com as crianças, os comentários dos cuidadores, os desenhos e as anotações da pesquisadora feitas em diário de campo durante a observação participante, facilitando a identificação de padrões e temas emergentes relacionados às experiências das crianças.

1 - Primeira etapa: pré-análise

Nesta etapa, foram realizadas a leitura e a análise inicial de todas as entrevistas, desenhos e escalas aplicadas durante a coleta de dados.

2 - Segunda etapa: exploração do material ou codificação

Os dados brutos coletados das entrevistas, registros em diário de campo e desenhos foram transformados sistematicamente, sendo agregados em unidades.

3 -Terceira etapa: tratamento dos resultados com inferência e interpretação

A organização e a análise dos dados foram conduzidas à luz da teoria de Vygotsky, especialmente no que se refere ao meio sociocultural, à presença do mediador e ao seu papel no desenvolvimento infantil, bem como à educação estética, especificamente no que se refere à recepção estética, às emoções e criações, ao sentimento na vivência estética, à educação dos sentimentos, ao encantamento estético, à imaginação e à criatividade na infância. Essa perspectiva possibilitou compreender de que modo a mediação das histórias, tanto por meio dos livros físicos quanto pelo aplicativo NaveghiBook, contribuiu para a construção de sentidos, evidenciando a sensibilidade estética das crianças hospitalizadas e valorizando as interações sociais, a imaginação e os processos de significação nesse contexto de cuidado e aprendizagem.

Os desenhos do presente estudo foram, inicialmente, categorizados de forma comparativa. Primeiramente, foram apresentados os desenhos referentes à escala CD:H elaborados pelas crianças que participaram dos dois dias de intervenção em

ambos os grupos. Em seguida, analisaram-se os desenhos da escala CD:H produzidos pelas crianças que participaram de apenas um dia de intervenção.

Posteriormente, foram apresentados os desenhos nos quais as crianças demonstraram maior identificação com as histórias, evidenciando aspectos de similaridade com suas vivências pessoais. Na sequência, apresentaram-se os desenhos dos personagens das histórias que foram mais frequentemente ilustrados pelos participantes dos dois grupos. Foram incluídos, posteriormente, os desenhos nos quais a pesquisadora principal foi representada pelas crianças.

Durante a coleta de dados, observou-se que a maioria das crianças apresentou dificuldade em desenhar algo que não tenha gostado durante a mediação. Diante disso, foi-lhes oferecida a opção de desenhar livremente ou de não realizar o desenho. Os desenhos produzidos nessas condições foram incluídos no tópico 4.11 dos resultados. Por fim, foi incorporado o desenho de uma participante do grupo de intervenção II, que solicitou a leitura de um livro físico de uso pessoal.

As informações obtidas nesta pesquisa foram organizadas em categorias, a partir da análise, da quantificação simples do conteúdo e observação de desenhos.

3.8.2 Dados quantitativos: estatística simples

Na análise dos resultados, adotou-se uma abordagem quantitativa fundamentada em estatística descritiva e inferencial. Inicialmente, os dados foram organizados em tabelas e representados graficamente, de modo a possibilitar uma visualização clara e comparativa dos achados.

As estatísticas descritivas compreenderam medidas de tendência central (média), de dispersão (desvio padrão) e de variação (valores mínimo e máximo), além da utilização de escores para padronizar e facilitar a interpretação dos resultados. Para a análise inferencial, foi aplicado o teste t pareado, adequado para comparar médias em condições relacionadas, buscando identificar diferenças significativas entre os momentos avaliados.

Os valores de p foram reportados como indicadores de significância estatística, assegurando maior rigor científico na interpretação dos resultados. Essa combinação de procedimentos analíticos permitiu uma descrição mais detalhada dos dados.

3.9 Aspectos éticos e legais

O presente estudo foi apreciado e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos, sob Parecer nº 7.280.984 e Certificado de Apresentação para Apreciação Ética nº 834.95924.0000.5208, corroborando o cumprimento das orientações da Resolução nº 466/2012 e da Resolução nº 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde, que dispõem sobre as diretrizes e normas regulamentadas de pesquisa envolvendo seres humanos.

Foram assegurados os princípios éticos de autonomia, não maleficência, confidencialidade das informações, minimização de riscos físicos e morais relacionados à participação no estudo. Todos os participantes assinaram voluntariamente o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e o Termo de Assentimento Livre e Esclarecido. Eles tiveram garantia de anonimato através do uso de pseudônimos, sendo utilizados os seguintes nomes de personagens de histórias infantis da escritora Beatrix Potter: Flopsy, Benjamin Bunny, Mopsy, Mrs. Jeremy-Fischer, Tom Kitten, Mr. Drake Puddle-Duck, Peter Rabbit, Cotton-tail, Tiimmy Tiptoes, Simpkin, Mrs. Tiggy-Winkle, Samuel Whiskers, Lucinda, Miss Rose, Jane, Miss Moppet, Appley Daply e Jemima Puddle-Duck.

Os procedimentos de coleta foram iniciados após a aprovação do projeto de pesquisa pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal de Pernambuco e pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás.

Os riscos da presente pesquisa foram: a) A criança se sentir desconfortável em ter seu depoimento gravado e ter a divulgação de suas informações; b) A criança se sentir frustrada em não saber responder a alguma pergunta. Nesse caso, as pesquisadoras interromperam a entrevista e lhe perguntaram sobre o desejo de continuar usando o aplicativo ou ouvir a história durante a mediação. A pesquisadoras

explicaram que não existiam respostas erradas e também ajudaram com informações sobre o uso do aplicativo; c) No caso de expressão de alguma vivência emocional negativa, a equipe multiprofissional foi comunicada, e um plano de intervenção individual foi realizado de forma colaborativa com a pesquisadora para cuidar da demanda emocional da criança.

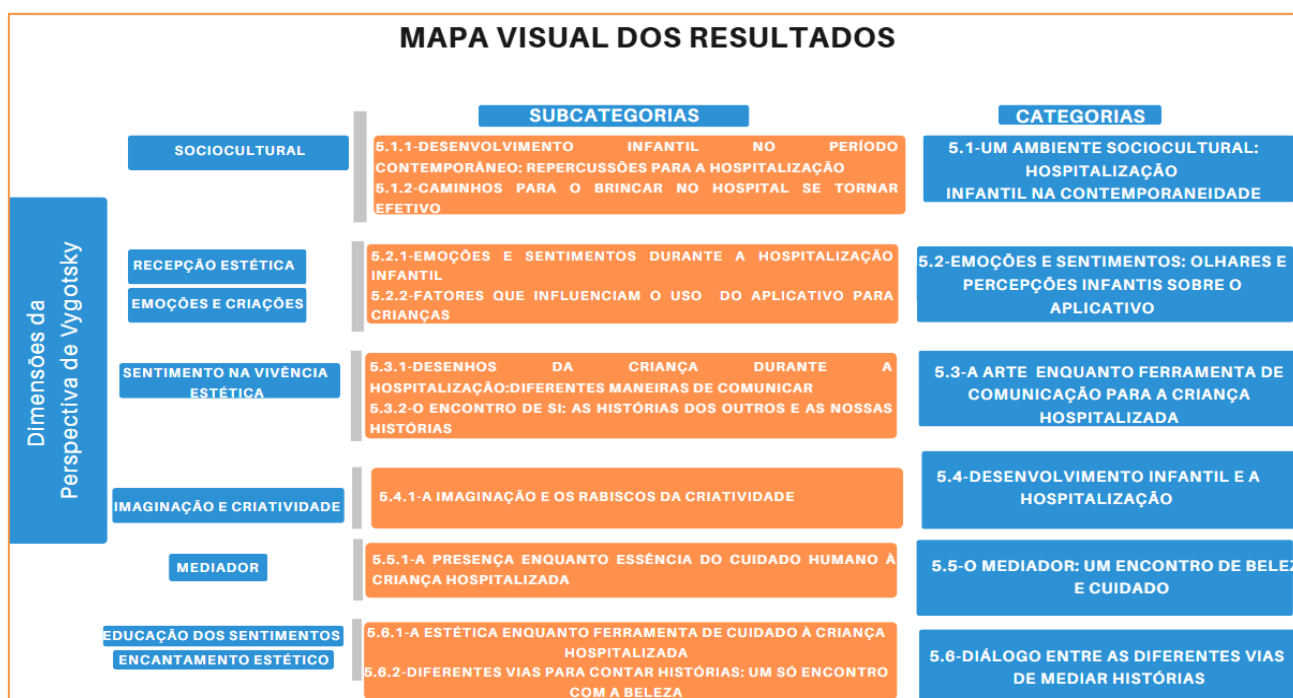
Em relação aos benefícios advindos da pesquisa, foram construídos conhecimentos sobre os sentimentos e emoções de crianças hospitalizadas e como o uso de tecnologias pode facilitar o vivenciamento do processo de adoecimento. Ademais, as crianças puderam ter um momento lúdico e de diversão durante o internamento e interagir com as pesquisadoras.

Benefícios adicionais estão relacionados à oportunidade de incentivo ao uso de aplicativos como ferramentas educativas no conhecimento e habilidades das crianças sobre o processo de hospitalização e a disponibilidade de ter o acesso ao aplicativo de forma gratuita após participação voluntária nesta pesquisa. Os dados coletados ficarão armazenados no computador da pesquisadora responsável, com senhas, por um período de cinco anos.

4 RESULTADOS

As categorias construídas foram subsidiadas a partir de temas que emergiram a partir de múltiplas fontes de evidência e analisadas a partir da perspectiva da educação estética de Vygotsky, conforme descrito na Figura 14.

Figura 14 - Mapa visual dos resultados



Fonte: elaborada pela autora (2025).

4.1 Caracterização da amostra

O estudo, na etapa III, contou com 18 crianças participantes, sendo nove do sexo feminino (50%) e nove do sexo masculino (50%). A maioria possuía 6 anos (28%) e 9 anos (28%), havendo apenas um participante com 8 anos (6%). Em relação à escolaridade, predominam crianças matriculadas no 1º ano (28%) e no 4º ano (28%), enquanto apenas um participante frequentava o 5º ano da educação infantil (6%).

A seguir, na Figura 15, foi feita uma apresentação dos 18 participantes do estudo, com um breve resumo sobre seu histórico de internamento. Para garantir o anonimato, optou-se por identificá-los com codinomes e ilustrá-los como os personagens das histórias infantis da escritora britânica Beatrix Potter:

Figura 15 - Caracterização de crianças participantes: existe beleza em cada história



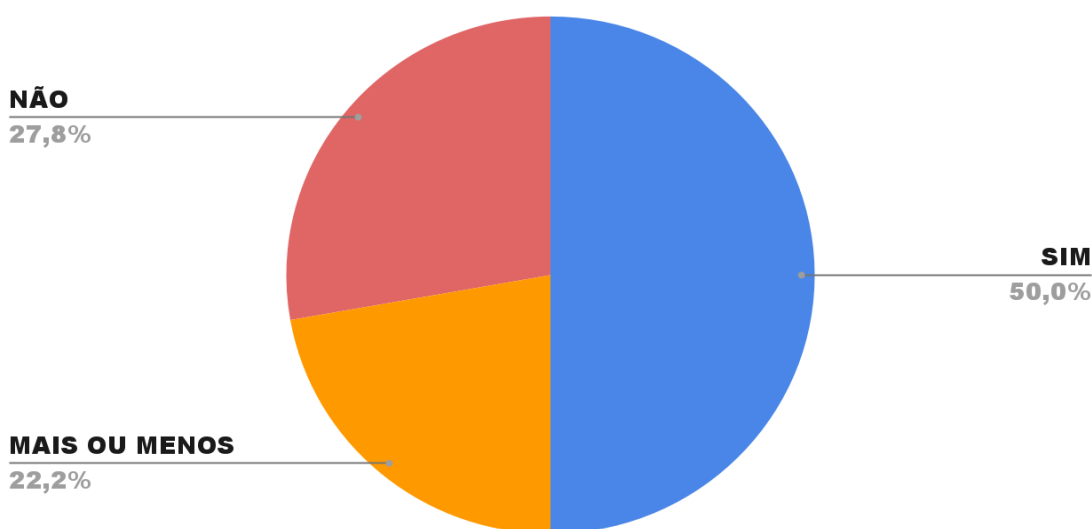
Fonte: elaborada pela autora (2025).

4.2 Caracterização de hábitos da criança hospitalizada

Os participantes também foram questionados sobre o hábito de ler/ouvir histórias infantis e sobre o gênero literário favorito. No grupo estudado, 50% dos participantes relataram possuir esse hábito; 22,2% afirmaram manter a prática de forma parcial (“mais ou menos”); e 27,8% declararam não ter esse hábito. Nota-se, portanto, que embora metade da amostra reconheça a presença dessa prática, há uma parcela significativa que a realiza de modo apenas ocasional, além de um terço que a nega completamente.

Figura 16 - Hábitos de ler/ouvir histórias infantis

HÁBITO DE LER/OUVIR HISTÓRIAS



Fonte: elaborada pela autora (2025).

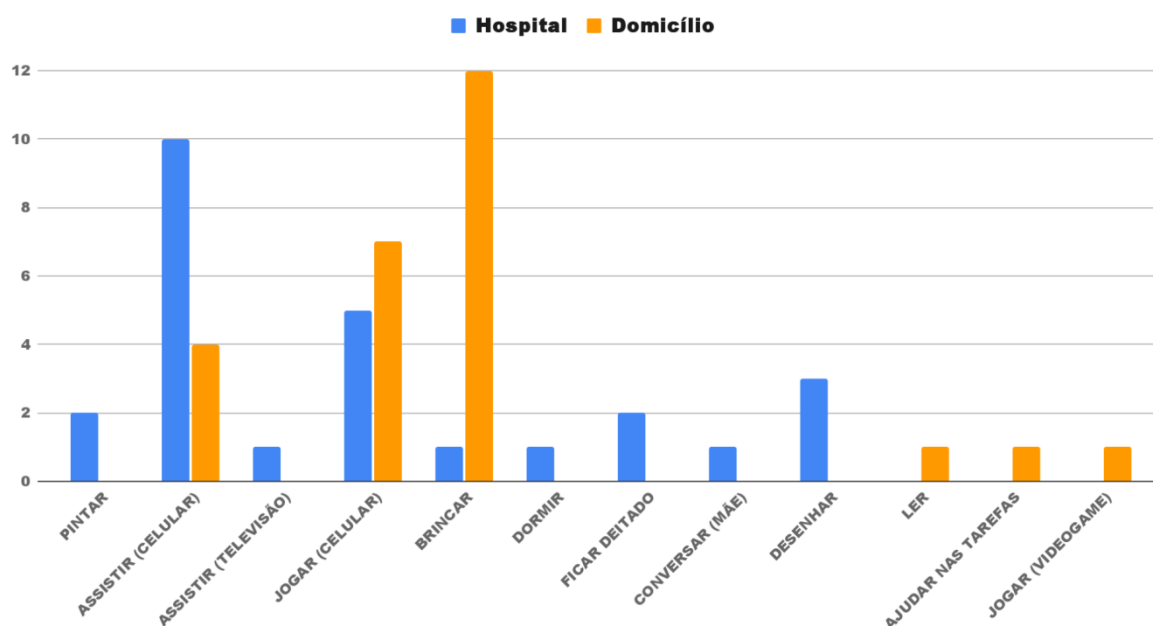
Os resultados também evidenciaram as atividades de entretenimento de maior preferência das crianças durante a hospitalização. O uso do celular para assistir e jogar foi descrito pela maioria dos participantes. De forma mais específica, as crianças relataram que gostam de assistir a vídeos no *YouTube*®, *shorts* aleatórios e alguns canais específicos disponibilizados na plataforma, como Julia Minegirl (influenciadora digital que ensina crianças como melhorar performances em jogos como *Roblox* e

Minecraft) e Emily Vick (influenciadora digital que produz conteúdos sobre o cotidiano adulto, danças e coreografias para músicas no estilo funk).

Os participantes também foram questionados sobre a principal atividade de entretenimento domiciliar. Brincar foi a atividade mais citada, com as seguintes brincadeiras: brincar de boneca, brincar de luta, brincar de pique-gelo, brincar de pular corda, brincar com jogos de raciocínio e memória, brincar com animais de estimação e contribuir nas atividades de organização do lar. Entretanto, assistir ou jogar no celular também foram citados como atividades de entretenimento em casa. Os jogos mais citados entre as crianças foram *Roblox*, *Freefire* e *Minecraft*. Jogar e assistir por meio do celular foram a segunda e a terceira atividade mais realizadas em casa pelas crianças do estudo. A Figura 17 a seguir nos permite visualizar de forma objetiva as informações supracitadas:

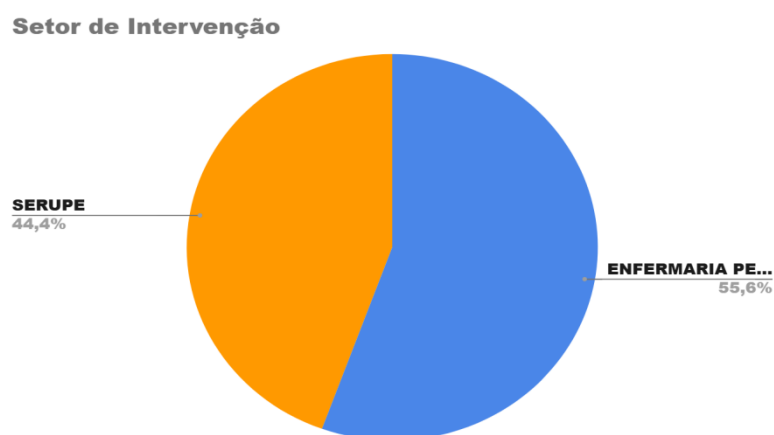
Figura 17 - Atividade de entretenimento durante a hospitalização e em domicílio

Atividades de Entretenimento - Hospitalização e Domicílio



Fonte: elaborada pela autora (2025).

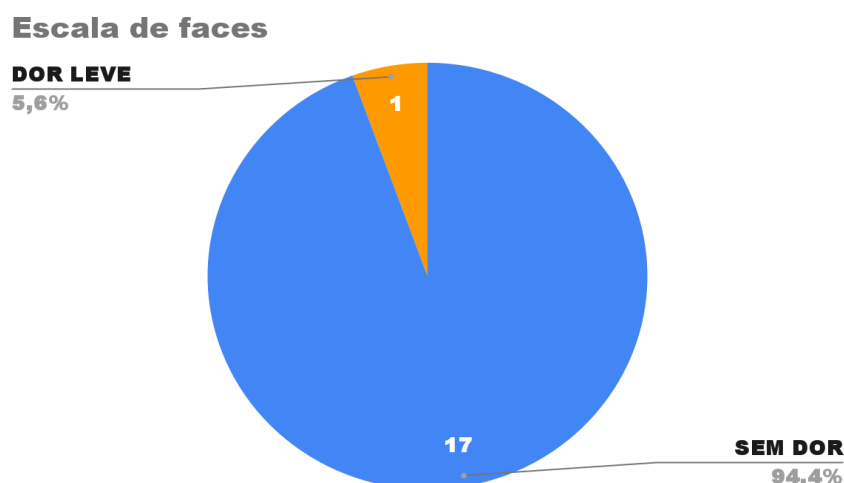
Considerando o setor de realização das intervenções, verificou-se que dez participantes (55,6%) foram atendidos na enfermaria pediátrica, ao passo que oito foram abordados no SERUPE (44,4%), conforme Figura 18 a seguir:

Figura 18 - Setor de intervenção

Fonte: elaborada pela autora (2025).

4.3 Nível de ansiedade das crianças (escala de faces e *Child Drawing: Hospital*) durante a hospitalização

Antes de iniciar a intervenção com os dois grupos, cada criança foi questionada como estava se sentindo. Para isso, usou-se a escala de faces ilustrada da Turma da Mônica para identificar expressões de dor, sentimentos e emoções antes do uso do aplicativo para o grupo de intervenção II e da contação de história com os livros físicos para o grupo de intervenção I. Apenas um participante descreveu estar sentindo dor leve, referindo desconforto relacionado ao uso do acesso periférico (5,6%). E todos relataram estar bem ou felizes antes da intervenção.

Figura 19 - Escala de faces

Fonte: elaborada pela autora (2025).

Quanto à análise comparativa da escala CD:H em relação ao nível de ansiedade dos participantes dos grupos de intervenção I e II, apenas três participantes de cada grupo realizaram as atividades de intervenção propostas para os dias 1 e 2, totalizando seis participantes. A análise comparativa das pontuações obtidas e da classificação mostrou que houve diminuição da pontuação total da escala CD:H em todos os seis participantes. Porém, apenas três obtiveram mudança de nível de ansiedade.

Entretanto, constatou-se que os grupos de intervenção I e II apresentaram redução dos escores totais da escala CD:H do primeiro para o segundo dia. O grupo de intervenção I reduziu em média 17 pontos, enquanto o grupo de intervenção II reduziu em média 13 pontos. A análise sugere que a diminuição dos níveis de ansiedade ocorreu de forma semelhante entre os dois grupos, como podemos observar, de forma detalhada, nas Tabelas 1 e 2:

Tabela 1 - Estatísticas descritivas dos escores totais da escala *Child Drawing: Hospital* nos dois dias

DIA	MÉDIA	DESVIO PADRÃO	MÍNIMO	MÁXIMO
Primeiro	111,17	30,62	62	144
Segundo	95,50	33,26	47	125

Tabela 2 - Resultado do teste t pareado para os escores totais da escala *Child Drawing: Hospital*

COMPARAÇÃO	t(3)	p
Dia 1 versus Dia 2		3,51 0,017

Fonte: elaborada pela autora (2025).

Verificou-se predominância de nível de ansiedade médio entre os participantes deste estudo, evidenciando o quanto o ambiente hospitalar e o processo de adoecimento geram repercussões na saúde emocional infantil. A Tabela 3 apresenta as pontuações obtidas na escala CD:H de todos os 18 participantes após a realização das atividades propostas para cada grupo no primeiro dia de intervenção.

Tabela 3 - Todos os participantes dos dois grupos com a escala *Child Drawing: Hospital*

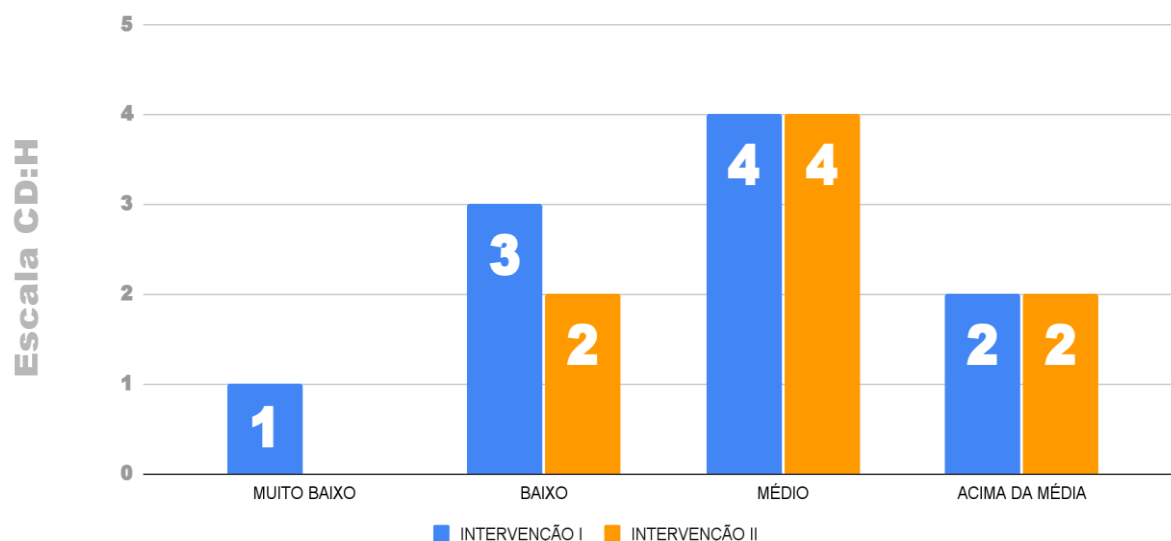
VARIÁVEL	N	(%)
ESCALA CHILD DRAWING: HOSPITAL		
MUITO BAIXO	1	6%
BAIXO	5	28%
MÉDIO	8	44%
ACIMA DA MÉDIA	4	22%
MUITO ALTO	0	0%

Fonte: elaborada pela autora (2025).

Na escala CD:H, observou-se que a distribuição dos participantes em relação aos níveis de ansiedade foi semelhante entre os grupos de intervenção I e II (Figura 20). No grupo de intervenção I, um participante foi classificado no nível muito baixo, três no nível baixo, quatro no nível médio e dois acima da média. Já no grupo de intervenção II, não foram identificados casos no nível muito baixo. Dois participantes foram classificados no nível baixo, quatro no nível médio e dois acima da média. Em ambos os grupos não houve registros no nível muito alto.

De modo geral, verifica-se que a maioria dos participantes se concentrou entre os níveis baixo e médio de ansiedade, sendo o nível médio o mais frequente nos dois grupos. A ausência de casos de ansiedade muito alta e a distribuição equilibrada entre os grupos sugerem que ambos apresentaram perfis semelhantes, sem diferenças significativas quanto à intensidade da ansiedade.

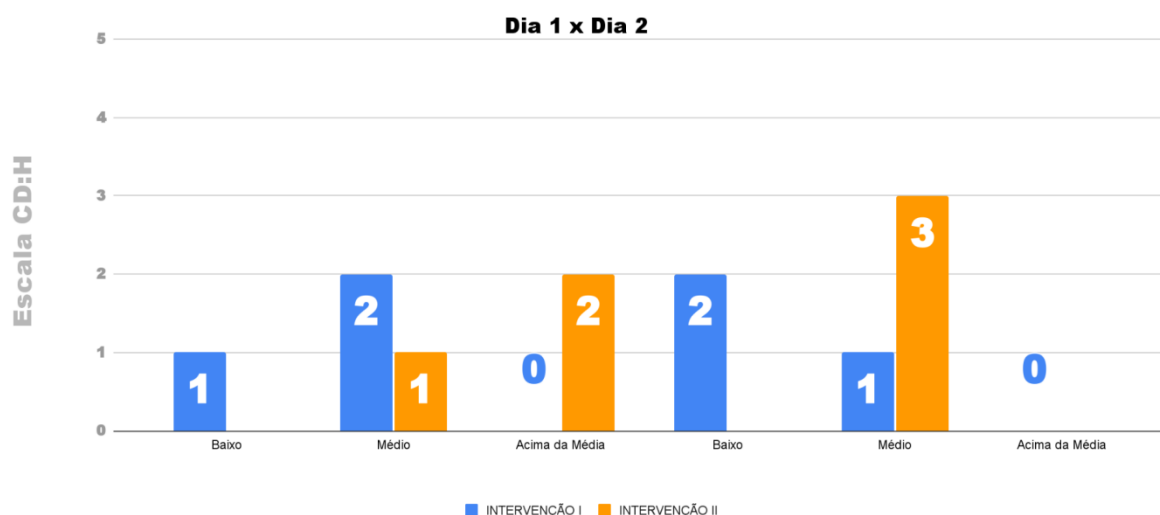
Figura 20 - Escala *Child Drawing: Hospital* comparando o nível de ansiedade dos dois grupos em colunas pareadas após o 1º dia de intervenção



Fonte: elaborada pela autora (2025).

Na Figura 21 a seguir, observamos a comparação entre os níveis de ansiedade medidos através da escala CD:H dos dois grupos (seis participantes), que participaram das intervenções propostas no 1º dia e 2º dia de coleta:

Figura 21 - Comparação do nível de ansiedade no 1º dia x 2º dia dos dois grupos



Fonte: elaborada pela autora (2025).

No dia 1, observou-se que o grupo de intervenção I apresentou maior concentração no nível médio da escala CD:H (n=2), com um participante no nível

baixo e nenhum no nível acima da média. Já o grupo de intervenção II foi distribuído de forma distinta, com predomínio do nível acima da média ($n=2$) e apenas um participante no nível médio, não havendo registros no nível baixo. Esses dados sugerem que, no momento inicial, o grupo de intervenção II submetido à intervenção apresentava nível de ansiedade relativamente superior em comparação ao grupo de intervenção I.

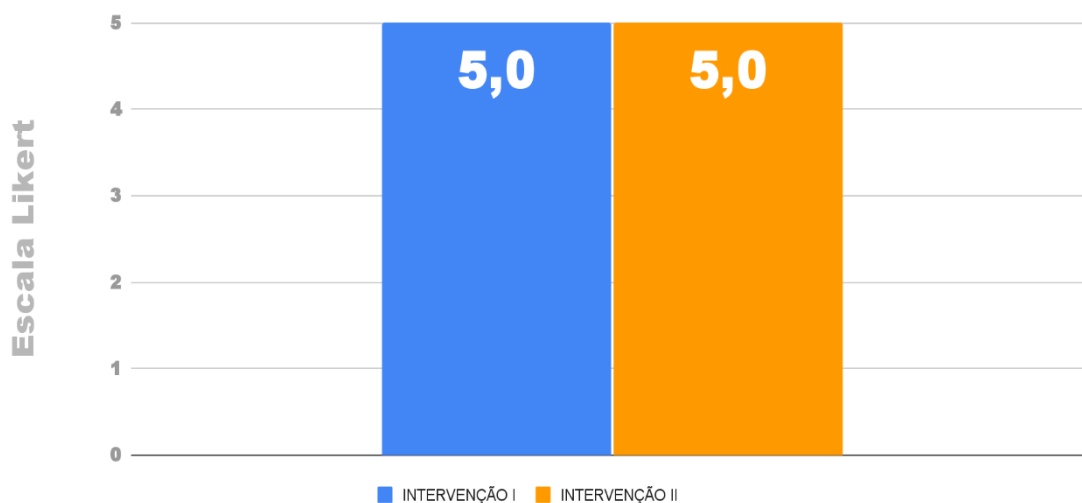
No dia 2, verificou-se alteração no padrão de distribuição. O grupo de intervenção I apresentou uma mudança em relação ao dia anterior, deslocando-se para os níveis inferiores da escala: dois participantes passaram ao nível baixo e apenas um permaneceu no nível médio, não havendo participantes “acima da média”.

Por outro lado, o grupo de intervenção II manteve maior homogeneidade, concentrando-se exclusivamente no nível médio ($n=3$). Devido à redução no número de participantes classificados como “acima da média” no primeiro dia, obteve-se redução de ansiedade para o nível “médio” ($n=2$) no segundo dia, o que indica melhora relativa do nível de ansiedade nesse grupo.

De modo geral, os resultados sugerem que, entre o primeiro e o segundo dia, o grupo de intervenção I apresentou tendência de queda no nível de ansiedade, alcançando valores mais baixos, enquanto o grupo de intervenção II evidenciou maior consistência, mantendo todos os participantes ($n=3$) no nível médio.

4.4 Análise de propriedades de multimídia do aplicativo NaveghiBook

Em relação à contação de histórias com os livros físicos e à contação de histórias mediada pelo aplicativo NaveghiBook, a análise demonstrou que o nível de satisfação, verificado pela escala de Likert, foi equivalente nos dois grupos, portanto existe uma semelhança significativa na satisfação dos dois grupos de participantes (Figura 22).

Figura 22 - Escala de Likert nos dois grupos de intervenção

Fonte: elaborada pela autora (2025).

Em relação às cores, aos desenhos e aos elementos lúdicos do aplicativo, esses itens foram considerados satisfatórios, sendo o nível máximo selecionado como a categoria mais escolhida pelos participantes do grupo de intervenção II.

As crianças atribuíram a pontuação máxima na escala de Likert (cinco estrelas), indicando que o aplicativo foi percebido como um recurso eficaz para apoiar tanto a leitura quanto a compreensão das histórias. Esse resultado evidencia uma avaliação positiva da experiência, sugerindo que os elementos do aplicativo conseguiram engajar os participantes e favorecer a assimilação do conteúdo narrativo.

Quanto às opções de acesso às histórias oferecidas pelo aplicativo, todas as crianças optaram por visualizar as histórias com vídeo narração, demonstrando preferência por esse formato multimodal. Além disso, tanto os recursos de vídeo quanto os de áudio e de imagem receberam a avaliação máxima (cinco estrelas) na escala de Likert, o que evidencia a aceitação e a satisfação das crianças em relação às diferentes formas de apresentação disponibilizadas.

Sobre as opções de atividades interativas do aplicativo (criar sua própria história, lousa e colorir desenhos), nenhuma criança avaliou a funcionalidade de “criar sua própria história”. Apenas uma criança avaliou a atividade “lousa” com quatro estrelas, enquanto a atividade “colorir desenhos” recebeu a menor avaliação (uma estrela), mas também foi avaliada por apenas uma criança.

Esses achados sugerem que, embora a proposta de atividades

complementares tenha sido bem aceita, algumas funcionalidades podem demandar ajustes para aumentar o engajamento e a atratividade. O fato de o manuseio da lousa ter sido disponibilizado em aparelho de celular, o que exige maior coordenação motora da criança, pode ter contribuído para a insatisfação com a funcionalidade.

A atividade “colorir desenhos” recebeu nota mínima (avaliada por um participante), devido à dificuldade de colorir pequenos espaços dos desenhos disponibilizados, gerando insatisfação por parte da criança com o resultado final da pintura. Possivelmente, o uso de um dispositivo com tela maior e uma caneta digital tornaria a atividade mais agradável.

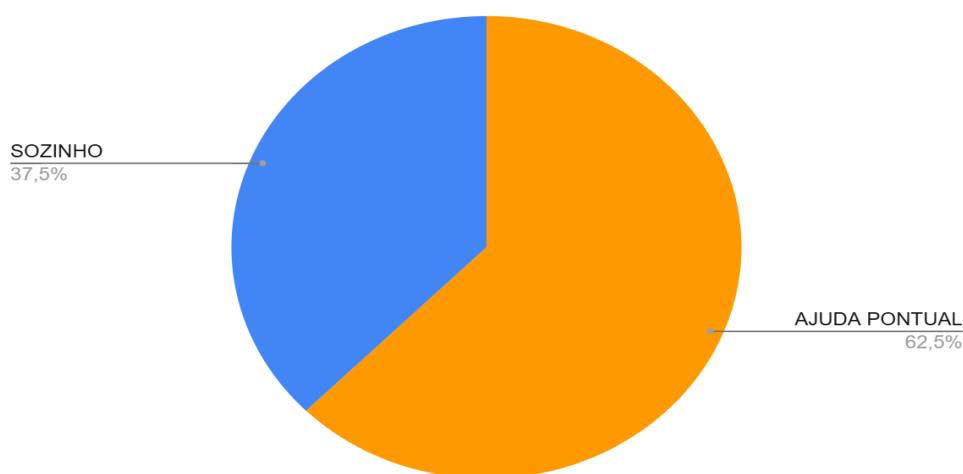
Esse mesmo participante se sentiu engajado a realizar o desafio linguístico, que está vinculado à história “O pequeno viajante estelar”. O desafio solicita que a criança e o cuidador escrevam uma carta em um papel em branco e escondê-la no ambiente em que se encontram. Os participantes devem fechar os olhos enquanto a carta é escondida e, então, iniciar sua procura. A criança escondeu a carta na pia do banheiro, enquanto o acompanhante a escondeu dentro da fronha da almofada do leito em que a criança estava internada. O momento terminou com um abraço, pois os dois escreveram mensagens carinhosas e de enfrentamento para a situação em que se encontravam. Assim, a opção de desafio do aplicativo recebeu o escore de cinco estrelas, evidenciando a satisfação de ambos com a funcionalidade.

Um fato observado que merece ser descrito é que, naquela tarde de mediação, a criança ouviu três histórias usando o aplicativo, mas nenhuma delas possuía um desafio integrado na categoria “desafio linguístico”. Por isso, foi necessário direcioná-la para uma quarta história para que ela seguisse para o desafio. Essa experiência nos leva a integrar todas as histórias a cada desafio no aplicativo NaveghiBook.

Quanto à forma de interação com o aplicativo, as crianças foram classificadas em duas categorias: uso autônomo, quando exploraram as funcionalidades sem auxílio da pesquisadora; e uso com auxílio, quando preferiram apoio para a realização das atividades, ainda que em momentos pontuais, especialmente, quando houve necessidade de retorno ao menu principal após o término das histórias. A Figura 23 a seguir evidencia tal fato:

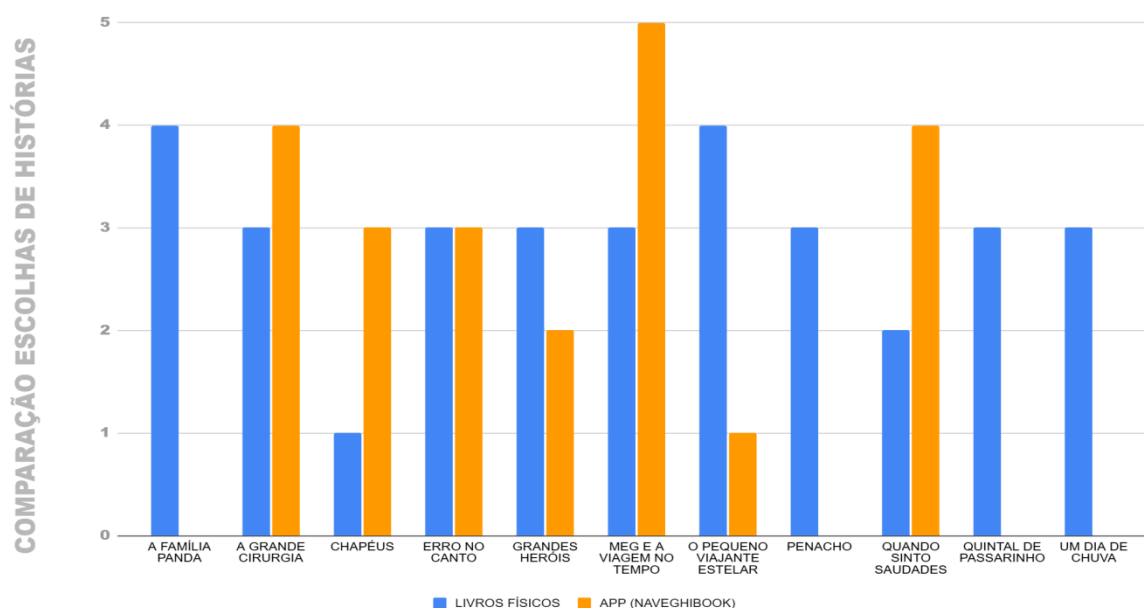
Figura 23 - Necessidade de auxílio para o uso do aplicativo

AUXÍLIO PARA USO DO APLICATIVO



Fonte: elaborada pela autora (2025).

Figura 24 - Comparação entre escolhas de histórias do grupo controle e do grupo experimental



Fonte: elaborada pela autora (2025).

A comparação entre as escolhas realizadas a partir dos livros físicos e aquelas efetuadas pelo aplicativo evidencia diferenças significativas na diversidade de títulos selecionados. Conforme ilustrado na Figura 24, a distribuição das escolhas realizadas com os livros físicos é mais equilibrada, contemplando praticamente todas as histórias disponíveis. Isso sugere que o contato direto com o material impresso, que permite folhear os exemplares e visualizar, de uma só vez, a variedade de opções e capas, favoreceu uma exploração mais ampla.

Em contraste, no aplicativo, observa-se uma concentração de escolhas em um número reduzido de histórias, com destaque para “Meg e a viagem no tempo”, “A grande cirurgia” e “Quando sinto saudades”. Diversos outros títulos, que foram escolhidos no suporte físico, aparecem com baixa ou nenhuma frequência no grupo que usou o aplicativo NaveghiBook.

Essa diferença pode ser atribuída à própria lógica de navegação do aplicativo. Para acessar as histórias, as crianças precisavam primeiramente selecionar uma categoria, o que funcionou como um filtro inicial que restringiu sua exposição ao conjunto total de opções. Dessa forma, a escolha se tornava limitada a um subconjunto de histórias, configurando um efeito que reduziu a diversidade de exploração.

Além disso, um dos participantes optou por não selecionar o tópico “família”, pois, ao ver esse nome, lembrou-se de conflitos existentes em sua própria família. Certamente, se a história tivesse sido apresentada diretamente pela capa lúdica, como “A família panda”, ele poderia se interessar imediatamente. Dessa forma, a organização das histórias por categoria pode reduzir o número de acessos, pois as pré-informações/pré-julgamentos influenciam as escolhas do público.

Portanto, o gráfico evidencia que o desenho da interface de categorias de histórias do NaveghiBook impactou diretamente a amplitude das escolhas, limitando a visibilidade e o acesso equitativo a todas as histórias, em contraste com a experiência oferecida pelo suporte físico.

4.5 Nossas observações vespertinas: análise de aspectos que envolvem o processo de mediação do aplicativo NaveghiBook

Todas as crianças foram questionadas sobre a preferência em ouvir as histórias do aplicativo com ou sem fones de ouvido. Entre aquelas que optaram por ouvir sem fones, observou-se um maior envolvimento dos cuidadores, tanto com as histórias quanto com a própria criança e com a pesquisadora.

A avaliação do processo de mediação permitiu concluir que, em algumas mediações, a instabilidade da internet prejudicou a progressão na transmissão das

histórias, prolongando a mediação e fazendo com que as crianças se dispersassem. Elas então solicitaram aos genitores os aparelhos celulares ou *tablets*.

As crianças demonstraram menor recusa em participar da atividade de contação quando esta foi mediada pelo aplicativo. Enquanto que, no grupo de intervenção I, três participantes não manifestaram interesse em participar da atividade com livros físicos na primeira abordagem, apenas uma criança rejeitou a realização da atividade quando mediada pelo aplicativo.

Os genitores registravam frequentemente as mediações das histórias, tanto com o aplicativo quanto com o livro físico, realizando fotografias e, em alguns casos, até videochamadas para familiares, a fim de compartilhar como as crianças estavam se divertindo com a atividade.

As crianças que utilizaram o livro físico solicitaram rever o material quando questionadas sobre o que mais haviam apreciado, abrindo as páginas e indicando os trechos que mais lhes chamaram a atenção. Algumas chegaram a tentar reproduzir por meio de desenhos os episódios destacados. Em contraste, as crianças que utilizaram o aplicativo não solicitaram revisitar as histórias.

Todas as crianças demonstraram apreço pela mesinha de apoio utilizada durante as mediações. Em determinadas ocasiões, o recurso chegou a ser solicitado para uso pessoal, evidenciando sua atratividade e funcionalidade no contexto das atividades.

Quando questionadas sobre como deixar o momento de intervenção mais divertido, as respostas das crianças indicaram que a inserção de elementos lúdicos adicionais, como desenho, brincadeiras com brinquedos (por exemplo, bonecos do Homem-Aranha), contação de histórias (particularmente de princesas) e jogos estruturados, como memória e quebra-cabeça, tornaria a atividade mais envolvente. A respeito do formato do jogo a ser disponibilizado, se digitalizado ou físico, a maioria disse que preferiria o jogo com peças físicas.

Esses dados sugerem que o enriquecimento das propostas pedagógicas e recreativas durante a hospitalização com recursos lúdicos variados pode potencializar o interesse, a motivação e o envolvimento das crianças em participar das intervenções.

4.6 Análise comparativa de desenhos da escala *Child Drawing: Hospital* entre os dois grupos no primeiro dia e segundo dia de intervenções

Os desenhos realizados pelos participantes nos primeiros dois dias de intervenção, em ambos os grupos, serão apresentados a seguir, com o objetivo de evidenciar suas percepções sobre “uma criança no hospital”. Conforme orienta a escala CD:H, foi solicitado o seguinte aos participantes: “*Desenhe a figura de uma pessoa no hospital... eu ficarei com o desenho quando você terminar*”. Observam-se mudanças discretas entre os desenhos do primeiro e do segundo dia.

Figura 25 - Benjamin Bunny
(1º dia/intervenção I)



Figura 26 - Benjamin Bunny
(2º dia/intervenção I)



Legenda: 1º dia: criança com acesso (pessoa de cor marrom), sentada em cadeira tomando soro e profissionais de saúde à sua volta (em amarelo e roxo). Era um dia de sol e a grama estava verde; 2º dia: o desenho mostra três pessoas: duas (em azul e laranja) parecem estar de pé, possivelmente médicos ou enfermeiros, e uma (em amarelo) está dentro de uma estrutura que lembra um biombo hospitalar. Todos estão sorrindo, o que sugere que a criança vê a situação de forma positiva ou tranquila.

Figura 27 - Tom Kitten (1º dia/intervenção I)**Figura 28 - Tom Kitten (2º dia/intervenção I)**

Legenda: 1º dia: Tom Kitten relatou que gostaria que tivesse duas geladeiras dentro de sua enfermaria: uma com comidas doces e outra com comidas salgadas. É uma criança palito que se encontra deitada na cama tomando soro, e próximo à cama, existem botões que otimizam a chegada dos alimentos. Tudo foi pintado na cor preta; 2º dia: Tom Kitten desenhou uma pessoa palito em pé, ao lado da cama, observando a janela. Tudo foi pintado de azul.

Figura 29 - Peter Rabbit (1º dia/intervenção I)**Figura 30 - Peter Rabbit (2º dia/intervenção I)**

Legenda: 1º dia: Peter Rabbit descreveu que a criança hospitalizada era portadora de diabetes tipo II, que é a sua patologia, relatando que não estava tomando os cuidados necessários com uso de insulina. Utilizou-se a cor vermelha de forma predominante, transmitindo um pouco de tensão na cena; 2º dia: Peter Rabbit apenas desenha a criança e informa que ela está no hospital, não detalhando informações sobre o seu quadro, utilizando de forma mais predominante a cor azul. O desenho transmite mais leveza e suavidade na cena, em comparação ao dia anterior.

Figura 31 - Mrs. Tiggy-Winkle
(1º dia/intervenção II)

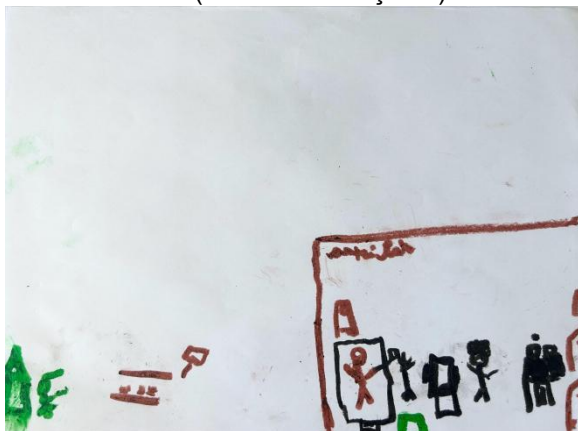
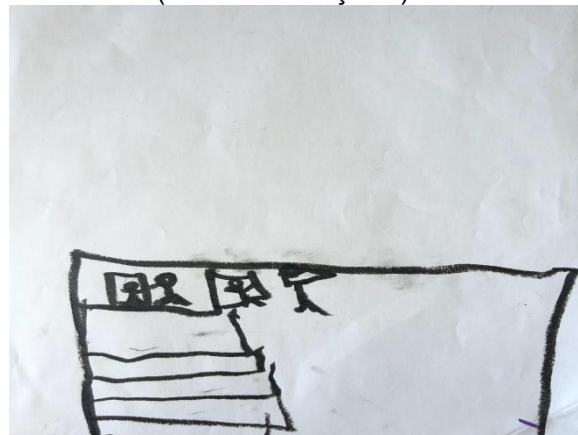


Figura 32 - Mrs. Tiggy-Winkle
(2º dia/intervenção II)

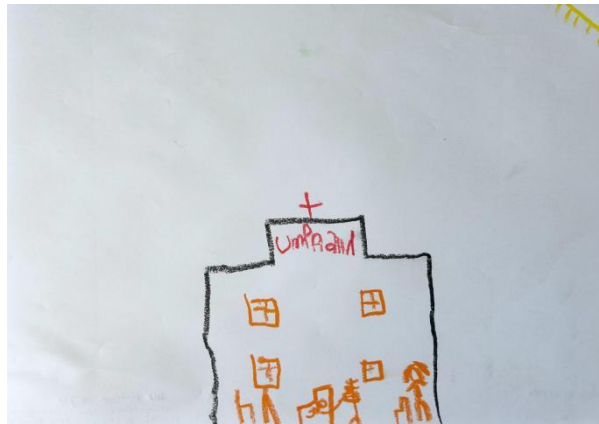


Legenda: 1º dia: Mrs. Tiggy-Winkle descreve que a criança desenhada estava em casa e sofreu uma queda da cama. Após isso, o pai da criança escutou barulhos, pois a criança estava chorando. O genitor correu para o hospital e, ao chegar lá, a criança “tomou agulha”. O desenho verde na lateral da folha usada é a casa da criança e uma árvore. Podemos observar que foi desenhada uma criança palito tomando soro (pessoa de cor marrom), um profissional de saúde com agulha na mão (pessoa de cor preta) e mais um acompanhante na cadeira (pessoa de cor preta); 2º dia: descreve a criança internada no último andar do prédio tomando soro, com a genitora deitada na cadeira de acompanhante e uma mesinha onde estão os alimentos (utiliza apenas a cor preta).

Figura 33 - Samuel Whiskers
(1º dia/intervenção II)



Figura 34 - Samuel Whiskers
(2º dia/intervenção II)



Legenda: 1º dia: Samuel Whiskers desenha criança (pessoa palito de cor laranja) com doença “muito séria”, deitada na cama do hospital tomando soro, e ao seu redor tem dois profissionais de saúde (pessoas palito de cor preta) cuidando dela para que melhore logo e possa ir para casa. Escreve o nome “UPA 24h” no topo do prédio, com janelas do prédio na cor roxa; 2º dia: Samuel Whiskers desenha criança (pessoa palito de cor laranja), acompanhante próximo à cadeira (pessoa palito de cor laranja) colorindo, repetindo a mesma cena do desenho anterior, porém sem profissionais de saúde. É, aparentemente, um cenário mais tranquilo.

Figura 35 - Jane (1º dia/intervenção II)**Figura 36** - Jane (2º dia/intervenção II)

Legenda: 1º dia: Jane desenhou uma criança deitada (pessoa palito de cor preta), descoberta, tomando soro. Ao lado da cama, um profissional de saúde, intitulado por ela como sendo “a médica” (pessoa palito de cor preta), administrando uma injeção. Ela utilizou apenas a cor preta em todo o desenho; 2º dia: Jane desenhou uma criança (pessoa de cor preta) deitada na cama, com fisionomia triste, com mãos segurando um lençol de bolinhas amarelas.

Os desenhos dos dois grupos refletem distintos níveis de ansiedade. A análise conjunta dos relatos descritivos e das próprias produções gráficas permite observar, entre o primeiro e o segundo dia, pequenas alterações nos contextos, nas cores e nos personagens representados.

Ademais, devemos nos atentar para o fato de que, por vezes, o nível de ansiedade das crianças está diretamente relacionado ao seu diagnóstico e às intervenções necessárias para o seu tratamento, ao número de vezes que são submetidas a determinados exames e procedimentos e, claro, ao próprio sofrimento ocasionado pela doença.

De forma semelhante, a contação de histórias, seja mediada através dos livros físicos ou por meio do aplicativo NaveghiBook, proporcionou momentos de distração, entretenimento e alívio, mesmo que de forma breve, nos dois encontros vespertinos realizados com esses seis participantes.

4.7 Desenhos referentes à escala *Child Drawing: Hospital*: os dois grupos

A seguir, apresentam-se os desenhos, referentes à escala CD:H, elaborados pelos 12 participantes que estiveram apenas no primeiro dia de intervenção, abrangendo ambos os grupos.

Figura 37 - Flopsy (1º dia/intervenção I)



Figura 38 - Miss Rose (1º dia/intervenção II)



Legenda: 1º dia: Flopsy desenhou uma criança (pessoa palito de cor marrom) vestida com blusa e saia tomando soro. Ela se encontra em pé e, ao seu lado, observamos um doutor (pessoa palito de cor marrom). No ambiente, podemos observar uma balança e uma fita métrica. Nas janelas do hospital, estão outras crianças que também estão internadas; 1º dia: Miss Rose desenhou uma pessoa (de cor preta) sendo levada ao hospital pelo caminhão dos bombeiros. O paciente em questão está com a perna quebrada e sofreu queimaduras, e também está com falta de ar. Ela também desenhou o céu, com o sol e algumas nuvens.

Figura 39 - Mopsy (1º dia/intervenção I)



Figura 40 - Appley Dapply (1º dia/intervenção II)



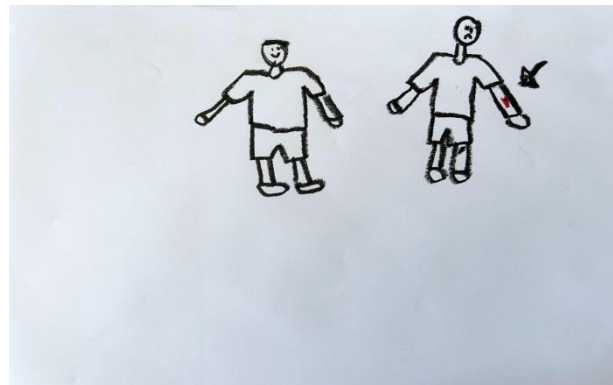
Legenda: 1º dia: Mopsy representou em seu desenho uma menina no hospital, relatando que a figura seria ela mesma, embora com algumas diferenças. A personagem foi retratada com cabelos lisos, de cor castanha e vestindo um vestido azul. Também incluiu a figura de um menino, que simboliza seu amigo, igualmente com cabelos castanhos e trajando um pijama hospitalar azul. Ao fundo, acrescentou a presença de uma enfermeira posicionada atrás, no posto de enfermagem; 1º dia: Appley Dapply descreve criança com catapora, com fisionomia triste (menina com cabelo preto, blusa verde e shorts amarelo), na sala de atendimento, que tem uma mesa e duas cadeiras: uma para a paciente e outra para a médica (com blusa roxa e shorts laranja).

Figura 41 - Mrs. Jeremy-Fischer(1º dia/intervenção I)**Figura 42** - Lucinda (1º dia/intervenção II)

Legenda: 1º dia: Jeremy-Fischer desenhou uma criança vestida com roupa vermelha dentro de um hospital. No ambiente desenhado, podemos observar uma cama (cor roxa), uma mesinha (cor verde), uma cômoda (cor amarela com laranja), uma porta (cor azul) e duas janelas (cor marrom); 1º dia: Lucinda desenhou uma criança em pé com vestido vermelho e cabelo preto com rabo de cavalo. Ao lado do hospital, que possui uma porta (cor azul) e duas janelas (cor verde), as paredes foram pintadas de laranja, amarelo e azul.

Figura 43 - Mr. Drake Puddle-Duck
(1º dia/intervenção I)**Figura 44** - Jemina Puddle-Duck
(1º dia/intervenção II)

Legenda: 1º dia: Mr. Drake Puddle-Duck descreve em seu desenho uma criança deitada na cama com dor de cabeça que, segundo ele, está passando mal. Ao redor da criança estão os pais (pessoas palito na cor laranja) à espera da criança e os doutores que foram ajudar a criança (pessoas palito de cor amarela); 1º dia: Jemina Puddle-Duck descreve uma “moçinha” no hospital que foi internada para fazer exames em seu coração. Para o exame, recebeu anestesia e não sentiu medo. A criança em questão se encontra deitada, sem cobertor e com o coração em evidência.

Figura 45 - Cotton-tail (1º dia/intervenção I)**Figura 46 - Simpkim (1º dia/intervenção I)**

Legenda: 1º dia: Cotton-tail descreveu seu desenho como uma menininha triste (pessoa palito de cor preta) tomando soro, deitada na cama, coberta com um lençol, porém transparente; 1º dia: Simpkim relata que foi bom com a criança do desenho e descreve que ela foi para o hospital apenas por ter machucado o braço em uma partida de futebol após tropeçar, buscando o atendimento médico apenas para chegar se realmente estava tudo bem, pois a criança estava normal.

Figura 47 - Tiimmy Tiptoes (1º dia/intervenção I)**Figura 48 - Miss Moppet (1º dia/intervenção II)**

Legenda: 1º dia: Tiimmy Tiptoes descreve uma criança palito (pessoa de cor preta) sentada em cadeira amarela e, ao seu lado, os seus genitores (pessoas palito de cor preta), sob a luz de uma lâmpada e a cruz símbolo do hospital no topo do prédio; 1º dia: Miss Moppet descreve que a criança (pessoa de cor marrom) e vestido roxo em pé está tomando soro após quadro de dor de barriga por ter ingerido um pirulito. A criança está com fisionomia triste devido à internação e ao adoecimento.

Fonte: desenhos produzidos pelos participantes da pesquisa.

4.8 As histórias do outro e as nossas histórias: um mural de delicadezas

Toda história possui a capacidade de nos transportar a novos espaços e, ao mesmo tempo, permite-nos revisitar universos já conhecidos, situações que evocam cenas do passado, e podem também revelar novas perspectivas e significados. Algumas das histórias analisadas nesta pesquisa foram expressas por meio de desenhos, os quais foram posteriormente comparados com situações vivenciadas descritas durante a entrevista, como será apresentado a seguir:

Figura 49 - Mopsy (grupo de intervenção I)



Fonte: desenhos produzidos pelos participantes da pesquisa.

[...] eu acho que ela só se identificou aí, porque ela também... nós só descobrimos o tumor dela por uma bolada que levou na testa (mãe de Mopsy, grupo de intervenção I, entrevista).

Mopsy desenhou a criança do livro “A grande cirurgia”. Nesse momento da história que foi desenhado, a criança obteve alta hospitalar, e as estrelas que estavam anteriormente em sua cabeça (sinal de dor utilizado de forma figurada) haviam voltado para o seu devido lugar, que é o céu. De alguma maneira, esse desejo de receber alta é algo comum em crianças hospitalizadas, para que possam se restabelecer em suas rotinas domiciliares e se verem livres das limitações ocasionadas pela doença.

A genitora de Mopsy ficou também emocionada ao relatar como a história “A grande cirurgia”, de alguma maneira, recordava a história do diagnóstico de tumor cerebral da filha, afirmando que a opção por desenhar essa história se deve ao fato de existirem algumas semelhanças entre Mopsy e a história em si.

Outra história citada por Mopsy e sua genitora, que apresenta uma realidade semelhante à vivenciada por elas, é “Quando sinto saudades”. A genitora lembrou que, todos os dias, no trajeto de casa para a escola, Mopsy se comporta como a personagem do livro ao se despedir da mãe após entrar no ônibus.

Sempre quando eu vou pro ônibus, eu gosto de dar tchau pra minha mãe, mandar beijo e fazer coração (Mopsy, grupo de intervenção I, entrevista).

A história “A grande cirurgia” foi novamente descrita como vivência semelhante à história do adoecimento do participante Samuel Whiskers, que possui diagnóstico de trauma ocular. O desenho foi feito devido à semelhança entre a parte do corpo que está doente. A seguir é realizada uma breve descrição sobre o desenho:

Figura 50 - Samuel Whiskers (grupo de intervenção II)



Fonte: desenhos produzidos pelos participantes da pesquisa.

[...] um menino que caiu e bateu a cabeça, aí ele... fiz ele com as estrelinhas aqui e o gol. Bateu a cabeça no chão e ele foi para o hospital. Aí, o doutor fez cirurgia com um monte de ferramentas, voltou para casa e descansou (Samuel Whiskers, grupo de intervenção II, entrevista).

Um terceiro participante também se identificou com a história ao notar que o local do acidente, descrito como um campo de futebol, também foi o seu. O trauma ocasionado em sua perna em um jogo de futebol com amigos evoluiu para uma osteomielite na perna direita.

Esse participante também machucou a perna num jogo de futebol com amigos, e recordou disso após ouvir a história (Mrs. Tiggy-Winkle, grupo de intervenção II, diário de campo).

De diferentes maneiras, as histórias foram se conectando com as vivências reais das crianças durante a hospitalização. Dessa vez, ocorreu o mesmo com a história “Erro no canto”, como podemos observar no relato a seguir:

Lucinda estava no pós-operatório de adenoamigdalectomia. Naquela tarde, uma das histórias que ouvimos foi “Erro no canto”, onde a narrativa mostra duas calopsitas que foram buscar atendimento médico, pois uma delas estava com dificuldade de cantar. Ao término da consulta, a Arara, que é a médica, oferece duas opções de tratamento: xarope de amora ou xarope de morangos silvestres. A calopsita opta pelo xarope de morango. Quando estava me despedindo, chegou o lanche que seria oferecido para Lucinda, e, coincidentemente, era uma vitamina de morango. De imediato, a acompanhante de Lucinda lembrou da história e incentivou a alimentação, comparando ao xarope de morango. Lucinda ingeriu boa parte do que foi oferecido após o argumento (Lucinda, grupo de intervenção II, diário de campo).

Por outro lado, ainda sobre a história “Erro no canto”, outro participante também teceu sobre semelhanças particulares que possui com a história. Encantou-se pelas calopsitas da história, pois possui uma família de calopsitas em casa, e descreveu os nomes de cada uma: Zeca, Bela, Paçoca e Branca. Elas tiveram três filhotinhos: Pipoca, Pirulito e Chico. Realizou-se o seguinte desenho de uma calopsita cantando (Figura 51):

Figura 51 - Jane (grupo de intervenção II)



Fonte: desenhos produzidos pelos participantes da pesquisa.

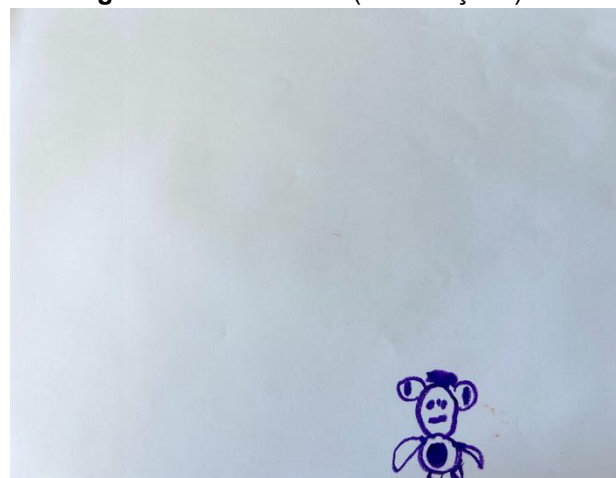
4.9 Memórias de um sonho: desenhando os personagens das histórias

Os participantes dos dois grupos desenharam as histórias preferidas. Em cada figura, podemos observar as cenas mais significativas ou que chamaram mais a atenção das crianças. Nos desenhos a seguir, podemos observar como elementos em destaque o arco-íris e os personagens principais da história “A família panda”:

Figura 52 - Flopsy (intervenção I)



Figura 53 - Cotton-tail (intervenção I)



Fonte: desenhos produzidos pelos participantes da pesquisa.

O interesse das crianças pelo arco-íris pode ser explicado pela combinação de fatores perceptivos, emocionais e simbólicos. A disposição sequencial das cores atrai

a atenção infantil, e a percepção de cada cor também exerce papel fundamental no desenvolvimento sensorial. Além disso, o arco-íris está frequentemente associado a narrativas culturais e elementos do imaginário coletivo, envolvendo a magia, a esperança e a alegria, potencializando a sua valorização no universo infantil.

Nas figuras a seguir, observamos a reprodução de desenhos inspirados no livro “Chapéus”. Nos três desenhos, destacam-se diferentes personagens e elementos. Na primeira imagem, reproduz-se a capa do livro, com a personagem principal, uma pintora de quadros que usa um chapéu. Na segunda ilustração, aparece um boneco de neve com touca. Por fim, na terceira imagem, são apresentados diversos chapéus mencionados no livro, como os de bombeiro, de médico, boné casual e touca.

Figura 55 - Peter Rabbit (intervenção I)



Figura 56 - Appley Daply (intervenção II)



Figura 57 - Jane (intervenção II)



Fonte: desenhos produzidos pelos participantes da pesquisa.

Os chapéus deixam as brincadeiras mais divertidas. Ao usar um chapéu, a criança pode imaginar que é outro personagem, como um astronauta, um cozinheiro ou um bombeiro. Além disso, os chapéus chamam atenção pelas cores, formatos diferentes e porque aparecem em muitas histórias infantis, sendo um elemento que nos ajuda a transitar por diferentes universos.

Nas seguintes figuras, podemos observar ilustrações que remetem ao livro *Penacho*. Os personagens em destaque são um índio com sua coroa de penas e dois monstros com características diferentes.

Figura 58 - Timmy Tiptoes (intervenção I)



Figura 59 - Peter Rabbit (intervenção I)



Figura 60 - Simpkim (intervenção I)



O fascínio infantil por índios e monstros pode ser explicado pela combinação de elementos visuais distintos, simbolismo lúdico e a narrativa de aventura. Enquanto os índios representam coragem e diversidade cultural, os monstros estimulam a curiosidade por meio de características inesperadas e fantasiosas. Esses personagens também reforçam aprendizagens sociais e emocionais, ao permitir que a criança explore identidades, desafios e comportamentos em contextos imaginativos.

Nas figuras a seguir, observamos os desenhos inspirados no livro “Erro no canto”. As calopsitas e o canto foram destacados no primeiro desenho, que também possui uma árvore. No segundo desenho, foram desenhados uma arara-azul e os morangos, para representar a médica e o xarope sabor morango, personagem e elemento que compõem a história. No terceiro desenho, observamos um ninho com duas calopsitas, recordando o lar descrito na narrativa.

Figura 61 - Mrs. Tiggy-Winkle (intervenção II)

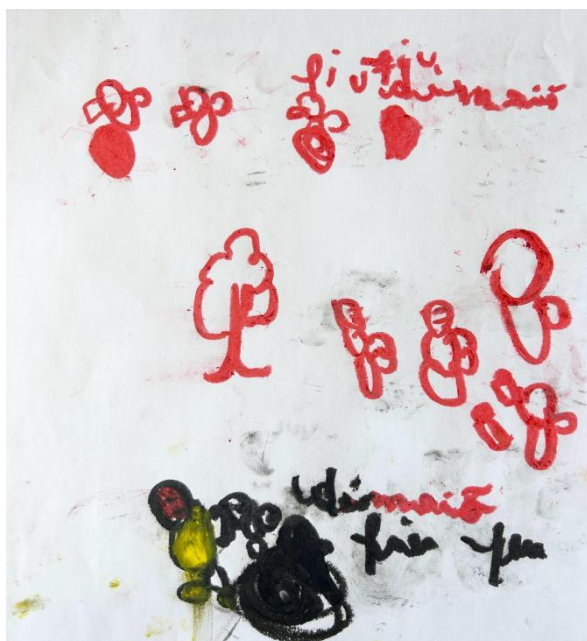


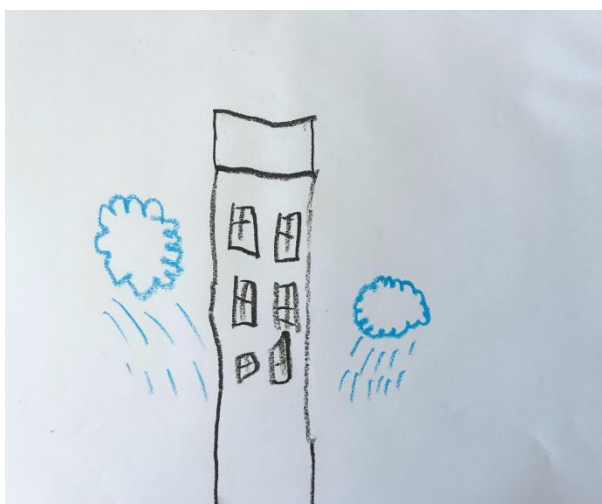
Figura 62 - Benjamin Bunny (intervenção I)



Figura 63 - Jane (intervenção II)

As crianças se encantam por calopsitas e araras devido às suas cores vibrantes, movimentos divertidos e sons interessantes, que despertam curiosidade. As calopsitas, por serem animais domésticos, permitem uma interação direta e afetuosa, o que aproxima ainda mais as crianças e fortalece o vínculo afetivo com a história. Como estamos na região Centro-Oeste, é comum no cotidiano infantil observar araras no entorno urbano ou rural e encantar-se pela imponência das araras. Todos esses fatores reforçam o fascínio e estimulam a imaginação e a criatividade das crianças.

Os desenhos a seguir representam a história “Quando sinto saudades”. As ilustrações feitas pelos dois participantes nas figuras abaixo destacam a mesma cena: quando a menina do livro diz se sentir triste ao descrever o sentimento de saudades dos familiares. A tristeza é simbolizada como um dia chuvoso na narrativa.

Figura 64 - Samuel Whiskers (intervenção II)**Figura 65** - Miss Rose (intervenção II)

Fonte: desenhos produzidos pelos participantes da pesquisa.

A escolha desse momento evidencia o reconhecimento e a interpretação de emoções significativas na narrativa. A utilização de elementos simbólicos, como o dia chuvoso, demonstra a capacidade das crianças de traduzir sentimentos em representações visuais, articulando percepção emocional, compreensão da narrativa e expressão artística.

Os desenhos a seguir representam a história “Meg e a viagem no tempo”. Os dois primeiros desenhos são representações da cachorrinha Meg: a protagonista da narrativa. O terceiro desenho mostra a cachorrinha em uma de suas aventuras: ela está nas costas de um Velociraptor, cercada por duas árvores. Por fim, o quarto desenho retrata a última cena do livro: Meg, após receber alta hospitalar, pensa: “E se eu pudesse viajar no tempo... de novo”.

Figura 66 - Miss Moppet (intervenção II)



Figura 67 - Appley Dapply (intervenção II)

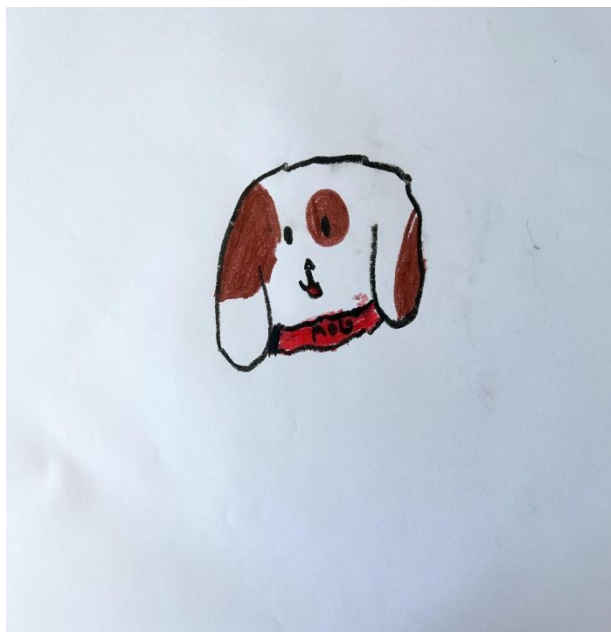
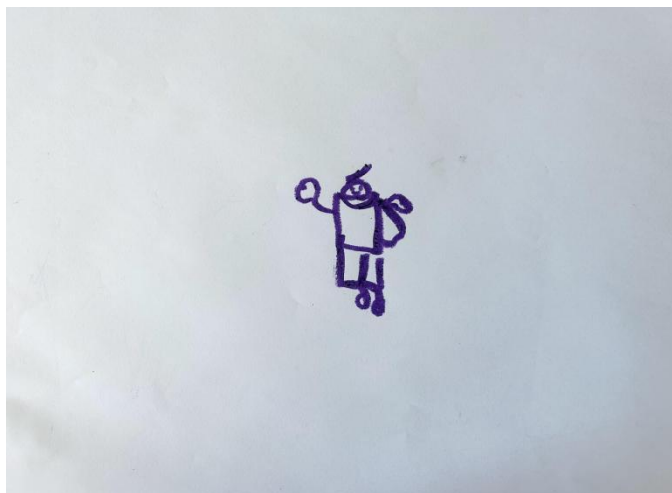


Figura 68 - Samuel Whiskers (intervenção II)**Figura 69** - Jane (intervenção II)

Fonte: desenhos produzidos pelos participantes da pesquisa.

Em histórias infantis, cachorros representam amizade, cuidado e empatia, conectando-se ao cotidiano das crianças. A narrativa os faz lembrar de seus próprios animais de estimação. Enquanto isso, os dinossauros despertam fascínio pela imponência e força, estimulando a imaginação e a curiosidade em um universo de fantasia. Essa história fez as crianças passearem por um território de esperança.

A ilustração feita por Mrs. Tiggy-Winkle, do grupo experimental, representa a história “Grandes heróis”. Ele desenhou, com traços simples, uma pessoa pequena com capa, aparentemente voando no ar.

Figura 70 - Mrs. Tiggy-Winkle (intervenção II)

Fonte: desenhos produzidos pelos participantes da pesquisa.

Esses personagens representam a coragem, a força e a capacidade de superar desafios. Além disso, a presença de poderes extraordinários e aventuras fantásticas estimula a imaginação, permitindo que a criança explore desejos de autonomia e controle de maneira lúdica.

O desenho feito por Mrs. Jeremy-Fischer, do grupo controle, foi inspirado no livro “Um dia de chuva”. O participante descreveu, em seu desenho, dois guarda-chuvas e um lobo, com o intuito de associá-lo ao ursinho protagonista da história. Os guarda-chuvas aparecem como elementos simbólicos que podem representar proteção, abrigo ou o contexto de um dia chuvoso.

Figura 71 - Mrs. Jeremy-Fischer (intervenção I)



Fonte: desenhos produzidos pelos participantes da pesquisa.

4.10 A presença do outro: um encontro de ternuras

No decorrer dos dias, alguns participantes desenharam a figura da pesquisadora de forma amigável e terna. No desenho a seguir, realizado por Peter Rabbit, encontram-se ele e a pesquisadora, em sua enfermaria. Na cena, estão com roupas iguais e ambos usando tiaras de orelha de raposa. Certamente, a presença se torna também um cuidado.

Figura 72 - Peter Rabbit (intervenção I)



Fonte: desenhos produzidos pelos participantes da pesquisa.

A mediação do adulto na contação de histórias é fundamental para o desenvolvimento afetivo da criança e para fortalecer vínculos. Por meio da interação, o adulto cria um ambiente acolhedor, estimulando a criança a expressar os seus sentimentos e compartilhar experiências, conectando-se emocionalmente com a narrativa e também com quem conta a história.

Outro participante também desenhou a figura da pesquisadora, detalhando a descrição do desenho da seguinte maneira: “Estamos juntos, eu, o pequeno robô Zipp e a senhora com a tiara de raposa”. O pequeno robô Zipp é um dos personagens principais da história “O pequeno viajante estelar”.

Figura 73 - Benjamin Bunny (intervenção I)



Fonte: desenhos produzidos pelos participantes da pesquisa.

A escolha da criança em desenhar a pesquisadora indica uma aproximação afetiva e de identificação com o mediador da atividade. Ao incluí-la na cena, a criança evidencia que percebeu sua presença como parte significativa da experiência de leitura e interpretação da história, reconhecendo a pesquisadora não apenas como observadora, mas como figura de referência e apoio durante a atividade. Esse desenho reflete a valorização do vínculo estabelecido, mostrando que a interação com o adulto contribuiu para a segurança emocional e para o engajamento da criança na construção narrativa.

No desenho a seguir, Jemina ilustrou-se segurando a mão da pesquisadora, ambas usando vestidos e tiaras de orelha de raposa, indicando uma relação de proximidade e confiança entre ambas. Essa escolha sugere que a criança percebeu a presença do adulto como acolhedora e significativa, associando a interação à sensação de segurança durante a atividade.

Eu desenhei eu e você dando as mãos com a tiara de raposinha
(Jemina Puddle-Duck, grupo de intervenção II, entrevista).

Figura 74 - Jemina Puddle-Duck (intervenção II)



Fonte: desenhos produzidos pelos participantes da pesquisa.

Jemina optou por fazer mais um desenho para a pesquisadora, mas, dessa vez, em forma de presente, descrevendo com ternura o desenho:

[...] eu falei que eu gostaria de te dar só por causa que eu não tinha aqui para te dar. Eu desenhei uma flor vermelha com o meio dela amarelo e o pauzinho de segurar verde e a folhinha do lado. E os corações grandão, que o seu é muito grandão pra caber bastante gente (Jemina Puddle-Duck, grupo de intervenção II, entrevista).

Esse gesto revela uma expressão espontânea de afeto e generosidade, evidenciando a forma como a criança atribui sentidos emocionais à experiência compartilhada. A flor e os corações funcionam como símbolos de cuidado, vínculo e reconhecimento, indicando que a pesquisadora foi percebida não apenas como mediadora da atividade, mas como alguém que ocupa um lugar significativo no campo relacional da criança. Na figura a seguir, podemos observar o desenho feito por Jemina:

Figura 75 - Jemina Puddle-Duck (intervenção II)



Fonte: desenhos produzidos pelos participantes da pesquisa.

4.11 Encantamento e a beleza na infância: traços de pequenas mãos

Após as intervenções, as crianças realizaram produções gráficas de caráter espontâneo. Após não conseguirem desenhar algo que não gostaram na intervenção, foi oferecida a possibilidade de realizarem desenhos livres. Esses registros foram frequentemente acompanhados pela elaboração de narrativas relacionadas às experiências de seu cotidiano, usando a articulação entre expressão estética e construção criativa para revelar anseios/desejos.

No desenho a seguir, Miss Moppet ilustrou um sorvete de casquinha com três sabores diferentes: morango, uva e banana. Os sabores selecionados foram descritos como a preferência atual e, de certa forma, representam o desejo pela sobremesa. Ao mesmo tempo, porém, trata-se de uma forma de comunicação que integra a imaginação, a emoção e a construção de significados.

Figura 76 - Miss Moppet (intervenção II)



Fonte: desenhos produzidos pelos participantes da pesquisa.

No desenho a seguir, Peter Rabbit ilustrou uma casa amarela com janelas abertas. Ao lado da casa, observa-se uma grande árvore, com uma copa vermelha, que nos lembra um Flamboyant, um gramado verde e um céu azul brilhante com nuvens. A combinação de cores e elementos evidencia um dia tranquilo do cotidiano, e pode nos direcionar para o possível desejo da criança para retornar para casa. Além disso, mostra-nos a capacidade da criança, mesmo em meio ao sofrimento, de realizar uma construção estética, usando a imaginação e a criatividade durante a hospitalização. Ao utilizar todo o espaço do papel, a criança evidencia autonomia e segurança.

Figura 77 - Peter Rabbit (intervenção I)



Fonte: desenhos produzidos pelos participantes da pesquisa.

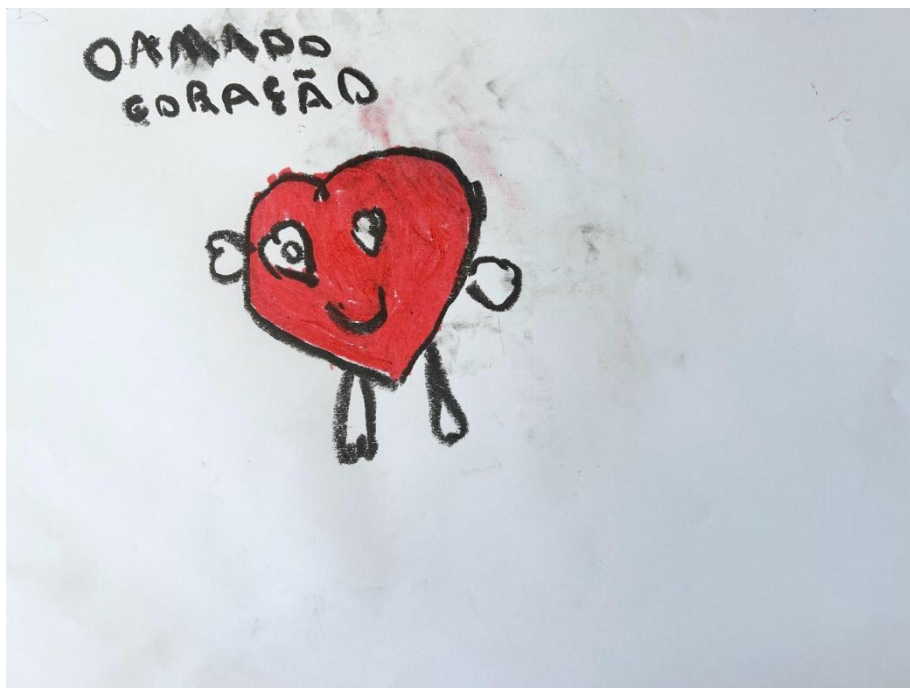
4.12 Duas formas de mediar histórias: um só encontro

Em uma das sessões de mediação realizadas com o grupo de intervenção II, após a utilização do aplicativo NaveghiBook, a participante Miss Rose relatou possuir um livro em sua enfermaria e expressou o desejo de que a pesquisadora realizasse a leitura da obra para ela.

O livro “O Amado Coração”, de Márcia Silva, apresenta uma narrativa de caráter metafórico que conta a história de um salvador que entrega a própria vida em favor do “amado coração”. A obra dialoga com temas como sacrifício, amor e doação, oferecendo às crianças uma experiência estética e afetiva que ultrapassa a literalidade do enredo, convidando à reflexão sobre valores humanos universais.

A obra é enriquecida por uma diversidade de ilustrações que retratam animais, florestas e pântanos, compondo cenários que ampliam o universo narrativo. Esses elementos visuais não apenas embelezam a narrativa, mas também desempenham um papel pedagógico, favorecendo a imaginação infantil, o contato com a natureza e a construção de significados a partir da relação entre texto e imagem.

Figura 78 - Miss Rose (intervenção II)



Legenda: observamos um coração vermelho com dois olhos e um sorriso, mãos, pés e o título do livro.

Fonte: desenhos produzidos pelos participantes da pesquisa.

Esse episódio evidencia a relevância da mediação como processo dialógico, no qual a criança não apenas participa da atividade proposta, mas também se apropria ativamente do espaço comunicativo, manifestando seus interesses e estabelecendo vínculos afetivos com a mediadora.

A participante Miss Rose relatou que o livro em questão já havia sido lido em diversas ocasiões por seus pais e irmãs, demonstrando familiaridade prévia com a narrativa. Ainda assim, insistiu para que uma nova leitura fosse realizada pela pesquisadora, revelando não apenas o desejo de reviver a experiência literária, mas também a importância da mediação enquanto ato relacional.

Durante a leitura, a criança antecipava acontecimentos da história, evidenciando sua memória narrativa através de sua capacidade de estabelecer previsões sobre o texto. Ao término da sessão, ao ser convidada a representar a experiência, Miss Rose escolheu desenhar uma cena do livro, destacando esse momento como o mais significativo para ela. Tal escolha sugere que a ênfase da experiência não esteve apenas no conteúdo literário, mas sobretudo no vínculo afetivo e simbólico construído no ato da leitura compartilhada.

4.13 Recontando histórias: inferências das crianças sobre as histórias

Quando as crianças recontam ou resumem uma história, evidenciam-se a apropriação do conteúdo narrativo e a construção de significados a partir do que foi lido. Esse processo demonstra que os elementos da narrativa foram assimilados de maneira significativa quando os participantes citam os personagens, lembram o enredo ou aspectos emocionais relacionados à história.

Ela sonhou que tinha passarinhos contando histórias para ela. Lavar as mãos para não pegar doença de COVID. Pesquisadora: quais foram os passarinhos que você reconheceu? Foi arara-azul, bem-te-vi, pica-pau (Tiimmy Tiptoes, grupo de intervenção I, entrevista, história “Quintal de Passarinho”).

Ela ficou doente. Fez um raio-X. Ela foi embora para casa e ela não conseguia mais voltar no tempo, mas ela estava feliz porque ela estava em casa (Miss Moppet, grupo de intervenção II, entrevista, história “Meg e a viagem no tempo”).

Uma cachorrinha que gostava muito [...] ela gostava muito de dinossauros e queria viajar ao tempo, e ela também gostava muito de ciências, mas só que ela acabou ficando doente e teve que ir no hospital. Ela teve que ficar internada, aí, toda vez que ela ia dormir, ela sonhava com dinossauros. E viajava no tempo. Pesquisadora: e o que aconteceu no final da história? Jane: ela voltou pra casa, conseguiu voltar aos seus experimentos, voltou pensando quando que vai voltar no tempo de novo (Jane, grupo de intervenção II, entrevista, história “Meg e a viagem no tempo”).

Tinha duas calopsitas, não era? Fifo e Filó. E aí uma ficou doente, não foi? E ela foi pra onde depois que ela ficou doente? Ela foi pro veterinário. Isso. E aí lá ela encontrou com quem? Com a arara e a arara-azul. Isso, tinha duas araras, né? Era uma médica e a outra era enfermeira. E aí ela passou um remedinho pra filó ficar melhor, não foi? E aí quais eram as opções, você lembra? O tuti-fruti e o morango. E aí ela escolheu o que? O morango. E depois, o que aconteceu no finalzinho da história? Ela voltou a cantar felizmente (Jane, grupo de intervenção II, entrevista, história “Erro no canto”).

Apreendi a sempre... ficar de repouso e não cantar antes da hora (Peter Rabbit, grupo de intervenção I, entrevista, história “Erro no canto”).

Bateu a cabeça no chão e ele foi para o hospital. Quando chegou lá, o médico falou que tinha que fazer uma cirurgia. E aí ele, aí ele tá com um monte de estrelinhas, tava vendo estrelinhas na cabeça dele. Aí o doutor fez cirurgia com um monte de ferramentas, voltou para casa e descansou (Mrs. Tiggy-Winkle, grupo de intervenção II, entrevista, história “A grande cirurgia”).

É, entendi que estava contando sobre Penacho, que é tipo o que te caracteriza, o que é você, tipo, se é legal, São coisas que caracterizam você (Simpkim, grupo de intervenção I, entrevista, história “Penacho”).

Recontar uma história funciona como uma forma de expressão ativa na qual a criança articula a memória, a compreensão e a criatividade, produzindo uma versão pessoal da narrativa. Essa reorganização e reelaboração das informações em sua própria linguagem favorecem o desenvolvimento cognitivo, de análise e síntese de conhecimentos.

5 DISCUSSÃO

Trata-se de estudo multimétodo. Inicialmente, são apresentados e discutidos os resultados qualitativos e, posteriormente, procede-se à discussão dos resultados quantitativos.

5.1 UM AMBIENTE SOCIOCULTURAL: HOSPITALIZAÇÃO INFANTIL NA CONTEMPORANEIDADE

5.1.1 Desenvolvimento infantil no período contemporâneo: repercussões para a hospitalização

Em nosso estudo, os resultados evidenciaram que a atividade de entretenimento mais apreciada pelas crianças durante a hospitalização é o uso do celular para assistir a vídeos e jogar. No contexto domiciliar, observou-se uma posição de destaque para essa mesma atividade, indicando continuidade desse padrão. Essa realidade pode representar um risco ao desenvolvimento infantil, uma vez que limita a diversidade de experiências fundamentais para o crescimento e a aprendizagem.

Além disso, o conteúdo acessado, conforme evidenciado em nosso estudo, não é em sua maioria produzido especificamente para o público infantil. Somado a isso, a navegação livre por plataformas de jogos e ambientes digitais abertos expõe as crianças a potenciais riscos, considerando a variedade de práticas nocivas que podem ocorrer nesse espaço pouco regulado que é a internet. A situação se agrava quando esse uso ocorre sem a supervisão de um adulto e sem a delimitação de tempo.

Quanto ao hábito de leitura, metade da amostra afirma praticá-lo, enquanto uma parcela significativa o realiza apenas ocasionalmente, e um terço diz não ler. Embora a leitura pudesse constituir uma alternativa enriquecedora no contexto de hospitalização, observa-se que ela é utilizada ou estimulada apenas esporadicamente, permanecendo restrita ao ambiente escolar.

A própria hospitalização, somada às condições clínicas decorrentes do adoecimento, impõe limites importantes às crianças no que diz respeito ao seu bem-estar geral. No entanto, esses fatores não devem se tornar obstáculos para a formulação de intervenções que integrem o brincar como instrumento de promoção do desenvolvimento. Para Vygotsky (1999), o desenvolvimento infantil ocorre fundamentalmente por meio das interações sociais e das experiências mediadas, sendo o brincar uma das principais formas de favorecer o desenvolvimento na infância. Dessa forma, devemos adaptar novas maneiras de brincar no hospital.

A SBP (2024) reforça que a saúde infantil depende da interação real da criança com os cuidadores, enfatizando o perigo da exposição excessiva a telas e a necessidade de refletir sobre a infância no contexto contemporâneo digital, juntamente às suas repercussões sobre o crescimento e desenvolvimento infantil.

Em seu último documento sobre o tema, a SBP (2024) recomenda evitar completamente o uso de telas em crianças menores de 2 anos. Para crianças de 2 a 5 anos, deve-se limitar o tempo de tela a no máximo uma hora por dia, sempre com supervisão de pais ou responsáveis. Para crianças de 6 a 10 anos, deve-se limitar a uma ou duas horas por dia, também com supervisão constante (Sociedade Brasileira de Pediatria, 2024).

O uso excessivo de telas por crianças e adolescentes está associado a diversos impactos negativos à saúde, incluindo dependência digital, alterações emocionais (como ansiedade, depressão e irritabilidade), transtornos do sono, déficit de atenção, isolamento social, sedentarismo, distúrbios alimentares, *cyberbullying*, problemas de imagem corporal, além de riscos relacionados à sexualidade (como abuso sexual e estupro virtual), comportamentos autolesivos, prejuízos visuais e auditivos, e alterações posturais (Sociedade Brasileira de Pediatria, 2024).

Esses achados, destacados pela SBP (2024), reforçam a necessidade de limitar o tempo de tela, promover atividades alternativas e incentivar a mediação de cuidadores para diminuir os efeitos adversos das mídias digitais no desenvolvimento infantil (Sociedade Brasileira de Pediatria, 2024).

Nesse contexto sobre tempo de uso de telas, estudo evidenciou que crianças hospitalizadas permanecem, em média, seis horas por dia em frente às telas, tempo superior ao limite recomendado pela *American Academy of Pediatrics*. O uso

simultâneo de mais de um dispositivo, a dificuldade de interromper o uso da mídia, o menor emprego de técnicas de disciplina positiva pelos cuidadores, a ausência de regras claras sobre o uso de telas e a escassa visualização com interação verbal entre a criança e o responsável foram identificados como fatores associados ao uso prolongado (Chaiseksamphan; Chonchaiya, 2022).

Entre os principais motivos relatados pelos cuidadores para o uso das mídias durante a hospitalização, destacam-se a necessidade de ajudar a criança a relaxar e a falta de alternativas de entretenimento no ambiente hospitalar (Chaiseksamphan; Chonchaiya, 2022).

Corroborando esse raciocínio, Gromyko (2023) descreve que a interação excessiva com dispositivos digitais acaba sendo uma via de isolamento, indo em sentido contrário à vivência de experiências naturais e sociais fundamentais para o desenvolvimento infantil.

O ambiente artificial sobrecarrega a criança com estímulos visuais desconexos e desvinculados da vida cotidiana, reduzindo o contato direto com adultos, familiares e outras crianças. Esse processo interrompe a comunicação social e empobrece as interações educativas/culturais (Gromyko, 2023).

Para o uso diligente dessas ferramentas, são necessárias estratégias como a promoção da disciplina positiva, a estimulação da visualização conjunta com diálogo e a oferta de uma maior diversidade de atividades durante a hospitalização, que podem contribuir para diminuir os efeitos adversos do uso excessivo de telas em crianças hospitalizadas (Chaiseksamphan; Chonchaiya, 2022).

É necessário, sobretudo, ter uma consciência crítica sobre os padrões de *design* manipulativos construídos para o público infantil que prendem a atenção da criança e estimulam comportamentos artificiais. Assim, em vez de a aprendizagem social guiar o desenvolvimento, a criança passa a ter seu comportamento moldado pela lógica das telas e algoritmos, o que subordina seu aprendizado e pode comprometer seu desenvolvimento emocional, cognitivo e relacional (Gromyko, 2023).

Dessa maneira, coadunando os artigos supracitados e diante do aumento de casos e denúncias que ganharam repercussão nacional, intensificaram-se as discussões políticas e sociais acerca da necessidade de proteção jurídica a crianças e adolescentes no ambiente digital. Como resposta, em 2025, foi sancionada a Lei nº

15.211, de 17 de setembro de 2025, conhecida como Estatuto Digital da Criança e do Adolescente, que dispõe sobre a proteção de menores em ambientes virtuais (Brasil, 2025).

Esse marco regulatório atualiza e amplia a proteção prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente e na Lei Geral de Proteção de Dados, estabelecendo diretrizes para a privacidade, a segurança, a supervisão parental e o uso responsável das mídias digitais, além de responsabilizar as empresas de tecnologia pelos conteúdos e serviços disponibilizados a esse público (Brasil, 2025).

Dessa forma, todos esses aspectos e reflexões devem ecoar nos cenários de cuidado e atendimento infantil, sendo pensados enquanto elementos primordiais para a construção de novos caminhos que permitam às crianças desfrutarem de um ambiente acolhedor, humano e saudável, para que possam vivenciar plenamente o seu desenvolvimento integral durante a hospitalização.

É pensando nisso que o estudo Karisalmi (2025) evidenciou que os serviços digitais hospitalares oferecidos através de um *tablet* personalizado têm potencial para melhorar a experiência de pacientes pediátricos e de suas famílias, oferecendo entretenimento, informação e suporte durante a internação. Além de promover uma estadia mais agradável, os *tablets* personalizados podem contribuir para experiências positivas no atendimento hospitalar.

No entanto, a construção de alternativas de entretenimento para crianças durante a hospitalização é desafiadora, pois solicita um processo contínuo de investimento, elaboração e avaliação, ao passo que deve considerar as individualidades pertinentes às diferentes faixas etárias e às próprias características socioculturais das crianças e dos cuidadores (Karisalmi, 2025).

Apesar disso, diante do cenário atual, cabe às instituições estruturar protocolos e rotinas que combinem recursos multimodais com mediação qualificada para familiares e profissionais, privilegiando propostas interativas, esteticamente potentes e de qualidade, alinhadas ao diagnóstico clínico da criança, à faixa etária e ao tempo de internação, para que o entretenimento também seja um cuidado, um encontro e um espaço real para a formação e o fortalecimento de leitores, mesmo em situação de vulnerabilidade.

5.1.2 Caminhos para o brincar no hospital se tornar efetivo

A rotina durante a hospitalização infantil é moldada por uma realidade diversa àquela que a criança vive no cotidiano em seu domicílio. No contexto hospitalar, os exames, as consultas e os procedimentos se tornam uma realidade constante. Entretanto, a possibilidade de brincar, muitas vezes, é descartada durante o adoecimento infantil, apesar de o brincar contribuir para o desenvolvimento de elementos essenciais na infância, favorecendo a sensação de segurança em novos ambientes e com indivíduos desconhecidos. É através do brincar que a criança entra em um processo de organização da realidade e da expressão criativa (Carvalho e Sousa *et al.*, 2015).

Estudo realizado por Cosme e Cruz (2025) demonstra que, quando disponibilizada, a ludoterapia favorece a socialização, estimula a criatividade e fortalece a autoestima, configurando-se como parte essencial para um cuidado humanizado. Nesse mesmo estudo, os autores evidenciaram que o uso excessivo de dispositivos eletrônicos, como forma de entretenimento durante a hospitalização infantil, pode comprometer o desenvolvimento emocional e a saúde mental das crianças.

A solução apontada é a ampliação do investimento em recursos materiais e humanos, bem como a capacitação dos profissionais, para que práticas lúdicas sejam implementadas no contexto assistencial. Essa integração possibilita promover maior engajamento emocional das crianças, favorecer a socialização e contribuir para o fortalecimento do bem-estar durante o período de hospitalização (Cosme; Cruz, 2025).

É preciso lembrar que a criança aprende a viver brincando, pois através dessa atividade são construídas maneiras de enfrentar e viver diferentes realidades (SOUSA *et al.*, 2021). Para Vygotsky (1991), o brincar é central no desenvolvimento socioemocional, pois possibilita à criança organizar funções cognitivas, como a linguagem, o autocontrole e o pensamento abstrato. Ademais, por meio da mediação de adultos ou cuidadores, a criança supera suas capacidades, internaliza normas sociais, explora regras e experimenta diferentes papéis.

O estudo realizado por Motta e Enumo (2004) descreve que brincar é um recurso eficaz para enfrentar a hospitalização. Além disso, aponta a necessidade de

apoio institucional através de profissionais qualificados e materiais adequados, pois, sem o investimento e o comprometimento efetivo das instituições, a possibilidade de brincar durante a hospitalização se torna menos factível.

O conhecimento sobre o desenvolvimento infantil e a respeito da diversidade de possibilidades de práticas lúdicas que podem ser oferecidas no atendimento pediátrico é essencial para os profissionais que atuam em serviços pediátricos, sendo responsabilidade das instituições oferecer treinamento adequado visando um cuidado integral (Godino-láñez, 2020).

Atualmente, a realidade dos hospitais públicos em relação ao entretenimento infantil é bastante limitada. Muitas unidades carecem de espaços adequados, materiais lúdicos e programas estruturados voltados ao brincar, restringindo a oferta dessa prática às poucas iniciativas pontuais ou dependentes de projetos externos. Assim, o atendimento continua focado principalmente em aspectos clínicos, deixando em segundo plano a importância do lazer e da ludoterapia como parte do cuidado integral.

Para que o brincar seja incorporado de forma efetiva no ambiente hospitalar, são necessários um investimento consistente e um replanejamento estratégico dos espaços físicos e das práticas assistenciais. Isso inclui a criação de ambientes específicos para as atividades lúdicas, aquisição de materiais adequados e capacitação contínua das equipes de saúde.

Além disso, é fundamental que haja integração entre diferentes setores e profissões para estruturar ações coordenadas que favoreçam a prática lúdica. O planejamento também deve considerar políticas institucionais que garantam recursos humanos e financeiros, permitindo que o brincar se torne parte sistemática do cuidado pediátrico, não apenas uma ação eventual (Ciuffo, 2023).

Apesar da existência da Lei nº 11.104, de 21 de março de 2005, que estabelece a obrigatoriedade da instalação de brinquedotecas em unidades de saúde que ofereçam atendimento pediátrico, observa-se que sua implementação ainda ocorre de forma desigual e, em muitos casos, limitada. Essa realidade evidencia desafios relacionados à efetivação da política pública, seja pela insuficiência de recursos materiais e humanos, seja pela ausência de profissionais capacitados para mediar as

atividades lúdicas, comprometendo o pleno exercício do direito da criança de brincar no contexto hospitalar (Brasil, 2005)

Além disso, o uso de brinquedo terapêutico também foi estabelecido através da Resolução nº 546, de 09 de maio de 2017, em todas as unidades de saúde que ofereçam atendimento pediátrico em regime de internação; entretanto, a realidade mostra que nem todos os hospitais cumprem essa determinação (Cofen, 2017).

Essa lacuna entre a legislação e a prática compromete o direito das crianças hospitalizadas ao acesso às atividades de entretenimento, prejudicando seu bem-estar e seu desenvolvimento durante o processo de internação.

5.2 EMOÇÕES E SENTIMENTOS: OLHARES E PERCEPÇÕES INFANTIS SOBRE O APLICATIVO

5.2.1 Emoções e sentimentos durante a hospitalização infantil

Os desenhos dos estudos realizados por Gomes *et al.* (2012) e por Souza *et al.* (2021) demonstram a percepção das crianças sobre a hospitalização como uma “situação de prisão”, caracterizando uma experiência emocional de sofrimento que foi vivida por muitas crianças. Esse sentimento surge, pois, durante a internação, elas enfrentam restrições físicas e sociais, como a impossibilidade de sair livremente do quarto ou da unidade hospitalar, a limitação de movimento devido a procedimentos ou dispositivos médicos usados durante o tratamento, o afastamento de familiares e a restrição do brincar.

Essa condição gera sensação de confinamento, perda de autonomia e frustração, intensificando emoções como tristeza, ansiedade e insegurança. Assim, para a criança, o hospital deixa de ser apenas um espaço de tratamento e passa a representar um ambiente de isolamento, impactando diretamente seu bem-estar emocional e sua experiência de cuidado.

Reconhecer e compreender essas vivências abre caminhos para um cuidado sensível, que é capaz de ir além do atendimento clínico, integrando diferentes estratégias para aliviar a ansiedade, favorecer a expressão emocional e promover o

acolhimento. Esse cuidado exige planejamento e deve, sobretudo, ser construído por diferentes categorias no âmbito institucional.

Estudo qualitativo, realizado com crianças hospitalizadas, utilizou entrevistas com pinturas para analisar suas experiências durante a internação, identificando fatores agradáveis e desagradáveis. Entre os aspectos positivos, destacaram-se o comportamento acolhedor de enfermeiros e médicos, um ambiente alegre e amigável, instalações adequadas e a possibilidade de brincar (Abazari, 2025).

Entre os aspectos negativos, as crianças citaram a restrição de movimento, os procedimentos dolorosos, a falta de acesso à televisão e a hospitalização no turno da noite. Esses achados ressaltam a importância de compreender a perspectiva infantil para promover um cuidado mais sensível, humanizado e adaptado às necessidades emocionais das crianças, reforçando a necessidade de comunicação efetiva entre profissionais de saúde e pacientes pediátricos (Abazari, 2025).

Os achados do presente estudo corroboram as evidências da literatura, evidenciando que o medo relacionado aos procedimentos hospitalares se manifesta nos desenhos das crianças, que frequentemente representam o uso de soro e a punção venosa. Além disso, observam-se expressões de desejo por alimentos preferidos e representações gráficas com traços faciais demonstrando tristeza ou, em alguns casos, a ausência completa de traços, refletindo o impacto emocional vivido durante a hospitalização.

Ensaio clínico randomizado por Abdi *et al.* (2025) comparou o efeito da ludoterapia e da contação de histórias na redução da ansiedade de 75 crianças hospitalizadas (3-10 anos). Os resultados indicaram que ambos os métodos são eficazes, mas a contação de histórias mostrou um impacto significativamente maior na redução da ansiedade, especialmente em crianças de 3-8 anos.

Observou-se ainda que fatores como idade, gênero e histórico prévio de hospitalização influenciam o efeito das intervenções. O estudo ressalta a contação de histórias como uma abordagem de baixo custo, prática e adaptável, recomendando sua implementação nos serviços de cuidado ao público pediátrico, com atenção às diferenças etárias e de gênero, para maximizar os benefícios terapêuticos (Abdi *et al.*, 2025).

Corroborando as estratégias já citadas para um cuidado sensível ao público pediátrico durante a hospitalização, estudo com 52 crianças hospitalizadas avaliou o efeito da música instrumental na redução da ansiedade e demonstrou que, após o segundo e o terceiro dias de intervenção, houve uma diminuição significativa nos escores de ansiedade, na frequência respiratória e uma melhora em outros sinais vitais (Hakim, 2023).

Em nosso estudo, entre as crianças que participaram dos dois dias de intervenção (I e II), observou-se uma redução dos níveis de ansiedade tanto nos escores totais da escala CD:H quanto nas transformações identificadas nos desenhos produzidos no primeiro e no segundo dia. Ainda que sutis, essas mudanças revelam indícios de uma modulação emocional decorrente da experiência mediada pela narrativa.

Estudo qualitativo realizado na Espanha explorou a hospitalização pela perspectiva das crianças por meio de entrevistas e desenhos, com o objetivo de compreender suas experiências emocionais durante o processo. Três temas principais surgiram: emoções e sentimentos, como medo, ansiedade e solidão; experiências de dor e desconforto; e interações com a equipe médica, que apontaram para a necessidade de uma comunicação clara e adequada às diferentes faixas etárias. Os resultados destacam a importância do cuidado centrado na criança, com estratégias como arteterapia, horários de visita flexíveis e comunicação adaptada ao desenvolvimento infantil, além do envolvimento familiar. O estudo aponta que tais abordagens podem melhorar significativamente o bem-estar emocional e psicológico de crianças hospitalizadas, recomendando pesquisas futuras para avaliar o impacto dessas intervenções e explorar sua integração à prática clínica pediátrica (Sillero *et al.*, 2024).

Com o intuito semelhante de ouvir as crianças, em nosso estudo, após as intervenções com histórias em formatos físico e digital, elas foram convidadas a fazer um desenho a partir da escala CD:H, representando uma criança no hospital. Em seguida, puderam narrar suas próprias experiências de adoecimento ou criaram histórias fictícias a partir da imagem produzida. Assim, observamos altos prédios e suas janelas, grandes camas e pequenas crianças à espera de algo, além do acessório mais presente: a infusão venosa através do acesso periférico.

Esse momento de escuta qualificada, em que a criança encontra tempo, espaço e acolhimento para expressar sua voz, seus afetos e sua perspectiva sobre a hospitalização, constitui um elemento fundamental para a humanização do cuidado, favorecendo a compreensão da experiência de internação.

Para Vygotsky, o desenho e as histórias infantis funcionam como instrumentos culturais que permitem à criança transformar vivências emocionais em significados compartilháveis, reorganizando afetos e ampliando sua capacidade de interpretar o mundo (Vygotsky, 2010)

Certamente, quando a criança converte sua experiência de adoecimento em imagem e em história, ela não apenas externaliza emoções, mas também reconstrói cognitivamente a situação vivida, tendo consciência dessas emoções e suas significações (Vygotsky, 1999). Esse processo, segundo o autor, é fundamental para o desenvolvimento, pois possibilita a passagem da ação para a consciência, fortalecendo a autonomia emocional e intelectual da criança.

Discussão dos resultados quantitativos:

Os níveis de ansiedade no presente estudo foram analisados a partir dos desenhos da escala CD:H dos participantes dos grupos de intervenção I e II. Apenas três crianças de cada grupo realizaram as atividades previstas para o primeiro e o segundo dia, totalizando seis participantes. A comparação das pontuações e das classificações obtidas indicou redução da pontuação total da escala CD:H em todos os seis participantes; contudo, somente três deles apresentaram mudança no nível de ansiedade.

Observou-se, ainda, que ambos os grupos demonstraram diminuição dos escores totais da escala CD:H do primeiro para o segundo dia de intervenção. O grupo de intervenção I apresentou redução média de 17 pontos, enquanto o grupo de intervenção II registrou redução média de 13 pontos. Esses resultados indicam que a redução da ansiedade ocorreu de maneira semelhante nos dois grupos. Ademais, observou-se que a média das pontuações diminuiu de 111,17, no primeiro dia, para 95,50, no segundo dia, o que indica uma redução geral da ansiedade ao longo do período. O teste t pareado mostrou que essa diferença foi estatisticamente

significativa ($t=3,51$; $p=0,017$), ou seja, a redução não ocorreu por acaso, mas representa uma mudança real nos níveis de ansiedade.

Estudo realizado estudo por Onur *et al.* (2020) demonstrou que a análise dos desenhos infantis, avaliada por meio da escala CD:H e dos indicadores emocionais do Desenho da Figura Humana, apresentou correlação negativa significativa com a escala de Frankl. Indicou-se que desenhos com maior carga emocional negativa estiveram associados a níveis mais elevados de ansiedade e a comportamentos menos cooperativos durante o atendimento odontológico, o que evidencia que os desenhos são sensíveis para identificar e refletir o estado emocional, assim como o grau de ansiedade das crianças no contexto odontopediátrico (Onur *et al.*, 2020).

Corroborando esse achado, estudo transversal avaliou 100 crianças de 6 a 8 anos submetidas a tratamento endodôntico, realizado por Mahale *et al.* (2024), e investigou a relação entre ansiedade odontológica e quociente de inteligência. A ansiedade foi mensurada por meio de desenhos infantis analisados pela escala CD:H, e evidenciou correlação estatisticamente significativa, indicando que os desenhos foram sensíveis para identificar a ansiedade das crianças e sua relação com aspectos cognitivos.

Estudo de validação para a versão turca realizado por Çelik *et al.* (2025) indica que a escala CD:H apresenta validade e confiabilidade para avaliação da ansiedade odontológica em crianças de 5 a 12 anos, destacando que o uso do desenho constitui um recurso eficaz para identificar a dor e a ansiedade no contexto odontológico.

5.2.2 Fatores que influenciam o uso do aplicativo para crianças

Para Vygotsky (2010, p. 120), “a criança está sempre brincando, ela é um ser lúdico, mas a sua brincadeira tem um grande sentido. [...] Pode-se dizer sem exagero que quase todas as nossas reações mais importantes e radicais são criadas e elaboradas no processo da brincadeira infantil.”

É pensando nisso que o uso de tecnologias digitais precisa ser compreendido como um novo cenário possível onde o brincar acontece. Nesse cenário, o que se torna determinante é o tipo de atividade lúdica que a tecnologia viabiliza e a qualidade

da mediação humana nessa atividade, de modo que a criança possa atuar como sujeito principal, criando, narrando e significando os processos, e não apenas consumindo passivamente conteúdos.

Quando foi oferecida às crianças a possibilidade de ouvir histórias por meio do aplicativo, observou-se uma aceitação imediata e proativa, pois demonstraram curiosidade e manipularam a interface com familiaridade. Esse movimento não pode ser entendido apenas como um interesse pontual pelo “novo”, mas se relaciona ao contexto contemporâneo fortemente permeado pela tecnologia, em que *tablets* e celulares já fazem parte do repertório cotidiano da infância.

Assim, a adesão espontânea ao aplicativo indica que as crianças reconhecem os dispositivos digitais como um novo ambiente no qual é possível brincar e que, de alguma forma, já se estabeleceu como uma extensão de seus cenários habituais de interação.

Em revisão sistemática, Jurdi *et al.* (2018) analisaram como as tecnologias de jogos vêm sendo aplicadas em contextos de hospitalização pediátrica, evidenciando que existem lacunas sobre sua utilização. Além disso, enfatizam a importância de adotar estratégias colaborativas, capazes de reduzir o isolamento social, além de integrar pais, cuidadores e equipes de saúde no processo lúdico. Ainda neste estudo, Jurdi *et al.* (2018) sugerem que futuras iniciativas considerem as necessidades emocionais relacionadas à hospitalização prolongada.

Em nosso estudo, observamos que a participação dos cuidadores na mediação das histórias pelo aplicativo NaveghiBook se tornou mais evidente nos momentos em que o áudio foi reproduzido sem o uso de fones de ouvido. Nesses casos, mesmo sem visualizar a tela, os cuidadores escutavam a narrativa junto à criança, o que favoreceu não apenas a interação, mas também a criação de um clima afetivo de compartilhamento, capaz de gerar identificação, acolhimento e sentimentos de estima pelas histórias.

Corroborando essa perspectiva, Ferreira e Junior (2021) descrevem a necessidade de incluir os usuários e cuidadores no processo de criação e aperfeiçoamento de aplicativos, especialmente quando o público são crianças e adolescentes hospitalizadas. A compreensão de suas especificidades será essencial

para alcançar melhorias reais no quadro clínico, favorecendo a melhora na qualidade de vida e no prognóstico a partir de aplicações direcionadas.

É necessário pensar em tecnologias que tenham como objetivo ir além do entretenimento infantil e favorecer a aprendizagem, o pensamento crítico, o enfrentamento emocional, o estabelecimento de relações interpessoais e a mobilidade motora durante a internação, possibilitando, de forma simultânea, a interação virtual e física com o ambiente (Jurdi *et al.*, 2018).

Para Vygotsky, as intervenções para crianças devem favorecer a imaginação criativa, pois será a partir dela que as crianças vão “exercitar seus impulsos e hábitos criativos, dominar a linguagem humana, a ferramenta mais sutil e complexa para formular e transmitir os pensamentos humanos, seus sentimentos, o mundo interior do homem” (Vygotsky, 2014, p. 85).

Em revisão de escopo, foi evidenciado que a avaliação do uso de tecnologias digitais deve se atentar, sobretudo, à exposição precoce, ao acesso às telas no horário noturno e ao uso sem supervisão de adultos. Esses fatores mostraram ser indicadores mais completos do que a simples quantificação das horas de tela (Selak; Horvat; Zmavc, 2025).

Selak, Horvat e Zmavc (2025) destacam a necessidade de realizar futuros trabalhos que permitam a inclusão de medidas confiáveis para melhor compreender os efeitos do uso das mídias digitais pelas crianças e seus contextos familiares. Outrossim, Rega, Gioia e Boursier (2023) destacam que o campo de estudo na área de problemas relacionados ao uso de mídias digitais ainda é incipiente, demandando mais investigação, inclusive pela escassez de instrumentos de autorrelato adequados para captar a perspectiva das crianças.

O uso de ferramentas lúdicas e de conversa dialogada permitiu que a criança descrevesse, à sua maneira, suas percepções, sentimentos e pensamentos. A interação mediada por desenhos e figuras, como a escala de Likert, otimiza as respostas e torna o momento da entrevista mais agradável para elas.

Portanto, para melhor compreender os fatores que influenciam o uso de tecnologias digitais, os problemas e os benefícios relacionados ao seu uso, é preciso buscar diferentes vias que permitam uma visualização das perspectivas infantis de

forma individualizada. Além disso, é preciso também compreender o contexto social no qual cada criança cresce e a sua rede de cuidadores (Rega; Gioia; Boursier, 2023).

Priorizar que as crianças descrevam as suas experiências por meio de desenhos nos permitiu, neste estudo, acessar conteúdos afetivos e percepções dificilmente verbalizáveis na infância, oferecendo uma via expressiva compatível com o nível de desenvolvimento. Essa estratégia, acompanhada de uma mediação verbal sensível, permitiu-nos evidenciar diferentes aspectos que envolvem o uso de um aplicativo para mediação de histórias infantis.

Além disso, em nosso estudo, as crianças que tiveram contato com o livro impresso demonstraram maior interesse em retomar o material quando questionadas sobre os aspectos que mais apreciaram, folheando as páginas e apontando as passagens que mais lhes despertaram atenção. Algumas buscaram representar, por meio de desenhos, os episódios que consideraram mais significativos. Em contrapartida, as crianças que utilizaram o aplicativo não manifestaram o desejo de revisitar as narrativas apresentadas.

Diante desse contexto, observa-se que o suporte utilizado para a mediação das histórias influencia diretamente a forma como as crianças se relacionam com o conteúdo. Enquanto o livro físico favoreceu uma interação mais ativa, reflexiva e duradoura, evidenciada pelo desejo de revisitar o material, pela exploração espontânea das páginas e pela construção criativa a partir dos desenhos, o uso do aplicativo esteve associado a uma experiência mais imediata e menos aprofundada, não despertando interesse em retomar as histórias.

Desse modo, esse resultado sugere que o contato com materiais físicos pode estimular um maior envolvimento cognitivo e afetivo, além de promover práticas lúdicas alinhadas às necessidades do desenvolvimento infantil, especialmente no que se refere à imaginação, à atenção e à apropriação das narrativas através dos desenhos.

Para Haidt (2024), o brincar constitui uma atividade essencial ao desenvolvimento infantil, sendo fundamental para a preparação cognitiva, social e emocional dos seres humanos. A privação das brincadeiras gera prejuízos significativos nessas dimensões. Contudo, nas últimas décadas, observam-se mudanças profundas nos comportamentos sociais devido à ampla difusão de

dispositivos digitais móveis, os quais passaram a ocupar, de forma intensa, os espaços públicos e o cotidiano, inclusive das crianças, alterando padrões de interação e vivência do brincar (Haidt, 2024).

A disseminação mundial, por parte da mídia, de que telas são uma ferramenta capaz de otimizar a aprendizagem e o desenvolvimento infantil mostrou-se uma atitude equivocada, implicando elevados gastos financeiros sem a obtenção de resultados significativos. Nesse sentido, Desmurget (2023) afirma que as crianças não se instruem sozinhas, e destaca que existem alternativas pedagógicas menos onerosas e mais eficazes para a promoção do desenvolvimento da linguagem, da atenção e das capacidades de interação social, as quais podem ser implementadas de maneira mais acessível.

Desse modo, a menor receptividade tecnológica e o menor envolvimento com as histórias observados no grupo II deste estudo estão diretamente relacionados ao contexto contemporâneo da infância no meio digital e às consequências geradas por essa realidade, conforme descrito por Desmurget (p. 182, 2023), ao detalhar que os “Estilos de vida digitais afetam a habilidade de se manter concentrados por períodos extensos. [...] Eles estão sempre carentes de novidades.”

Diante dessa realidade, é necessário articular a experiência narrativa, o brincar, o ouvir histórias e a identificação com personagens por meio de intervenções que atuem como ferramentas de entretenimento infantil durante a hospitalização. Essas intervenções devem ter conteúdo direcionado e adequado ao público pediátrico, proporcionando benefícios para o desenvolvimento da imaginação e da elaboração emocional. Portanto, através de intervenções zelosas, que favorecem o contato humano, é possível, durante a hospitalização, construir vias que conectam a infância com o brincar durante o adoecimento.

5.3 A ARTE ENQUANTO FERRAMENTA DE COMUNICAÇÃO PARA A CRIANÇA HOSPITALIZADA

5.3.1 Desenhos da criança durante a hospitalização: diferentes maneiras de comunicar

No que se refere à criação infantil, Vygotsky revela que o desenho pode ser uma via de expressão de sentimentos infantis através da arte, pois “a criança não escreve versos ou desenha porque nela se revela um futuro criador mas porque nesse momento isso é necessário para ela e ainda porque em cada um de nós estão radicadas certas possibilidades criadoras” (Vygotsky, 2010, p. 349).

Essas possibilidades criadoras presentes nas crianças não significam que elas necessariamente se tornarão grandes pintoras ou escritoras no futuro, mas indicam que a arte é uma via de comunicação que traduz, ao modo da criança, a forma como ela “percebe o mundo de modo muito original e absolutamente à sua maneira” (Vygotsky, 2010, p. 341).

Estudo com delineamento transversal, realizado com 100 crianças de 6 a 12 anos, sendo 50 com doenças crônicas (diabetes mellitus 1 e fibrose cística) e 50 saudáveis, mostrou, através da avaliação por desenhos, que crianças com doenças crônicas exibem menos rostos sorridentes (percepção familiar mais negativa) e mais pássaros (sinal de busca de esperança/enfrentamento), enquanto crianças saudáveis desenhavam raízes com maior frequência, sendo esse um indicador de estabilidade (Manomenidis *et al.*, 2025).

De forma semelhante, estudo realizado por Köksal, Kilicarslan e Emeksiz (2025), em uma Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica, com crianças de 7 a 12 anos, evidenciou que o grupo que recebeu intervenção terapêutica, utilizando técnicas de desenho e contação de histórias, obteve uma redução significativa da ansiedade. O estudo também descreve que os desenhos na infância funcionam como via expressiva para identificar estados emocionais e experiências que não emergem pela linguagem verbal.

Em nosso estudo, observamos que as crianças desenharam após a mediação das histórias/figuras, que representam cenas que conectam suas histórias com o enredo das narrativas, estabelecendo vínculos entre suas próprias experiências e os personagens das obras. Ao ilustrar as páginas dos livros, elas não apenas recontaram visualmente os enredos, mas também incorporaram elementos de suas vivências reais, evidenciando um processo de identificação e ressignificação da experiência de hospitalização através da arte.

Esse achado corrobora uma das características da reação estética descrita por Vygotsky: “O seu objetivo final não é repetir alguma reação real, mas superá-la e vencê-la” (Vygotsky, 2010, p. 339). Nesse sentido, a beleza e a estética promovem um encontro do sujeito consigo mesmo, impulsionando-os em direção a novos caminhos e começos possíveis, ainda que esses percursos se desenhem, sobretudo, em seu interior.

Segundo Abazari *et al.* (2025), enfermeiros devem incorporar, no planejamento do cuidado, as perspectivas de crianças e pais, utilizando desenhos para captar percepções a respeito da experiência hospitalar infantil, a fim de orientar ações de melhoria da qualidade e promover participação ativa das crianças.

Os autores concluíram que a arteterapia e a brincadeira terapêutica são estratégias não farmacológicas eficazes para manejo de dor e ansiedade em procedimentos pediátricos, recomendando sua incorporação em rotinas assistenciais para qualificar o cuidado e oferecer suporte emocional durante os procedimentos dolorosos (Mersal; Elwasefy; Elbilgahy, 2025).

Coadunando com essa perspectiva, meta-análise indica que a arteterapia promove efeitos promissores sobre desfechos psicológicos em crianças internadas no setor de pediatria oncológica, reduzindo a ansiedade e a depressão, e trazendo benefícios para quadros de estresse e raiva (Zhou *et al.*, 2025).

Dessa maneira, Loreskär e Binder (2024) apresentam, em seu estudo, uma perspectiva significativa a respeito dos desenhos feitos por crianças hospitalizadas durante sessões de arteterapia, enfatizando que desenhar promove a criatividade, aumenta a autonomia e autoconfiança, o que fortalece o sentimento de segurança.

Ademais, Loreskär e Binder (2024) também evidenciam que intervenções com desenhos integram dimensões criativas, educativas e relacionais, elevando o bem-

estar de crianças hospitalizadas, favorecendo o estabelecimento de uma “aliança terapêutica”. Essa aliança é caracterizada pelo estreitamento de laços relacionais entre a criança e o mediador e é identificada como um mecanismo ainda pouco explorado em pesquisas, mas que potencializa o engajamento e a criação artística durante a hospitalização.

Nesse sentido, o desenho viabiliza a representação da realidade psíquica por meio de imagens, tornando-se um recurso sensível para captar vivências, conflitos e emoções. No contexto hospitalar, esse recurso potencializa a comunicação não verbal do sofrimento e das angústias da criança, ampliando as possibilidades de avaliação e intervenção e favorecendo uma prática clínica que reconhece a singularidade infantil, subsidiando decisões assistenciais mais precisas (Silva, 2010).

No estudo de Hen (2023), entende-se que a arteterapia no hospital possui como objetivo melhorar o bem-estar da criança hospitalizada, promovendo autonomia e oferecendo espaço seguro para processar emoções através da linguagem não verbal. Os entrevistados enfatizam que a arte/criatividade, por ser uma “linguagem natural” da infância, ajuda as crianças a aprenderem a reconhecer, a nomear e a expressar emoções por meio do fazer artístico, tornando a experiência hospitalar mais suportável e significativa para a criança (Hen, 2023).

Em nosso estudo, observamos a presença de uma variedade de elementos nos desenhos das crianças, como ursos pandas, arco-íris fantásticos, chapéus, bonecos de neve, índios, monstros, pássaros cantando em seus ninhos, prédios altos em um dia chuvoso e triste, guarda-chuvas, uma cachorrinha que viaja no tempo, conhece dinossauros raros e retorna para casa, e um herói de capa em pleno voo.

Todos esses elementos nos permitem vislumbrar os múltiplos caminhos possíveis abertos pelas histórias, que oferecem às crianças novos modos de significar suas experiências, reorganizar seus sentimentos e criar mundos próprios no plano da imaginação. Para Vygotsky, “se um poema sobre tristeza tivesse por objetivo final nos comunicar apenas sobre tristeza, isto seria triste demais para a arte” (Vygotsky, 2010, p. 339). Porém, segundo o autor, a poesia nos eleva e nos ajuda a cultivar o desejo de vencer a tristeza e, por fim, superá-la. Da mesma forma, acontece com os desenhos infantis.

Dessa maneira, a expressão de sentimentos infantis por meio da arte, durante a hospitalização, é uma via de comunicação, elaboração e construção da subjetividade, por meio da qual a criança “se eleva” acima da realidade que vivencia. Assim, o desenho é um recurso fundamental para que a criança possa simbolizar sua experiência de adoecimento, dialogar com os seus significados, viajar pela imaginação e encontrar, na criação estética, um modo mais humano e suportável de viver o sofrimento.

5.3.2 O encontro de si: as histórias dos outros e as nossas histórias

A vivência estética mediada por histórias infantis pode favorecer o fortalecimento de sentimentos de empatia tanto em relação ao outro quanto em relação a si mesmo. No contexto da hospitalização infantil, isso significa que o encontro com as narrativas e as imagens possibilitou que as crianças reconhecessem fragmentos de suas próprias experiências.

Nesse sentido, como afirma Vygotsky, “uma obra de arte vivenciada pode efetivamente ampliar a nossa concepção de algum campo de fenômenos, levar-nos a ver esse campo com novos olhos, a generalizar e unificar fatos amiúde inteiramente dispersos” (Vygotsky, 2010, p. 342). Desse modo, ao comparar “a história do outro” com a sua, a criança pode compreender melhor o que sente, exercitar a empatia diante do sofrimento e, simultaneamente, construir novos sentidos para a situação que está vivendo.

Tschida, Ryan e Ticknor (2014) consideram a literatura infantil uma ferramenta fundamental para a transmissão de conhecimentos. Ao permitir que os leitores se identifiquem com aspectos de suas identidades, culturas e experiências presentes no texto, a literatura infantil exerce a função de “espelho”, fortalecendo o vínculo das crianças com o universo dos livros e com suas próprias histórias. Ademais, para ampliar/diversificar os horizontes, os livros também devem funcionar como “janelas”, oferecendo experiências que ultrapassem os contextos da própria vida do leitor, possibilitando observar a realidade de outros.

Dialogando com essa perspectiva, Stakić e Janković (2022) descrevem que as histórias infantis são uma via para promover a aprendizagem sobre a identidade,

sendo a qualidade estética e o potencial semântico aspectos que ajudam a criança a reconhecer a si mesma e aos outros, favorecendo o desenvolvimento integral, encaminhando-a para ampliar sua compreensão sobre alteridade.

Destacam que, para construir um ambiente ideal de leitura para crianças, é essencial uma curadoria diligente das obras, adequando-as à faixa etária. Sobretudo, é preciso viabilizar uma formação para os mediadores, visando, assim, uma melhor implementação de atividades (Stakić; Janković, 2022).

Para Pacheco e Lordelo (2024), quando as crianças conhecem as histórias e as apreciam esteticamente, passam a se apropriar das histórias, e é a partir de sua reprodução que a memória dialoga com a imaginação, tornando essa prática um condutor para os processos criadores. Além disso, acrescentam que é essencial a presença de profissionais que atuem enquanto mediadores para ajudar as crianças nesse universo de construção criativa, reflexão crítica e expressão simbólica.

Estudo realizado por Ramos, Vasconcelos e Neitzel (2024) com professoras que utilizam a contação de histórias em seu cotidiano de ensino mostra que elas percebem as histórias infantis como um objeto artístico que favorece a mediação afetiva, pois mobiliza conhecimentos sobre o mundo, estimula a curiosidade, a imaginação, a criatividade, a reflexão sobre posicionamentos éticos, a resolução de problemas e a compreensão do outro. Dessa forma, amplia-se o repertório cultural e de linguagem, e transforma-se o ambiente por meio da beleza, da diversão e da criação, abrindo um mundo de possibilidades para sonhar.

A propriedade estética dos livros infantis viabiliza a construção de novas perspectivas a partir da beleza, favorecendo a criatividade das crianças ao proporcionar experiências fabulares e fazê-las imaginar outros mundos e seres. Suas características estéticas conduzem à apropriação cultural e à sensibilidade (Baptista; Silva; Amaral, 2024).

Assim, as narrativas criam um ambiente no plano afetivo, na relação com um mediador (educador, cuidador, contador de histórias), no qual a criança é convidada a interpretar, comparar, imaginar finais diferentes e se colocar no lugar do personagem. Essa mediação promove o exercício da imaginação e da linguagem, ampliando a sua capacidade de compreender a si mesma e aos outros.

Nesse sentido, quando Vygotsky afirma que “como qualquer vivência intensa, a vivência estética cria uma atitude muito sensível para os atos posteriores e, evidentemente, nunca passa sem deixar vestígios para o nosso comportamento” (Vigotsky, 2010, p. 342), ele enfatiza que o contato com a arte não se esgota no momento do encontro.

No contexto da hospitalização infantil, ouvir histórias e desenhar não é apenas um alívio passageiro, mas uma experiência que reconfigura, ainda que sutilmente, a maneira como as crianças se percebem, percebem os outros e a própria doença. As emoções mobilizadas pela narrativa e pelo desenho geram identificação, esperança, coragem e ternura, influenciando atitudes posteriores, como maior abertura ao diálogo, disposição para cooperar com procedimentos e melhor elaboração do processo do medo e da dor.

Assim, os vislumbres deixados pela vivência estética se traduzem em novas formas de sentir, interpretar e agir diante da realidade hospitalar, contribuindo para um cuidado sensível, capaz de transformar a experiência do sofrimento com instantes de beleza.

5.4 - DESENVOLVIMENTO INFANTIL E A HOSPITALIZAÇÃO

5.4.1 A imaginação e os rabiscos da criatividade

Os desenhos produzidos pelas crianças funcionam como uma forma de comunicação simbólica, permitindo que expressem seus pensamentos, sentimentos e emoções que, muitas vezes, ainda não conseguem transmitir por meio da linguagem verbal (Gonzalez; Barbosa-Lima; Vasconcellos-Silva, 2025).

Além disso, oferecer atividades que estimulam a imaginação, o uso das mãos e a atenção visual pode ajudar no equilíbrio emocional das crianças. O entretenimento criativo contribui para o aumento dos sentimentos de alegria e satisfação durante atividades como desenhar. Dessa forma, o estudo reforça a importância de propor tarefas que despertem interesse ativo e apoiem o bem-estar infantil (Brechet; Saget; Vijil, 2025).

A diversidade de histórias infantis disponibilizadas em nosso estudo permitiu que as crianças tivessem a oportunidade de entrar em contato com diferentes cenários, culturas, personagens e modos de vida. Quanto maior a diversidade de narrativas, maior é a chance de a criança expandir sua compreensão do mundo, reconhecendo realidades que vão além de sua própria experiência cotidiana.

Esse contato com múltiplos contextos, sejam eles fantásticos, históricos, sociais ou relacionados ao universo das emoções, estimula a imaginação e favorece o desenvolvimento de empatia, tendo em vista que a criança passa a observar situações vividas por outros personagens em outros lugares e sob outras perspectivas. Assim, a bibliodiversidade de histórias não apenas enriquece o universo infantil, mas também fortalece a capacidade de interpretar o mundo com mais sensibilidade.

Oferecer meios que estimulem o pensar criativo é fundamental para o desenvolvimento integral da criança, pois amplia sua capacidade de explorar, imaginar, fazer escolhas e produzir soluções próprias diante de novas situações. Quando a criança tem acesso a materiais variados, a experiências sensoriais ricas e a espaços para experimentar e liberdade para criar, ela aprende não apenas a repetir modelos, mas a construir ideias originais, combinando referências internas e externas.

Para Vygotsky (2010), a atividade criativa é qualquer atividade que pode gerar algo novo, seja ela um objeto do contexto exterior ou uma construção mental. O autor descreve que toda criação reflete as experiências anteriores, as memórias significativas ou as cenas atuais.

Os desenhos inseridos na seção de resultados, no tópico 4.11 (Encantamento e a beleza na infância: traços de pequenas mãos), evidenciam os desejos infantis revelados através dos desenhos. As experiências vivenciadas trazem da memória vários aromas, sabores, encontros, natureza e liberdade.

Essa experiência, vivenciada durante a hospitalização, permite à criança transportar-se, de forma efêmera, para espaços de tranquilidade e aconchego. Embora sejam breves, são capazes de transformar cada instante com ternura.

Dessa maneira, através de histórias infantis, foi possível favorecer a criação artística corroborando o que descreve Vygotsky (2014, p. 111): “o futuro do homem é conquistado através da imaginação criativa”. A criança deve ser preparada para o

“amanhã”, sendo a construção de um desenvolvimento integral e de sua criatividade a principal via para a concretização de um futuro possível.

5.5 O MEDIADOR: UM ENCONTRO DE BELEZA E CUIDADO

5.5.1 A presença enquanto essência do cuidado humano à criança hospitalizada

A presença do mediador durante a contação de histórias é essencial para se obter a melhor compreensão do contexto. A interpretação dos desenhos e o fortalecimento de vínculos entre o mediador e a criança só são possíveis por meio de um diálogo iniciado com cada história. Esse encontro se caracteriza como uma intervenção potencialmente eficaz para promover ganhos na habilidade comunicativa e no comportamento interativo da criança (Deliberato; Adurens; Rocha, 2021).

Em metassíntese realizada por Nan e Tian (2025), evidenciou-se que a leitura compartilhada entre pais e filhos é uma prática essencial para o desenvolvimento infantil, pois favorece habilidades linguísticas, cognitivas e socioemocionais. Para promover a contação de histórias, segundo os autores, é preciso ter acesso a livros de qualidade, um ambiente acolhedor, apoio formativo aos mediadores e criar experiências prazerosas durante a leitura.

O estudo destaca a importância dos pais enquanto mediadores, sendo um papel determinante para fortalecer vínculos, pois, ao se fazer perguntas, dialogar e relacionar a história à vida da criança, consolida-se uma relação interpessoal entre a criança, o mediador e o livro (Nan; Tian, 2025).

Reyes (2017) destaca que, na relação intitulada “triângulo amoroso”, a leitura é uma experiência compartilhada. O adulto funciona como o “texto vivo” da criança, ao emprestar a sua voz, o seu rosto e a sua presença. Observa-se isso no olhar da criança, que alterna constantemente entre as páginas e o rosto do mediador. Dessa forma, a história ganha vida no corpo e na voz do adulto, e é nesse vínculo que a criança percebe o texto e sente a narrativa, experimentando a leitura como algo afetivo.

Em outro texto, a mesma autora reflete sobre a experiência estética da linguagem através das histórias. Reyes (2010) destaca que a necessidade afetiva e de palavras da criança é semelhante à necessidade fisiológica de nutrição, pois, assim como se alimenta, ela anseia repetir diversas vezes uma mesma história para ter presença, ouvir palavras e se encantar novamente.

No nosso estudo, o desenho realizado durante a intervenção II, destacado no tópico 4.12 (Duas formas de mediar histórias: um só encontro), dialoga com os artigos supracitados, pois evidencia a necessidade infantil de repetir a experiência de encantamento estético com o livro físico e o vínculo afetivo envolvido no processo de contar histórias.

É durante esse processo recorrente que as crianças escutam atentamente os detalhes e nutrem-se das “vozes que mais à frente os ajudarão a encontrar sua própria voz” (Reyes, 2010, p. 35). É através desse movimento que aprendem não apenas a decodificar palavras, mas a atribuir sentido ao mundo, permitindo que elaborem emoções, organizem pensamentos e construam a sua própria identidade.

Assim, a contação de histórias deixa de ser uma simples transmissão de conteúdo e se torna um ato de cuidado por meio da presença, um espaço em que a linguagem, o afeto e a imaginação se entrelaçam, favorecendo a autonomia interpretativa e o desenvolvimento infantil. É nesse encontro que cada história cumpre a sua função, ajudando a criança a se reconhecer como sujeito capaz de sentir, pensar e expressar-se no mundo. Desse modo, “(...) ao oferecer leituras, podemos dar a cada criança uma caixa de ferramentas para ajudá-la na tarefa de inventar sua própria vida, entre o que é dado e o que é possível” (Reyes, 2017, p. 50).

A presença oferecida durante a contação de histórias, especialmente dos mediadores, pode ser considerada um elemento essencial para o cuidado humanizado à criança hospitalizada. Os relatos das próprias crianças mostram que elas vivenciam a internação não apenas como um evento clínico, mas como uma experiência emocional que demanda segurança, escuta e vínculo. A presença dos pais atua como fator de proteção psicológica, reduzindo a ansiedade e favorecendo o enfrentamento da dor (Sillero, 2024).

Portanto, a mediação, entendida também como a presença do outro, constitui uma via fundamental pela qual conceitos, significados e experiências sociais são

internalizados. No contexto da contação de histórias, a presença do outro favorece o ato de ouvir, a memória, a criatividade, a imaginação e o raciocínio lógico. Ela também aperfeiçoa habilidades cognitivas e linguísticas complexas, promovendo processos como antecipação, inferência, empatia e regulação emocional (Vygotsky, 2007). Dessa maneira, a mediação de histórias ocupa lugar central durante o desenvolvimento infantil.

5.6 DIÁLOGO ENTRE AS DIFERENTES VIAS DE MEDIAR HISTÓRIAS

5.6.1 A estética enquanto ferramenta de cuidado à criança hospitalizada

O Plano Nacional para a Primeira Infância (2020) defende que as crianças têm direito à beleza como dimensão essencial do desenvolvimento humano e aos direitos básicos de sobrevivência e proteção. Ele também enfatiza:

A beleza não é algo que se deixa para depois de resolver todos os problemas, de preencher as carências econômicas, de vencer os sofrimentos psicológicos e ter os direitos fundamentais cumpridos. Ela não é um depois: ela nasce junto com o esforço de superação, forma-se na ação e, aí sim, dá supremacia ao realizado. Há uma beleza, em permanente gestação na vida, que sutura feridas, que reata laços, que perdoa e volta a abraçar, que rejeita o desespero e se apegua à esperança. [...] Nos lugares mais carentes, a sede de beleza é ainda maior. A força da poesia vibra com vigor inusitado onde a miséria é mais cruel. Às vezes, a beleza é a sua tábua de salvação. Com sabedoria, Edgar Morin disse que “a beleza deve ajudar a viver” (RNPI, 2020, p. 206).

Nesse sentido, quando falamos em beleza, não nos referimos apenas ao sentido tradicional de algo “bonito”, mas à estética como dimensão sensível da experiência humana: aquilo que afeta os sentimentos, desperta emoções, nos introduz a um novo mundo e produz bem-estar. Para as crianças hospitalizadas, essa dimensão estética, presente nas histórias, torna-se ainda mais essencial, pois atua como contraponto ao sofrimento físico, ao medo, à dor e à ruptura da rotina.

Vygotsky (2010) descreve que as histórias infantis podem ser consideradas ferramentas da arte. Por sua vez, possuem características estéticas capazes de nos

conduzir por novos caminhos mediados pela vivência estética e “nunca passa sem deixar vestígios para o nosso comportamento” (p. 342).

Corroborando essa perspectiva, os resultados de estudo realizado por Abdi *et al.* (2025) demonstram que a contação de histórias produziu uma redução estatisticamente significativa nos níveis de ansiedade das crianças participantes, efeito que não foi observado no grupo controle. Enfatizou-se que, entre as estratégias comparadas, somente a narrativa mediada por histórias foi capaz de diminuir a ansiedade de modo relevante, evidenciando seu impacto específico no bem-estar emocional infantil (Abdi *et al.*, 2025).

Ensaio clínico randomizado realizado por Çoban *et al.* (2025), com 60 crianças em tratamento de queimaduras, mostrou que a contação de histórias digitais durante o curativo reduziu significativamente a dor, o medo e a ansiedade, quando comparada ao cuidado padrão, além de melhorar parâmetros fisiológicos e aumentar a satisfação dos pais. Por ser uma ferramenta de baixo custo e fácil aplicação, os autores recomendam a inclusão de histórias infantis como estratégia não farmacológica no manejo da dor e ansiedade para pacientes pediátricos.

De forma semelhante, Brockington *et al.* (2021) demonstram, em estudo experimental com crianças hospitalizadas em Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica, que a contação de histórias resulta em aumento de oxitocina, redução de cortisol, menor percepção de dor e uso mais frequente de linguagem positiva para descrever a experiência de internação.

Os estudos mencionados convergem com os resultados desta pesquisa ao evidenciarem a redução dos níveis de ansiedade entre os participantes submetidos às intervenções, bem como o estímulo à imaginação e à criatividade, observados por meio de suas produções gráficas, nas quais criaram cenas e ambientes simbólicos capazes de deslocá-las, ainda que subjetivamente, do contexto hospitalar.

Para Vygotsky, a estética não deve estar disponível apenas em momentos comemorativos, pois “a beleza deve-se tornar uma exigência do cotidiano” (2010, p. 352), indicando que o contato com experiências sensíveis, artísticas e simbólicas é uma necessidade perene para o desenvolvimento emocional e intelectual das crianças.

Assim, a presença da arte, das histórias infantis e da beleza deve ser vista como parte constitutiva de um cuidado integral. O hospital pediátrico, que acolhe a dimensão estética, não apenas trata o corpo, mas reconhece a criança como sujeito sensível, imaginativo, criador e capaz de significar sua experiência. As unidades de atendimento ao público pediátrico devem estar atentas ao que afirma Vygotsky:

[...] Assim como a eletricidade não existe só onde existe a tempestade, a poesia também não existe só onde há grandes criações de arte, mas em toda parte onde soa a palavra do homem. É essa poesia de “cada instante” que constitui quase que a tarefa mais importante da educação estética (Vygotsky, 2010, p. 352).

5.6.2 Diferentes vias para contar histórias: o mediador e a criança

A contação de histórias, mediada por ferramentas digitais, tem se mostrado uma prática inovadora no contexto educacional, pois potencializa a capacidade crítica e reflexiva a respeito de diferentes temas. Ao mesmo tempo, acredita-se que essa prática pode ser uma via alternativa para o fortalecimento do ensino e da aprendizagem na infância (Khoo; Mitchel; Sammons, 2024).

Nesse contexto, é essencial observar que o uso da literatura infantil em formatos digitais também articula diferentes recursos, criando novas possibilidades de interação estética entre a obra e o leitor. Essa configuração multimodal exige que o leitor desenvolva habilidades ampliadas de leitura, envolvendo não apenas a interpretação verbal, mas também a compreensão crítica do visual e do sonoro, mobilizando saberes, emoções e experiências com a tecnologia (Morais, 2015).

Lima (2018) descreve que, embora os modos de leitura e interação com livros tenham se transformado, exigindo novas competências do leitor e mediador, os critérios que definem o que é considerado literatura de qualidade e experiência estética permanecem praticamente inalterados. Assim, ainda é necessária uma curadoria zelosa para analisar criticamente a variedade de conteúdo e as possibilidades estéticas disponibilizadas pela literatura infantil digital.

Nesse sentido, a presença de recursos multimodais na literatura infantil digital não elimina a necessidade de mediação realizada por um adulto. A presença do mediador amplia a autonomia da criança e a auxilia na construção de competências interpretativas, que só podem ser desenvolvidas em experiências compartilhadas de

leitura. Assim, a literatura digital para crianças requer a construção de um ecossistema que articule diferentes práticas narrativas, favorecendo tanto o prazer estético da leitura quanto a formação literária do leitor (Kirchof; Moraes, 2022)

Corroborando essa perspectiva, o estudo de Selak, Horvat e Zmavc (2025) evidencia que a avaliação do uso problemático das tecnologias digitais na infância não deve se limitar ao tempo de tela. Os achados indicam que fatores como exposição precoce, uso de dispositivos antes de dormir e uso solitário estão mais fortemente associados a impactos negativos do que apenas à quantidade de horas de uso, reforçando a necessidade de cuidados mais abrangentes em relação ao uso da literatura digital.

Sob um ponto de vista semelhante, Nan e Tian (2025) evidenciam a necessidade de se estabelecerem diretrizes claras sobre o uso de livros digitais em práticas de leitura compartilhada com crianças, de modo a determinar em que contextos e condições esses materiais podem ser incorporados sem que se comprometam os ganhos cognitivos, linguísticos e socioemocionais associados à leitura mediada.

Convergindo com essa perspectiva, nosso estudo observou que as crianças dos dois grupos de intervenção reduziram os níveis de ansiedade, ampliaram sua imaginação e criatividade, como pode ser evidenciado pelos diversos desenhos elaborados, e, sobretudo, construíram vínculos empáticos com a mediadora.

No tópico 7.12 (Duas formas de mediar histórias: um só encontro) dos nossos resultados, a experiência empírica revelou que, mais do que o formato do suporte — seja ele impresso ou digital —, o elemento central da leitura é o encontro estético mediado pela presença do outro. Durante uma sessão de mediação de histórias por meio de aplicativo, uma participante manifestou o desejo de interromper a narrativa digital para ouvir a leitura de um livro físico que possuía.

Sob a perspectiva de Vygotsky, esse movimento confirma que a contação de histórias atua como uma experiência estética e socialmente mediada, em que o sentido não se constitui de forma isolada, mas na interação com o outro, pois o desenvolvimento humano é organizado socialmente (Vygotsky, 2010). Assim, o pedido da criança representa uma busca pela dimensão relacional da leitura, que

envolve afeto, reconhecimento e partilha emocional, elementos que nem o livro impresso ou livro digital são capazes de oferecer.

Dessa forma, mais do que hierarquizar os formatos dos livros infantis, é fundamental reconhecer que, durante a hospitalização infantil, é urgente a necessidade de implementar um ecossistema humano que favoreça a contação de histórias, oferecendo o diálogo, a sensibilidade estética e a construção conjunta de significados. Vygotsky considera esses aspectos centrais no papel humanizador da arte.

As dificuldades enfrentadas na pesquisa estiveram diretamente relacionadas às características do público estudado e às condições institucionais do campo da etapa III. A diversidade de diagnósticos se mostrou um desafio, pois gerou experiências muito distintas entre as crianças acompanhadas, impossibilitando uma maior uniformização dos dados e a criação de parâmetros comparativos mais homogêneos.

Outro ponto relevante foi o tempo de internação, que, na maioria dos casos, foi bastante curto, com apenas um dia de intervenção. Muitas crianças eram admitidas, avaliadas e liberadas rapidamente, o que reduzia a oportunidade de realizar os dois dias de intervenção. Essa limitação restringiu a observação de processos mais prolongados e impossibilitou aprofundar aspectos que poderiam emergir em internações mais longas.

Por fim, aspectos logísticos também impactaram de maneira significativa. A disponibilidade da pesquisadora para ir ao campo apenas durante a semana e no período da tarde dificultou o registro de situações importantes, já que as altas frequentemente ocorriam no final da manhã, antes do início das atividades de pesquisa.

Além disso, o fechamento temporário da Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica durante o período de coleta reduziu consideravelmente o número de admissões e de procedimentos cirúrgicos realizados no hospital, o que afetou diretamente a quantidade e a variedade de casos disponíveis para estudo. Esses fatores somados resultaram em uma coleta mais limitada do que a inicialmente planejada.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

As histórias infantis, em seus diferentes formatos, mostraram-se ferramentas eficazes para a redução da ansiedade infantil durante a hospitalização. Ao adentrarem o universo narrativo, as crianças puderam viajar pelo espaço sideral, observar tartarugas no oceano, desenhar bonecos de neve, reencontrar dinossauros pré-históricos e, sobretudo, reconhecer-se nas histórias que ouviam, enxergando nelas reflexos de suas próprias experiências e emoções.

Ao favorecer o encontro de aspectos fantásticos/lúdicos com cenários relacionados à realidade da hospitalização infantil, emergiram sentimentos de alegria, esperança, amor, amizade e coragem. Certamente, o medo e a tristeza associados ao adoecimento infantil também ficaram evidentes.

Todos esses sentimentos e emoções compõem o ser humano e caracterizam nossa essência, sendo determinantes para a forma como vivemos no mundo. De algum modo, eles devem ser comunicados. Para as crianças, o meio de anunciar o que sentem ocasionalmente será o verbal, e para isso é necessário oferecer outras vias possíveis.

Assim, as histórias infantis e os desenhos se tornaram, neste estudo, meios para que a comunicação por parte das crianças fosse efetivada. Dessa maneira, a percepção subjetiva das crianças sobre o processo de cuidado e adoecimento foi visualizada a partir de desenhos e narrativas, corroborando para sua participação ativa nos encontros que também caracterizaram um cuidado.

No decorrer das nossas observações, percebemos que o cuidado à criança deve ser compreendido em sua dimensão biopsicossocial, reconhecendo-a como sujeito em formação. A ênfase no cuidado físico ignora os aspectos emocionais essenciais ao desenvolvimento integral, porém as interações na infância moldam a constituição afetiva e cognitiva, repercutindo na vida adulta. Desse modo, o cuidado integral deve articular o corpo, a mente e a cultura, promovendo a saúde física e o bem-estar emocional.

Com base nesse entendimento, fomos conduzidos a refletir sobre o papel da instituição hospitalar e dos profissionais de saúde no desenvolvimento infantil em situações de adoecimento, o que suscitou importantes questionamentos: como o

entretenimento é vivenciado pela criança durante a hospitalização? Qual é o papel da instituição e dos profissionais para minimizar o estresse vivenciado por crianças hospitalizadas? E de que modo é possível cuidar do corpo físico de uma criança em desenvolvimento sem oferecer, simultaneamente, instrumentos que favoreçam sua expressão, imaginação e bem-estar emocional?

Respondendo aos questionamentos supracitados, evidenciamos neste estudo que ainda há um longo percurso na construção de um cuidado verdadeiramente integral à criança hospitalizada, sobretudo diante dos desafios que a infância contemporânea enfrenta em uma sociedade marcada pela aceleração tecnológica e pela virtualização das relações. O uso indiscriminado de telas, o acesso precoce a conteúdos e jogos inadequados têm comprometido a saúde física, emocional e cognitiva de crianças e adolescentes, tornando-os mais vulneráveis e expondo-os a consequências sem precedentes no que se refere ao desenvolvimento humano.

Ao direcionarmos o olhar ao brincar durante a hospitalização, damos um passo fundamental rumo à consolidação de um cuidado integral à criança. A proposição de práticas lúdicas, especialmente a contação de histórias, desenvolvida em nosso estudo nos formatos digital e físico, evidencia como a curadoria de conteúdos de qualidade, aliada a uma mediação sensível, pode transformar realidades, ainda que por breves instantes, promovendo alívio, expressão e sentido no contexto do adoecimento infantil.

Além disso, o presente estudo trouxe apontamentos relevantes sobre o uso da literatura infantil digital mediada por aplicativos móveis em unidades de atendimento pediátrico. Observou-se que, embora o aplicativo tenha sido bem avaliado e correspondido às expectativas das crianças, há necessidade de aperfeiçoamentos no *layout*, a fim de otimizar a visualização das histórias. Tal aprimoramento demanda uma reorganização da interface da tela de leitura, ampliando as possibilidades de escolha e interação com o conteúdo. Destaca-se também o papel de um mediador adulto preparado para explorar, em sua plenitude, a contação de histórias nos formatos digital e físico, de modo a estimular a participação das crianças e abordarem os sentimentos e emoções vivenciados em seu processo de adoecimento.

Nesse sentido, outro aspecto significativo identificado refere-se à maior integração entre as crianças e a mediadora quando o uso do aplicativo e o acesso às histórias ocorreram sem o uso de fones de ouvido, favorecendo a criação de vínculos

afetivos e diálogos interativos com o ambiente no qual o dispositivo eletrônico foi utilizado.

Ademais, em relação à receptividade aos diferentes formatos de acesso às histórias, observou-se maior aceitação por parte das crianças quando a mediação ocorreu por meio do aplicativo NaveghiBook, possivelmente em razão da familiaridade do público infantil contemporâneo com o uso de dispositivos móveis. Entretanto, o grupo que utilizou o livro físico demonstrou maior interesse em retornar ao material impresso, folheando as páginas para rever as ilustrações e produzir seus próprios desenhos, enquanto as crianças que acessaram as histórias por meio do aplicativo NaveghiBook não manifestaram o desejo de revisitar o conteúdo após a atividade.

Desse modo, o comportamento observado no grupo que utilizou o livro físico sugere um envolvimento mais profundo e reflexivo. Esses achados evidenciam que diferentes suportes produzem formas distintas de vínculo com a narrativa, podendo ser usados de maneira complementar conforme os objetivos da intervenção.

Nosso estudo também desvelou novos caminhos através da arte enquanto via para a expressão simbólica, o que favoreceu a comunicação com as crianças. Por meio das histórias, foi possível entrever suas realidades e representá-las através dos desenhos. As histórias infantis e as produções gráficas se tornaram, assim, a voz das crianças, seu meio de expressão e, simultaneamente, fonte de entretenimento e de conexão afetiva com a mediadora. A arte nos conecta a nós mesmos e ao outro, criando pontes entre o sentir, o imaginar e o comunicar.

Por fim, percorremos os corredores carregando a beleza. Pelas paredes das enfermarias, o silêncio dos quartos era suavemente atravessado por vozes, cores e sorrisos. Acendam as luzes, pois observamos que, pouco a pouco, sentimentos de esperança e lampejos de uma alegria discreta transbordavam das mãos e dos olhos dos pequenos participantes, revelando que a arte, mesmo em espaços marcados pela dor, pode iluminar a vida.

Constatamos que um cuidado germinou do encontro entre o livro, a criança e o mediador. Um encontro tecido pela beleza, pela estética e pelo encantamento. Um cuidado que não se limita à dimensão técnica, direcionada à doença física, mas que floresce no campo do desenvolvimento infantil, despertando o sorriso, a memória, o pensamento e a reflexão como formas de elaboração emocional e cognitiva. Nesse

entrelaçar de palavras e afetos, a arte mostrou-se um caminho possível para o florescimento da sensibilidade, reafirmando que, muitas vezes, cuidar também é permitir-se tocar o outro por meio da beleza.

Em um texto poético de Manoel de Barros, intitulado “O solitário”, podemos observar a dimensão da beleza enquanto luz para a vida. Podemos também realizar inferências sobre o diálogo discreto que cada verso realiza com o tempo atual vivido pelas crianças, o cuidado integral e a beleza:

Os muros enflorados caminhavam ao lado de um
homem solitário
Que olhava fixo para certa música estranha
Que um menino extraía do coração de um sapo.

Naquela manhã dominical eu tinha vontade de sofrer
Mas sob as árvores as crianças eram tão comunicativas
Que me faziam esquecer de tudo
Olhando os barcos sobre as ondas...

No entanto o homem passava ladeado de muros!
E eu não pude descobrir em seu olhar de morto
O mais pequeno sinal de que estivesse esperando
alguma dádiva!
Seu corpo fazia uma curva diante das flores.
(Barros, 2013, p. 36)

Os versos do poeta nos convidam a refletir que, mesmo quando a dor e as dificuldades nos cercam, há em cada ser humano um anseio silencioso e constante por tudo o que desperta a beleza e a ternura; há o desejo por uma esperança que não se apaga. A vivência estética surge, então, como um gesto de redenção, uma chama que reacende o olhar e nos resgata da apatia, conduzindo-nos de volta à nossa essência e nos fazendo redescobrir que a vida é bonita, apesar da dor.

Desse modo, os pequenos instantes de beleza e cuidado observados nesta tese produzem importantes apontamentos para a formulação e o aprimoramento de políticas públicas voltadas ao cuidado integral da criança. Nossos achados reforçam a necessidade de integrar elementos da arte, em especial a contação de histórias, às práticas de cuidado e ao cotidiano da hospitalização infantil, de modo que essa integração não seja considerada apenas como um aspecto secundário no cuidado à criança hospitalizada.

Portanto, nosso estudo também reforça as recomendações voltadas à formação de profissionais de saúde, estimulando o desenvolvimento de novas habilidades e atitudes que promovam um cuidado verdadeiramente integral às crianças. É fundamental que esses profissionais atuem com sensibilidade e adotem abordagens que contribuam para relações mais acolhedoras entre cuidadores e crianças. Uma via é a integração de afetos por meio da mediação de histórias, pois constitui uma estratégia potente para criar conexões e vínculos, contribuindo para o desenvolvimento integral da criança em suas relações familiares, seja no contexto hospitalar ou no domiciliar.

REFERÊNCIAS

- ABAZARI, L. *et al.* Experiences of children during hospitalization: content analysis of interviews and paintings. **BMC Pediatrics**, v. 25, n. 183, p. 1-9, 2025. DOI: <https://doi.org/10.1186/s12887-025-05529-4>.
- ABDI, F. *et al.* Effect of play therapy and storytelling on the anxiety level of hospitalized children: a randomized controlled trial. **BMC Complementary Medicine and Therapies**, v. 25, n. 23, p. 1-34, 2025. DOI: 10.1186/s12906-025-04767-4.
- ANICETO, B.; BOMBARDA, T. B. Cuidado humanizado e as práticas do terapeuta ocupacional no hospital: uma revisão integrativa da literatura. **Cadernos Brasileiros de Terapia Ocupacional**, v. 28, n.2, p. 640-660, 2020.
- ARAUJO, G. B.; SPERB, T. M.; BITENCOURT, H. R. Termos Mentais na Contação de Histórias e a Teoria da Mente das Crianças. **Psicologia: Teoria e Pesquisa**, Brasília, v. 32, n. 4, p. 1-9, 2016.
- ARCHIBALD, M. M. *et al.* Developing “My Asthma Diary”: a process exemplar of a patient-driven arts-based knowledge translation tool. **BMC Pediatric**, v.18, n.186, p. 1-10, 2018. DOI: <https://doi.org/10.1186/s12887-018-1155-2>
- BAPTISTA, M. C.; SILVA, H. A. L.; AMARAL, M. P. L. Mediação de leitura literária e fruição estética: questões para a formação de professoras para e da educação infantil. In: FAVINHA, M. A. Z. (org.). **Formação de professoras e professores da educação infantil: bases científicas, contextos, desafios e possibilidades**. Marília: Oficina Universitária; São Paulo: Cultura Acadêmica, 2024. p. 151-165. DOI: 10.36311/2024.978-65-5954-558-2.
- BARDIN, L. **Análise de Conteúdo**. São Paulo: Edições 70, 2016.
- BARROS, L. As consequências psicológicas da hospitalização infantil: prevenção e controle. **Análise Psicológica**, Lisboa, v. 16, n. 1, p. 11-28, 1998.
- BARROS, M. **Poesia Completa**: Manoel de Barros. São Paulo: LeYa. 2013.
- BARROS, M. S. *et al.* Percepções de estudantes do ensino superior sobre um processo educativo mediado por contação de histórias. **Educ. Pesqui.**, São Paulo, v. 50, p. e276324, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1678-4634202450276324>
- BEYER-WUNSCH, P.; REICHSTEIN, C. Effects of a Humanoid Robot on the Well-being for Hospitalized Children in the Pediatric Clinic - An Experimental Study. **Procedia Computer Science**, v. 176, n. 1, p. 2077-2087, 2020.
- BRASIL, Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**: Educação é a Base. Brasília: Ministério da Educação, 2018. Disponível em: https://www.gov.br/mec/pt-br/escola-em-tempo-integral/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal.pdf. Acesso em: 2 mar. 2024.

BRASIL. **Lei nº 11.104, de 21 de março de 2005**. Dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de brinquedotecas nas unidades de saúde que ofereçam atendimento pediátrico em regime de internação. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 22 mar. 2005. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11104.htm. Acesso em: 2 mar. 2024.

BRASIL. **Lei nº 15.211, de 17 de setembro de 2025**. Dispõe sobre a proteção de crianças e adolescentes em ambientes digitais (Estatuto Digital da Criança e do Adolescente). Diário Oficial da União, Brasília, DF, 17 set. 2025. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2025/lei/L15211.htm. Acesso em: 18 set. 2025.v

BRASIL. Ministério da educação. **Guia de Contação De Histórias**, 2021. Disponível em: <https://pdfs.semanticscholar.org/4bb0/b53ff1c6e290e7215bee2b1613a56060b08e.pdf>. Acesso em: 10 mar. 2023.

BRECHET, C.; SAGET, C.; VIJIL, I. From blank page to bright mind: comparing the emotional benefits of drawing and other activities in children. **Cognitive Development**, v. 75, n. 101606, p. 1-10, 2025. DOI: 10.1016/j.cogdev.2025.101606.

BROCKINGTON, G. *et al.* Storytelling increases oxytocin and positive emotions and decreases cortisol and pain in hospitalized children. **PNAS**, v. 118, n. 22, p. 1-7, 2021. DOI: 10.1073/pnas.2018409118

BRONDANI, J. P.; PEDRO, E. N. R. O uso de histórias infantis no cuidado de enfermagem à criança: revisão integrativa. **Rev Bras Enferm.**, v. 72, n. Supl 3, p. 348-357, 2019.

CACHADO, R. Diário de campo: Um primo Diferente na família das ciências sociais. **Rev. sociol. antropol.**, Rio de Janeiro, v. 11, n. 2, p. 551–572, mai./ago. 2021.

CAMPOS, F. V. Adaptação cultural do instrumento Child Drawing : Hospital. 199 f. **Dissertação**. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2018. DOI <https://doi.org/10.11606/D.7.2019.tde-08052019-161538>

CAMPOS-RAMOS, P. C.; BARBATO, S. Participação de crianças em pesquisas: Uma proposta considerando os avanços teórico- metodológicos. **Estudos de Psicologia**, v. 19, n. 3, p. 157-238, jul./set. 2014. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1413-294X2014000300004>

CARVALHO, A. M. A. *et al.* O Uso de Entrevistas em Estudos com Crianças. **Psicologia em Estudo**, Maringá, v. 9, n. 2, p. 291-300, mai./ago. 2004.

CARVALHO E SOUSA, L. *et al.* The act of playing within the hospital context in the vision of the accompanying persons of the hospitalised children. **Journal of Human Growth and Development**, v. 25, n. 1, p. 41-49, 2015.

ÇELIK, D. S. O. *et al.* Validation of child drawing hospital (CD: H) scale and the role of drawing in the evaluation of Dental anxiety. **BMC Oral Health**, v. 25, n. 274, 2025.

CERIBELLI, C. *et al.* A mediação de leitura como recurso de comunicação com crianças hospitalizadas. **Rev Latino-Am Enfermagem.**, v. 17, n. suppl 1, p. 81-87, 2009.

CEZAR, A. T.; JUCÁ-VASCONCELOS, H. P. Diferenciando sensações, sentimento e emoções: uma articulação com a abordagem gestáltica. **Revista IGT na Rede**, v. 13, n. 24, p. 4-14, 2016.

CHAISEKSAMPHAN, O.; CHONCHAIYA, W. Screen media use in hospitalized children: a prospective observational study. **European Journal of Pediatrics**, v. 181, p. 2357-2366, 2022. DOI: 10.1007/s00431-022-04435-6.

CIUFFO, L. L. *et al.* O uso do brinquedo pela enfermagem como recurso terapêutico na assistência à criança hospitalizada. **Revista Brasileira de Enfermagem**, v. 76, n. 2, e20220433, p. 1-7, 2023. DOI: 10.1590/0034-7167-2022-0433pt

CLATWORTHY, S.; SIMON, K.; TIEDEMAN, M. E. Child Drawing: Hospital - An Instrument Designed to Measure the Emotional Status of Hospitalized School-age Children. **J Pediatr Nurs.**, v. 14, n. 1, p. 1-9, 1999a.

CLATWORTHY, S.; SIMON, K.; TIEDEMAN, M. E. Child Drawing: Hospital Manual. **J Pediatr Nurs.** v.14, n.1, p. 10-18, 1999b.

ÇOBAN, N. *et al.* The effect of therapeutic storytelling on pain, fear, and anxiety levels in children undergoing burn dressing. **Burns**, v. 51, n. 9, 2025. DOI: 10.1016/j.burns.2025.107691.

COFEN (CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM). **Resolução nº 546, de 09 de maio de 2017.** Atualiza norma para utilização da técnica do brinquedo/brinquedo terapêutico pela equipe de enfermagem na assistência à criança hospitalizada. Brasília, DF: COFEN, 2017. Disponível em: <http://www.cofen.gov.br/wp-content/uploads/2017/05/Resolu%C3%A7%C3%A3o-546-17.pdf>. Acesso em: 2 mar. 2025

COMUNIDADE EDUCATIVA (CEDAC) .**Pequenos leitores : um projeto de formação de educadores para a garantia do direito à literatura desde a primeira infância / Comunidade Educativa.** CEDAC e FTD Educação, 1. ed. São Paulo : FTD, 2018.

COSME, A. L. S.; CRUZ, G. V. S. F. Ludoterapia: o brincar no hospital e a saúde mental infantojuvenil. **Revista Aracê**, v. 7, n. 4, p. 17787-17804, 2025. DOI: 10.56238/arev7n4-126.

COSTA, T. S.; MORAIS, A. C . A Hospitalização Infantil: Vivência De Crianças A Partir De Representações Gráficas. **Rev enferm UFPE on line**, Recife, v.11, n. Supl. 1, p. 358-367, jan. 2017.

CREMIN, T. *et al.* Storytelling in Early Childhood: Enriching language, literacy and classroom culture (1st ed.). **Pub.Location**, London, p.224, 2016. DOI: <https://doi.org/10.4324/9781315679426>

DELIBERATO, D.; ADURENS, F. D. L.; ROCHA, A. N. D. C. Brincar e contar histórias com crianças com transtorno do espectro autista: mediação do adulto. **Revista Brasileira de Educação Especial**, v. 27, p. 73-88, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1590/1980-54702021v27e0128>

DESMURGET, M. **A fábrica de cretinos digitais**: Os perigos das telas para as nossas crianças. 1 ed. São Paulo: Vestígio, 2023.

DOURADO, C. A. N. *et al* . A criança no ambiente hospitalar e o processo de humanização . **Concilium**, v. 22, n. 4, p. 359-377, 2022. DOI: <https://doi.org/10.53660/CLM-381-376>

ESTEVES, C. H.; ANTUNES, C.; CAIRES, S. Humanization in a pediatric context: the role of clowns in improving the environment experienced by hospitalized children. **Interface**, Botucatu, v. 18, n. 51, p. 697-708, 2014.

ETOKABEKA, E. Supporting the Development of Executive Function Skills Through Structured Play: A Qualitative Study of South African Preschool Teachers. **Early Childhood Education Journal**. p. 1-10, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1007/s10643-024-01827-1>

FELÍCIO, F. A. S.; SEABRA JUNIOR, M. O.; RODRIGUES, V. Brinquedos educativos associados à contação de histórias aplicados a uma criança com deficiência múltipla. **Rev. Bras. Ed. Esp.**, Bauru, v. 25, n. 1, p. 67-84, Jan./Mar. 2019. DOI: 10.1590/s1413-65382519000100005

FERREIRA, D. P.; JUNIOR, S. C. S. G. Aplicativos móveis desenvolvidos para crianças e adolescentes que vivem com doenças crônicas: uma revisão integrativa. **Interface (Botucatu)**, v. 25, e200648, p. 1-17, 2021. DOI: 10.1590/interface.200648.

GODINO-IÁÑEZ, M. J. *et al*. Play therapy as an intervention in hospitalized children: a systematic review. **Journal of Healthcare**, v. 8, n. 239, p. 1-12, 2020. DOI: 10.3390/healthcare8030239.

GODOY, A. S. Pesquisa qualitativa: tipos fundamentais. **Revista de Administração de Empresas**, v. 35, n. 3, p. 20-29, 1995. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0034-75901995000300004>

GOMES, I. L. V. *et al*. A hospitalização no olhar de crianças e adolescentes: sentimentos e experiências vivenciadas. **Cogitare Enfermagem**, v. 17, n. 4, p. 703-709, 2012. DOI: <https://doi.org/10.5380/ce.v17i4.30378>

GOMYKO, Y. V. Cultural-historical psychology of mastering activity and alternatives to digitalization. **Cultural-Historical Psychology**, v. 19, n. 2, p. 27-40, 2023. DOI: 10.17759/chp.2023190204.

GONZALEZ, T. S.; BARBOSA-LIMA, M. C. A.; VASCONCELLOS-SILVA, P. R. A arte em papéis virtuais: análise dos desenhos de crianças (5-12 anos) sobre a pandemia de COVID-19 da campanha “Sentimentos no Papel” (2020) da UNICEF Brasil. **EaD em Foco**, v. 15, n. 1, p. e2438, 2025. DOI: 10.18264/eadf.v15i1.243.

HAIDT, J. **A geração ansiosa**: como a infância hiperconectada está causando uma epidemia de transtornos mentais. São Paulo: Companhia das Letras, 2024.

HAKIM, A. *et al.* The effect of non-verbal music on anxiety in hospitalized children. **BMC Pediatrics**, v. 23, p. 279, p. 1-6, 2023. DOI: 10.1186/s12887-023-04101-2.

HEN, M. Art therapy for children in short-term hospitalization. **Continuity in Education**, v. 4, n. 1, p. 83-95, 2023. DOI: 10.5334/cie.63.

INSTITUTO AYRTON SENNA. **As 10 competências gerais da BNCC e as competências socioemocionais**. 2020. Disponível em: <https://institutoayrtonsenna.org.br/app/uploads/2022/12/instituto-ayrton-senna-as-10-competencias-gerais-da-bncc-e-as-competencias-socioemocionais.pdf> Acesso em: 2 mar. 2025

ITAU SOCIAL. **Guia para mediação de literatura infantil digital**. 2020. Disponível em: [Leia-para-uma-Criança_Matriz-de-criterios-Literatura-Infantil-Digital.pdf](#) (itausocial.org.br) Acesso em: 6 mar. 2024

JÚNIOR, S. D. da S.; COSTA, F. J. Mensuração e escalas de verificação: uma análise comparativa das escalas de Likert e Phrase Completion. **Revista Brasileira de Pesquisas de Marketing, Opinião e Mídia**, v.15, n. 1, p. 1-16, 2014.

JURDI, S. *et al.* A systematic review of game technologies for pediatric patients. **Computers in Biology and Medicine**, v. 1, n. 97, p. 89-112, 2018. DOI: 10.1016/j.combiomed.2018.04.019.

KARISALMI, N. *et al.* Digital services to support hospitalized pediatric patients and their parents: user experience survey on a service tablet in a children's hospital. **Quality and User Experience**, v. 10, n. 5, p. 1-16, 2025. DOI: 10.1007/s41233-025-00075-4.

KASIRYE, F. An Overview of Mixed and Multi Method Research. **Advance**. p.1-7, 2021. DOI: 10.31124/advance.14681643

KHOO, E.; MITCHELL, L.; SAMMONS, M. Teacher Use of Digital Stories to Promote Reflective Practice Supportive of Migrant and Refugee Children's Sense of Belonging. **Early Childhood Education Journal**, v. 52, p. 1993-2007, 2024. DOI:10.1007/s10643-023-01538-z

KIRCHOF, E. R.; MORAIS, G. L. Literatura digital infantil, experiências sonoras e audição de histórias. **Revista FAEEBA – Educação e Contemporaneidade**, v. 31, n. 68, p. 215-230, 2022. DOI: 10.21879/faeeba2358-0194.2022.v31.n68.p215-230

KÖKSAL, O.; KILICARSLAN, E.; EMEKSIZ, S. Drawing and mutual storytelling to alleviate anxiety and improve emotional well-being in children in PICU: a randomized controlled trial. **European Journal of Pediatrics**, v. 184, n. 602, 2025. DOI: 10.1007/s00431-025-06454-5.

LI, R. *et al.* Effects of Child Life intervention on the symptom cluster of pain–anxiety–fatigue–sleep disturbance in children with acute leukemia undergoing chemotherapy.

Asia-Pacific Journal of Oncology Nursing, v. 10, n. 7, p. 1-10, May. 2023. DOI: 10.1016/j.apjon.2023.100243.

LIMA, G. Da página à tela: apontamentos sobre a leitura da literatura infantil na cultura digital. **Revista Brasileira de Alfabetização – ABA/f**, v. 1, n. 8, p. 136-156, jul./dez. 2018. DOI:10.47249/rba.2018.v1.299

LORESKÄR, P.; BINDER, P. E. Nothing less than a creative triumph: a study of children admitted to hospital for serious somatic illness or injury and their experience of art therapy. **Frontiers in Psychology**, v. 15, n. 1353507, p. 1-15, 2024. DOI: 10.3389/fpsyg.2024.1353507.

LUCIAN, R. Repensando o Uso da Escala Likert: Tradição ou Escolha Técnica? **Revista Brasileira de Pesquisas de Marketing, Opinião e Mídia**, v. 18, p. 13-32, 2016. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/301687422_Repensando_o_Uso_da_Escala_Likert_Tradicao_ou_Escolha_Tecnica. Acesso em: 1 mar. 2024.

MAHALE, A. L. *et al.* Correlation of Dental Anxiety Measured by Children Drawing: Hospital Scale and SEM Scale with the Intelligence Quotient Levels Measured by Binet Kamat Test among Children Aged 6–9 Years. **J. Pediatr. Dent.**, v. 9, n. 1, p. 1-7, 2024.

MANOMENIDIS, G. *et al.* Evaluating children's drawings as a means of expression in children with chronic diseases. **Medical Archives**, v. 79, n. 2, p. 159-163, 2025. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/392727260_Evaluating_Children%27s_Drawings_as_a_Means_of_Expression_in_Children_with_Chronic_Diseases Acesso em: 1 mar. 2025.

MEDINA, C.; SOEBEL, D. M. Care-giverchild interaction influences casual learning and engagement during structured play. **Journal of Experimental Child Psychology**, v. 189, n. 104678, p. 2-12, 2019. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jecp.2019.104678>

MELO, A. S. *et al.* A contação de história e seus contributos para a interação e desenvolvimento linguístico da criança. **Revista OLHARES**, Guarulhos, v. 8, n. 3, p.1-18, dez. 2020. DOI:10.34024/olhares.2020.v8.11161

MENEGAZZI, D.; SYLLA, C. Reading hotspots: a method to evaluate reader and mediator's experience with children's digital books. **Brazilian Journal of Information Design**, v. 20, n. 3, p. 1-19, 2023.

MERRIMAN, B.; GUERIN, S. Using children's drawings as data in child-centred research. **The Irish Journal of Psychology**, v. 27, n. 1, p. 48-57, 2006.

MERSAL, F. A.; ELWASEFY, S. A.; ELBILGAHY, A. A. Healing through art and play: reducing pain and anxiety in hospitalized children during venipuncture. **Journal of Pediatric Nursing**, v. 25, p. 22-29, 2025. DOI: 10.1016/j.pedn.2025.07.009.

MINAYO, M. C. S. Amostragem E Saturação Em Pesquisa Qualitativa: Consensos E Controvérsias. **Revista Pesquisa Qualitativa**. São Paulo (SP), v. 5, n. 7, p. 01-12, 2017.

MORAIS, G. L. Do livro ilustrado ao aplicativo: reflexões sobre multimodalidade na literatura para crianças. **Estudos de Literatura Brasileira Contemporânea**, n. 46, p. 231-253, jul./dez. 2015. DOI: 10.1590/2316-40184613.

MOTTA, A. B.; ENUMO, S. R. F. Brincar no hospital: estratégia de enfrentamento da hospitalização infantil. **Psicologia em Estudo**, v. 9, n. 1, p. 19-28, 2004. DOI:10.1590/S1413-73722004000100004

NAN, J.; TIAN, Y. Parent–child shared book reading challenges and facilitators: a systematic review and meta-synthesis. **Frontiers in Psychology**, v. 16, n.1635956, p. 1-18, 2025. DOI: 10.3389/fpsyg.2025.1635956

NOVAES, H. M. D.; DE SOÁREZ, P. C. A Avaliação das Tecnologias em Saúde: origem, desenvolvimento e desafios atuais- Panorama internacional e Brasil. **Cad. Saúde Pública**, v. 36, n. 9, p.1-10, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1590/0102-311x00006820>

ONUR, S. G. *et al.* Children's drawing as a measurement of dental anxiety in paediatric dentistry. **Int J Paediatr Dent Nov**, v. 30, n. 6, p. 666-675, 2020. DOI: 10.1111/ipd.12657.

PACHECO, H. F. A.; LORDELO, L. R. “Quem conta um conto...”: a atividade criadora infantil no (re)conto de histórias. **Cadernos CEDES**, v. 44, n. 124, p. 340-350, set./dez. 2024.

PEREIRA, R. T.; ROLIM, C. L. A. A manifestação da ludicidade na hospitalização infantil: do ambiente às práticas ludo-terapêuticas. **Revista Educação Especial**, v. 35, n. 1, p. 1-25, 2022.

PERES, S. G.; NAVES, R. M.; BORGES, F. T. Recursos simbólicos e imaginação no contexto da contação de histórias. **Psicologia Escolar e Educacional**, SP, v. 22, n. 1, p. 151-161, Jan/Abr.2018. DOI: 10.1590/2175-35392018013877

PÉREZ, M. E. D. M. *et al.* Aprendizaje autorregulado del alumnado de Educación Infantil al narrar historias orales con una app. **Texto Livre**, Belo Horizonte, v. 15, n. e37844, p. 1-16, 2022. DOI: 10.35699/1983-3652.2022.37844

PINTO, A. C.; MÜLLER, G. C.; BROERING, C. V..Sentimentos pré- cirúrgicos: o que as crianças relatam? **Rev. SBPH**, Rio de Janeiro,v. 25, n. 2, p. 96-107, Jul./Dez. 2022. DOI:<https://doi.org/10.57167/Rev-SBPH.v25.479>

POLIT, D. F.; BECK, C. T. **Fundamentos de pesquisa em enfermagem: avaliação de evidências para a prática da enfermagem** [recurso eletrônico]. – 9. ed. – Porto Alegre: Artmed, 2019.

RAMOS, F. B.; VASCONCELOS, R. A. C.; NEITZEL, A. A. A arte de viver e de contar histórias: experiências de professoras na educação básica. **Educar em Revista**,

Curitiba, v. 40, n. e87633, p. 1-18, 2024. DOI:<https://doi.org/10.1590/1984-0411.87633>

REDE NACIONAL PRIMEIRA INFÂNCIA. **Plano Nacional Primeira Infância**: 2010 - 2022 | 2020 – 2030. 2. ed. Brasília: RNPI/ANDI, 2020. Disponível em: <https://primeirainfancia.org.br/wp-content/uploads/2020/10/PNPI.pdf> Acesso em: 2 mar. 2025

REGA, V.; GIOIA, F.; BOURSIER, V. Problematic media use among children up to the age of 10: a systematic literature review. **International Journal of Environmental Research and Public Health**, v. 20, n. 5854, p. 1-29, 2023. DOI: 10.3390/ijerph20105854.

REYES, Y. **A casa imaginária: leitura na primeira infância**. São Paulo: Global, 2010.

REYES, Y. O triângulo amoroso. In: LIMA, E.; FARIAS, F.; LOPES, R. (org.). **As crianças e os livros: reflexões sobre a leitura na primeira infância**. Belo Horizonte: Fundação Municipal de Cultura, 2017.

RODRIGUES, J. I. B.; FERNANDES, S. M. G. C.; MARQUES, G. F. S. Preocupações e necessidades dos pais de crianças hospitalizadas. **Saúde Soc.** São Paulo, v. 29, n. 2, p. 1-14, 2020. DOI:10.1590/s0104-12902020190395

SABETI, F. *et al.* Health care providers' experiences of the non- pharmacological pain and anxiety management and its barriers in the pediatric intensive care units. **Journal of Pediatric Nursing**, v. 60, n. 1, p. 110-116, 2021. DOI:10.1016/j.pedn.2021.07.026

SANTOS, T. A. S. *et al.* O acesso a tecnologias pelas crianças: necessidade de monitoramento. **RISTI - Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação**, v. 9, n. 38, p. 48-63, 2020. DOI: 10.17013/risti.38.48–63

SEAWRIGHT, J. **Integrative Multi-Method Research**. Cambridge University Press. Strategies for Social Inquiry. 246p. 2016.

SEKHAVATPOUR, Z. *et al.* The effect of storytelling on anxiety and behavioral disorders in children undergoing surgery: a randomized controlled trial. **Pediatric Health Med**, v. 11, n. 10, p. 61-68, 2019. DOI: 10.2147/PHMT.S201653

SELAJ, Š.; HORVAT, J.; ŽMAVC, M. Problematic digital technology use measures in children aged 0 to 6 years: scoping review. **JMIR Mental Health**, v. 12, n. e59869, p. 1-27, 2025. DOI: 10.2196/59869.

SILLERO, S. A. *et al.* Child-centered care: a qualitative study exploring pediatric hospitalization through children's perspectives. **Nursing Reports**, v. 14, p. 3138-3149, 2024. DOI: 10.3390/nursrep14040228.

SILVA, J. M. M. O desenho na expressão de sentimentos em crianças hospitalizadas. **Fractal: Revista de Psicologia**, v. 22, n. 2, p. 447-456, maio/ago. 2010. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1984-02922010000800016>

SILVA, R. M. G.; PULINO, L. H. C. Z. Em defesa de uma educação estética como ética do ensinar e do aprender em espaços escolares. **Boletim de Conjuntura-BOCA**, v. 14, n. 42, Boa Vista, 2023.

SIMÕES, V. L. B. Histórias Infantis E Aquisição De Escrita. **São Paulo Em Perspectiva**, v. 14, n. 1, p.22-28, 2000.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA. **Receite um livro: fortalecendo o desenvolvimento e o vínculo**: a importância de recomendar a leitura para crianças de 0 a 6 anos. São Paulo: Sociedade Brasileira de Pediatria, 2015.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA. **Manual de orientação: #Menos Telas #Mais Saúde – Atualização 2024**. Grupo de Trabalho Saúde na Era Digital (Gestão 2022-2024). nº 163, 13 ago. 2024.

SOUSA, C. S. *et al.* O brinquedo terapêutico e o impacto na hospitalização da criança: revisão de escopo. **Revista da Sociedade Brasileira de Enfermagem Pediátrica**, v. 21, n. 2, p. 173-180, dez. 2021. DOI: <http://dx.doi.org/10.31508/1676-379320210024>

SOUSA, J. P. de. Contação De História: Contribuição Para O Desenvolvimento Da Socialização E Aprendizagem De Crianças Da Educação Infantil. 2014. 32p. **Trabalho de Conclusão de Curso**. Universidade Federal da Paraíba, 2014.

SOUZA, A.; IRIART, M. F. S. A dimensão estética do desenho livre e suas implicações no processo de formação das funções psicológicas superiores. **Revista Zero -a -seis**. v. 24 n. 46, p. 1103-1123, 2022. DOI: <https://doi.org/10.5007/1980-4512.2022.e83300>

SOUZA, R. L. A. *et al.* A hospitalização na percepção de crianças e adolescentes em tratamento oncológico. **Revista Gaúcha de Enfermagem**, v. 42, n. e20200122, p. 1-9, 2021. DOI: 10.1590/1983-1447.2021.20200122.

STAKIĆ, M. M.; JANKOVIĆ, A. V. The role of literary texts in relation to the development and respect of the child's identity. **International Journal of Cognitive Research in Science**, v. 10, n. 1, p. 107-115, 2022. DOI:10.23947/2334-8496-2022-10-1-107-115

STRAUSS, J. *et al.* Apps for mental health. Mental Health in a Digital World. **Global Mental Health in Practice**, v. 1, n. 1, p. 355-433, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-822201-0.00006-X>

SUITSU, I. M. R. *et al.* **Castelo de areia: Game to exercise creativity through storytelling**, 2016 XI Latin American Conference on Learning Objects and Technology (LACLO), San Carlos, Costa Rica, p. 1-8, 2016.

TABATABAEY-MASHADI, N.; SUDIRMAN, R.; KHALID, P. I. An Evaluation of Children's Structural Drawing Strategies. **Jurnal Teknologi Sciences & Engineering**, v. 61, n. 2, p. 27-32, 2013. DOI: <https://doi.org/10.11113/jt.v61.1632>

TRIANTAFYLLIDIS, A. *et al.* Social robot interventions for child healthcare: A systematic review of the literature. **Information Technologies Institute, Centre for Research and Technology Hellas (CERTH)**, v. 3, n. 100108, p. 1-7, 2023.

TSCHIDA, C. M.; RYAN, C. L.; TICKNOR, A. S. Building on windows and mirrors: encouraging the disruption of “single stories” through children’s literature. **Journal of Children’s Literature**, v. 40, n. 1, p. 28-39, 2014. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/268446210_Building_on_Windows_and_Mirrors_Encouraging_the_Disruption_of_Single_Stories_Through_Children%27s_Literature Acesso em: 12 mar. 2024

UNITED NATIONS. **The Sustainable Development Goals Report 2018**. New York: United Nations, 2018. Disponível em: <https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2018/thesustainabledevelopmentgoalsreport2018-en.pdf>. Acesso em: 27 mar. 2025

ÜSTÜNER-TOP, F.; CAM, H. H. Right to health: Pediatric nurses' views on the hospitalized child. **Archives de Pédiatrie**, v. 30, n. 1, p. 59-66, 2023. DOI: 10.1016/j.arcped.2022.11.020

VYGOTSKY, L. S. **A construção do pensamento e da linguagem**. Tradução de: BEZERRA, P. São Paulo: Martins Fontes, 2000.

VYGOTSKY, L. S. A brincadeira e seu papel no desenvolvimento psíquico da criança. Trad. Zoia Prestes. **Revista Virtual de Gestão de Iniciativas Sociais**, n. 8, p. 23-36, 2008.

VYGOTSKY, L. S. **A Formação Social da Mente: o desenvolvimento dos processos psicológicos superiores**, 4 edição, São Paulo: Martins Fontes, 1991.

VYGOTSKY, L. S. **Imaginação e criatividade na infância**. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2014

VYGOTSKY, L. S. **Psicologia da Arte**. 1 ed. São Paulo: Martins Fontes, 1999.

VYGOTSKY, L. S. **Psicologia Pedagógica**. 3ed. São Paulo: Editora WMF, Maria Fontes, 2010.

WARREN, J.L. Exploring the Potential for Tangible Social Technologies for Childhood Cancer Patients within the Hospital. In: **International Conference On Tangible, Embedded, And Embodied Interaction**, v. 13, New York: Association for Computing Machinery, p. 733-736, 2019.

WILSON, M. E. *et al.* The Voices of Children: Stories About Hospitalization. **Journal of Pediatric Health care**, v. 24, n. 2, p. 95-102. 2010.

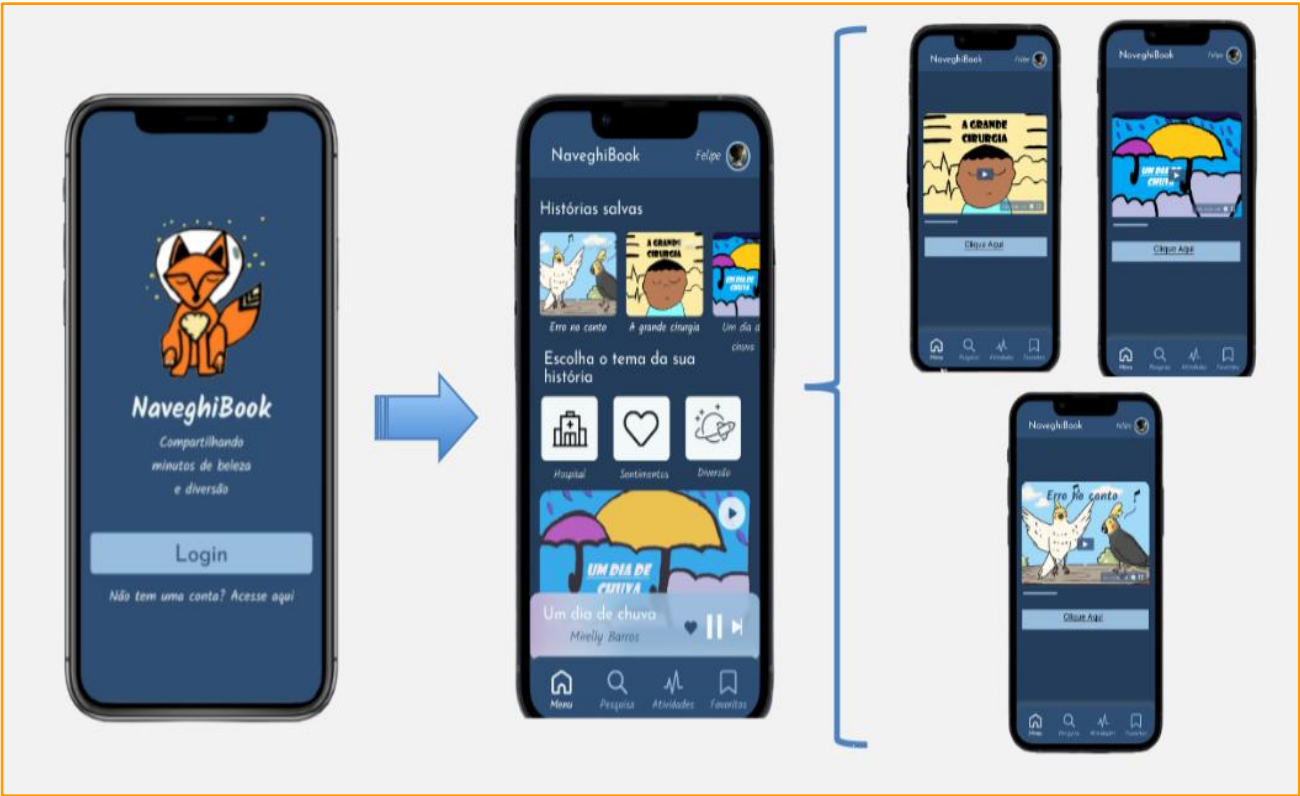
YADAV, S.; CHAKRABORTY, P. Child–smartphone interaction: relevance and positive and negative implications. **Universal Access in the Information Society**, v. 21, n. 1, p. 573–586, Abr. 2022. DOI: <https://doi.org/10.1007/s10209-021-00807-1>

ZHANG, Z. **Learning in the Arts and Aesthetic Development**. In: GOPAL, R. Learning in the Arts and Aesthetic Development . 1st Edition. First Published: Routledge India, 2022.

ZHOU, S. *et al.* Effects of art therapy on psychological outcomes among children and adolescents with cancer: a systematic review and meta-analysis. **BMC Complementary Medicine and Therapies**, v. 25, n. 149, p. 1-16, 23 abr. 2025. DOI: 10.1186/s12906-025-04866-2.

APÊNDICES

APÊNDICE A - Figura 3 - Primeira versão do aplicativo NaveghiBook, versão Figma. Recife, Pernambuco, Brasil, 2023



Fonte: elaborada pela autora (2025).
Acesse mais resultados no vídeo a seguir (etapa I):
<https://www.youtube.com/shorts/V6BBueSIYLc>

Sugestões pós validação		
Aspecto	 NaveghiBook	
Tela principal do App	Ser mais colorida	✓
Conteúdo das histórias	Deixar as letras das histórias em destaque Adicionar outros tipos de vozes para narrar as histórias.	---
Conteúdo App	Mudar a palavra e o ícone "hospital" para "saúde"	✓
Atividades criativas	Além da criação das histórias pelas crianças adicionar animações	---

Livros usados para a validação inicial das histórias criadas nesta etapa I que, posteriormente, foram inseridas em formato digital no aplicativo NaveghiBook.



Fonte: elaborada pela autora (2025).

**APÊNDICE B - Figura 4 - Capa dos livros que serão utilizadas no estudo no formato digital disponibilizadas no aplicativo NaveghiBook e em livro físico.
Recife, Pernambuco, Brasil, 2025**



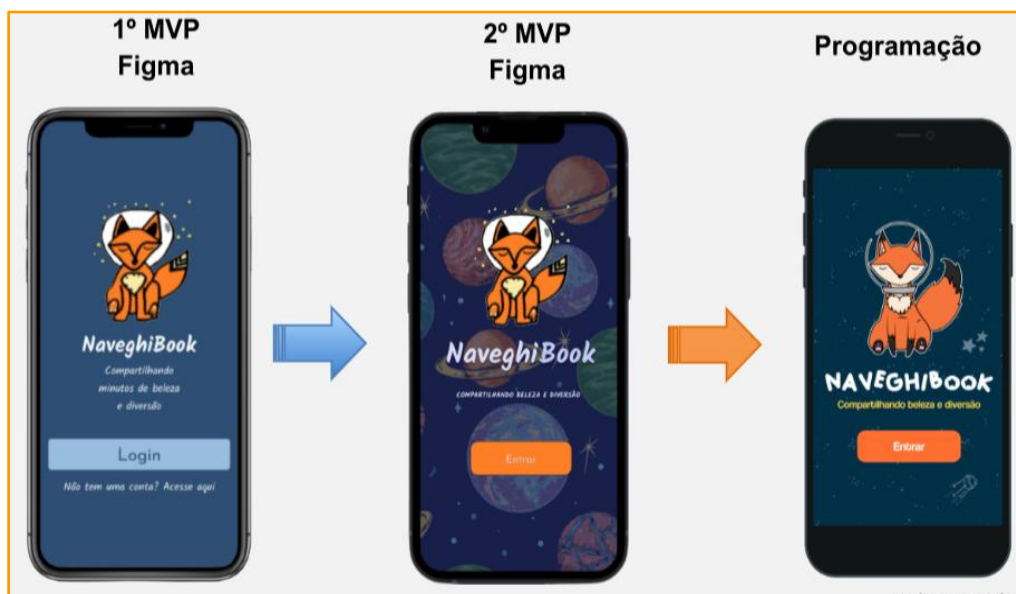
APÊNDICE C - Quadro 1 - Resumo das histórias autorais desenvolvidas para o aplicativo NaveghiBook. Recife, Pernambuco, Brasil, 2025

TÍTULO	AUTOR	RESUMO
A GRANDE CIRURGIA	Adélia Falcão	Conta a história de um menino que participou de um campeonato de futebol escolar e, durante o jogo, sofreu um traumatismo craniano. A dor era tão forte que ele sentia como se visse estrelas ao redor da cabeça. Foi necessária uma cirurgia, que reverteu a situação. No período de internação, passou por exames e precisou de repouso até, finalmente, conquistar a tão esperada alta hospitalar.
UM DIA DE CHUVA	Mirelly Barros	A história narra as aventuras de um ursinho que precisou ser internado em um dia chuvoso, acompanhado de seu pai. Durante a internação, ele usa sua imaginação para viajar por diferentes cenários: uma aventura marítima, uma aventura no espaço e uma aventura no jardim. No final, o sol volta a brilhar, e toda a família se reúne em um grande abraço, celebrando o reencontro e a superação do momento difícil.
PENACHO	Mirelly Barros	A história mostra que as diferenças de cada indivíduo, como suas pintas, coroas de penas, braços ou pernas de tamanhos variados, fazem parte de sua singularidade. Ela transmite a mensagem de que o mundo tem espaço para todos, valorizando tanto as semelhanças quanto as diferenças de cada um.
QUANDO SINTO SAUDADES	Mirelly Barros	A história narra a jornada de uma menina que viaja para lugares distantes em busca de seus sonhos. Embora suas viagens não sejam definitivas, ela sempre retorna para o aconchego do abraço materno. Mesmo sentindo saudade durante suas ausências, ela aprende que o amor permanece vivo em seu coração e no coração daqueles que ama.
O PEQUENO VIAJANTE ESTELAR	Adélia Falcão	A história narra a experiência de um menino que precisa ser internado para cuidar do coração. Durante sua estadia no hospital, ele recebe a visita inesperada de um pequeno robô chamado “Zipp”, que o leva a uma emocionante aventura pelo espaço sideral. Ao final da viagem, “Zipp” deixa uma carta cheia de encorajamento e esperança, lembrando o menino de nunca deixar de explorar o universo da imaginação.
A FAMÍLIA PANDA	Adélia Falcão	A história narra a vida de uma pequena panda chamada “Meimei”, que vive na floresta e adora

		brincar com cristais coloridos e se alimentar de bambu. Apesar de ter dificuldades com barulhos excessivos, sua família está sempre atenta, acolhendo-a com muito amor e cuidado, mostrando a beleza da vida e a importância do afeto familiar.
ERRO NO CANTO	Matheus Simplício	A história narra as aventuras de duas irmãs calopsitas: Fifo e Filó. Quando Filó amanhece sem voz para cantar, Fifo a leva ao hospital, onde a equipe de profissionais de saúde é formada por araras. Em um ambiente divertido, já que o hospital é uma árvore, a arara-azul oferece diversas opções de medicamentos, e Filó escolhe um xarope de morangos silvestres. Seguindo todas as orientações médicas, ela retorna para casa e, em breve, volta a cantar alegremente.
QUINTAL DE PASSARINHO	Mirelly Barros	A história narra a experiência de uma menina durante o período da pandemia. Ao conversar com passarinhos, ela descobre as realidades vividas por crianças de diferentes regiões do país. Conhecendo as diversas formas de enfrentamento, a menina reforça uma mensagem de esperança e otimismo para os dias futuros.
CHAPÉUS	Mirelly Barros	Apresenta, de forma simples, os diferentes chapéus usados por pessoas, profissionais e animais, levando as crianças, de forma lúdica, a viajar na imaginação e por diferentes cenários.
GRANDES HERÓIS	Mirelly Barros	A história ensina às crianças que elas são verdadeiros heróis, enfrentando o processo de adoecimento com alegria e esperança. Com coragem para realizar exames e cuidar da alimentação, aprendem que o tempo passa e, em breve, uma nova estação florescerá em suas vidas.
PETER O TOCADO PELA ÁGUA	Matheus Simplício	A história narra dois reinos que, há séculos, vivem em conflito e totalmente separados. Com o nascimento de duas crianças, surge uma nova rede de amizade capaz de reconectar os povos, mostrando que laços de afeto podem superar antigas divisões.
MEG E A VIAGEM NO TEMPO	Matheus Simplício	A história narra a vida de Meg, uma cachorrinha apaixonada por experimentos científicos, que precisa ser internada devido a problemas cardíacos. Durante a hospitalização, ela realiza diversos exames e, todas as noites ao dormir, embarca em viagens no tempo, vivendo incríveis aventuras com dinossauros raros.

Fonte: elaborada pela autora (2025).

APÊNDICE D - Figura 5 - Evolução do aplicativo NaveghiBook: programação do protótipo I (etapa II). Recife, Pernambuco, Brasil, 2023

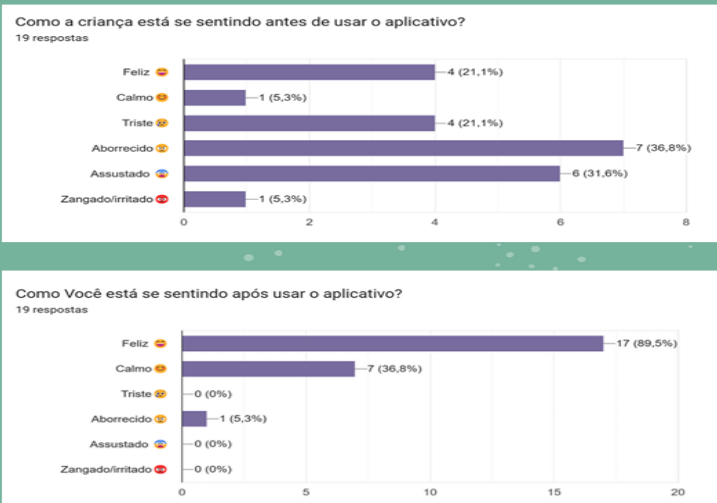


Fonte: elaborada pela autora (2025).

Acesse mais resultados no vídeo a seguir (etapa II)
[:https://www.youtube.com/watch?v=6SbFN99MDBI](https://www.youtube.com/watch?v=6SbFN99MDBI)

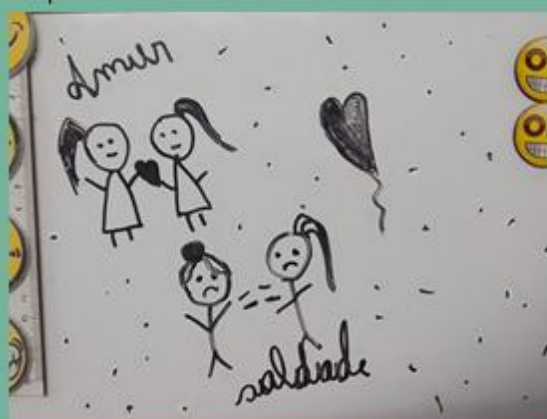


Opinião das crianças quanto aos seus sentimentos ao utilizar o aplicativo NaveghiBook a partir das faces de emoções apresentadas



MURAL DE DELICADEZAS: Significados e aprendizados durante a implementação do Aplicativo

Durante a avaliação por design participativo-PERGUNTAMOS: Como você está se sentindo nesse momento? O que você mais gostou nas histórias e atividades do aplicativo? Como você está se sentindo após usar o aplicativo? EM SEGUIDA, solicitamos que as crianças desenassem as suas respostas.



Durante a hospitalização sentimos muitas coisas, no desenho, a criança destacou a saudade e o amor, mas, certamente, o mais importante é o amor, representado pelo encontro com a pessoa amada e o balão em formato de coração que flutua.

Trazer a memória da criança sentimentos positivos como o "amor", podem fortalecer o processo enfrentamento desse momento adverso que é a hospitalização.



Após utilizar o aplicativo, conhecer as histórias e desenhar, a criança optou por fazer um autorretrato do momento que estava vivendo (sentado na cadeira, com fones de ouvido, segurando o aparelho celular), nesse dia, ele aguardava uma consulta na emergência, nos despedimos entre sorrisos.



Os passarinhos fizeram sucesso. A grande verdade é que cada criança queria ser também um passarinho livre. Ainda que nos hospitais os passarinhos não sejam vistos tão facilmente, nesta tarde, eles estavam bem pertinho!

MURAL DE DELICADEZAS: Significados e aprendizados durante a implementação do Aplicativo



Neste desenho, "Um dia de chuva" foi a história que recebeu uma atenção especial, sendo escolhida para ser ilustrada por uma criança. Aqui, a criança desenha o desejo de seu coração: reencontrar o irmão. Ao descrever o desenho, fala também que os dias de espera no hospital estão um pouco melhores e relata o seu desejo em se tornar médico.

Do lado direito, ele desenha a mãe e acredita que ela está um pouco doente. Após esse relato, oferecemos para a mãe o celular com os fones para que ela pudesse também ouvir uma história, ao ouvir a história... essa mãe deixou escapar algumas lágrimas. Ficamos em silêncio e depois juntamos nossas mãos com a dela, tentando ser apoio. Por fim, ela disse que a curta história trouxe ao seu coração esperança, esperança que os dias de chuva vão passar e o sol vai brilhar.



Nestes desenhos, "A Grande cirurgia" foi a história que recebeu uma atenção especial, sendo escolhida para ser ilustrada por duas crianças. Aqui, cada criança desenha o desejo de seu coração: ver as estrelas em uma das janelas de sua casa, como na história.

Podemos inferir que sentimentos de esperança foram despertados, cada criança notou um reflexo de si na história, notando-se como protagonistas de suas histórias reais. Crescendo o entendimento de que: o que aconteceu com a criança da história também acontecerá com ela.



MURAL DE DELICADEZAS: Significados e aprendizados durante a implementação do Aplicativo

DESENHOS(Avaliação por design participativo):



Neste desenho, o espaço que se abriu na imaginação da criança foi um amplo campo de futebol. O desejo: participar de uma partida.

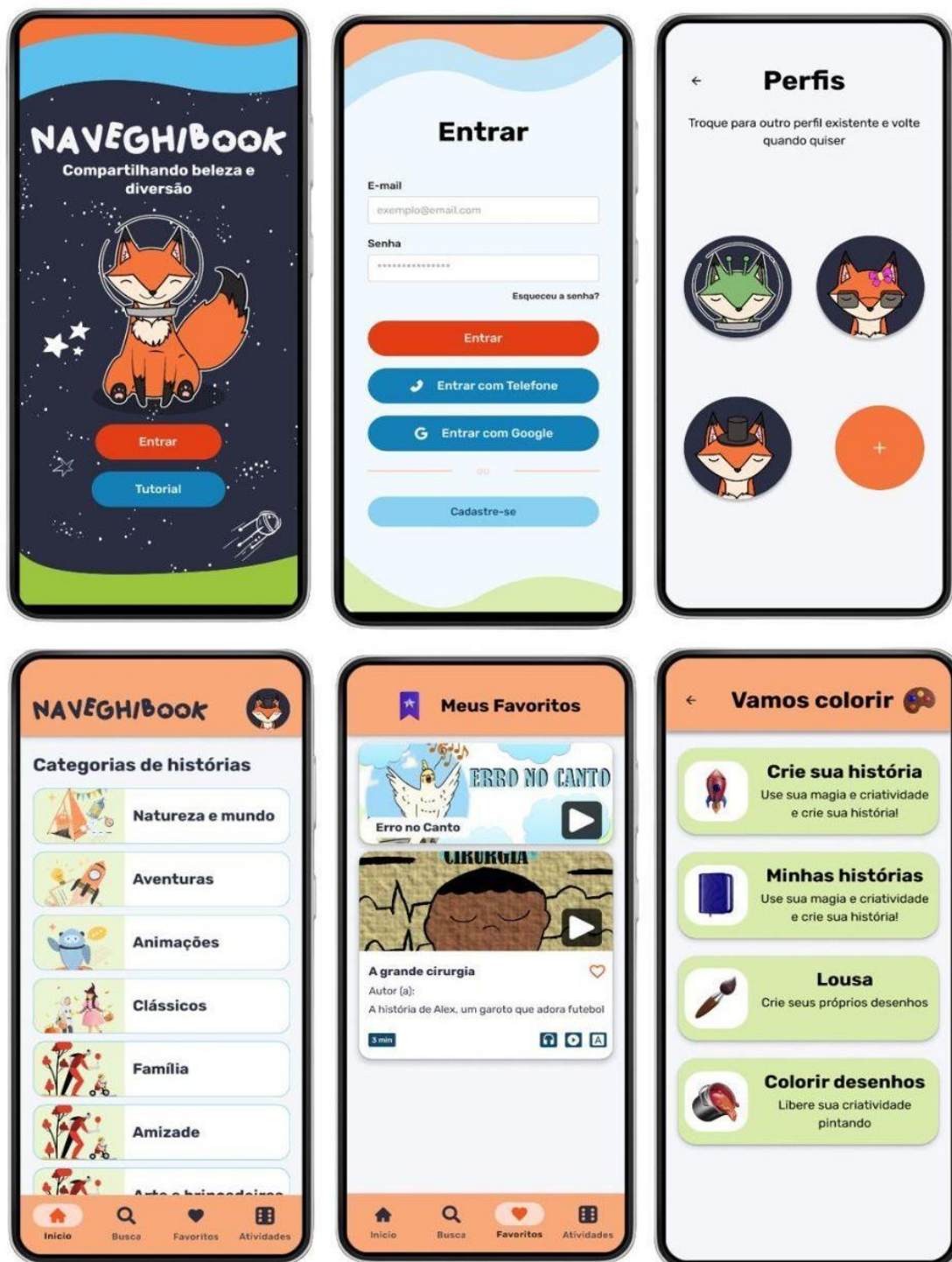


As histórias conduziram as crianças para uma realidade alternativa, de beleza e imaginação: Nunca imaginamos que uma criança poderia se ver como um passarinho, o próprio, que sua casa era um pequeno ninho, na copa de uma linda árvore! Que a realidade de hospitalização vivida pelo passarinho da história seria um elemento disparador para pensamentos sobre si e identificação relacionada ao contexto.



Mas, de algum modo, o NaveghiBook tonou possível esses pequenos pensamentos, interseções, conexões, uma visão empática, uma visão de beleza existiu ali. **(Desenho referentes a história: Erro no canto)**

APÊNDICE E - Figura 6 - Versão atual do aplicativo NaveghiBook. Recife, Pernambuco, Brasil, 2025

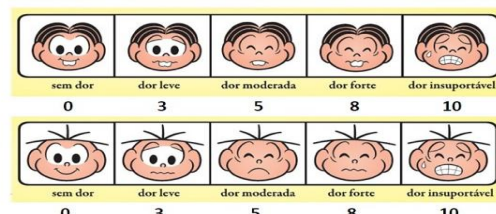




Fonte: elaborada pela autora (2025).

APÊNDICE F - ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA GRUPO DE INTERVENÇÃO II

- 1 NOME:
- 2 IDADE:
- 3 SEXO:
- 4 Escolaridade (série que está cursando atualmente):
- 5 Quais os principais sentimentos (dor) experimentados durante a hospitalização (será levado quadro ilustrativo abaixo para compreensão desses sentimentos):



- 6 Tem o hábito de ouvir/ler histórias: S () N()

6.1 Onde?

7. Qual o gênero literário favorito (Gosta mais de histórias longas ou curtas? Contos de fadas; Histórias do passado ou do futuro? Textos com ensinamentos?): _____

8. Quais aplicativos você mais utiliza quando está internado: 9. Qual a principal atividade que faz quando está em casa:

10. O que você mais gostou no aplicativo Naveghibook (faça um desenho representativo)?

11. O que você menos gostou no aplicativo Naveghibook (faça um desenho representativo)?

12. Como foi a experiência de ouvir histórias através do aplicativo (quantas estrelas você pode dar essa experiência)?

ESCALA DE LIKERT

Experiência desagradável



Experiência agradável

13. Como você se sente após usar o aplicativo?

ESCALA DE LIKERT

Ar
Mu
interfaces
recursos multimídia e interatividade)

Experiência desagradável      **Experiência agradável**

s de
k (multimodais, os

14. Equilíbrio ou Desequilíbrio- Você acha que as cores, desenhos e elementos estavam numa quantidade boa ou ruim?
15. Clareza ou Dúvida - Foi fácil ou difícil pra encontrar/para mexer as histórias?
16. Fluidez ou empecilho – O aplicativo ajudou ou atrapalhou a leitura?
17. Engajamento ou Distração- O que você achou das opções de acesso as histórias (Áudio, Vídeo, Imagens)?
18. Engajamento ou Distração- O aplicativo ajudou a entender a história ou distraiu?
19. Engajamento ou Distração- O que você achou das opções de atividades (Crie a sua história; Lousa; Colorir desenhos)?
20. Engajamento ou Distração- O que você achou das opções de desafios (Matemático; Espacial; Naturalista; Linguística; Musical; Corporal; Interpessoal; Intrapessoal)?
21. Engajamento ou Distração- O que você achou da possibilidade de compartilhar suas histórias?
22. Engajamento ou Distração- O que você achou da possibilidade de ganhar medalhas após realizar os desafios?
23. Aproximação ou Frustração- Você preferiu ajuda do seu pai/sua mãe ou mexer sozinho ou com a pesquisadora?

ESCALA DE LIKERT



Experiência desagradável



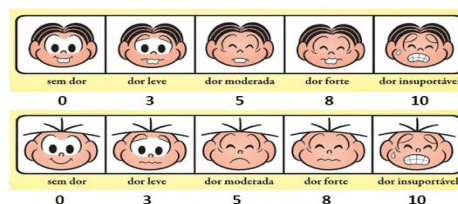
Experiência agradável

Será feito quadro interativo com a escala de Likert para gerar maior interação durante a entrevista, tornando o encontro avaliativo divertido e dinâmico. As questões 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 serão respondidas através da Escala de Likert.

24. Faça um breve resumo da história que você mais gostou e o que você aprendeu?
25. Em sua opinião, o que poderíamos melhorar no aplicativo (referente a contação de histórias)?

APÊNDICE G - ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA GRUPO DE INTERVENÇÃO I

- 1 NOME:
- 2 IDADE:
- 3 SEXO:
- 4 Escolaridade (série que está cursando atualmente):
- 5 Quais os principais sentimentos (dor) experimentados durante a hospitalização (será levado quadro ilustrativo abaixo para compreensão desses sentimentos):



- 6 Tem o hábito de ouvir/ler histórias: S () N () 6.1 Onde?
7. Qual o gênero literário favorito (Gosta mais de histórias longas ou curtas? Contos de fadas; Histórias do passado ou do futuro? Textos com ensinamentos?): _____
8. Quais histórias infantis você mais utiliza/lê quando está internado:
9. Qual a principal atividade que faz quando está em casa:
10. O que você mais gostou nesse momento de contação de histórias (faça um _____ desenho representativo)?
11. O que você menos gostou nesse momento de contação de histórias (faça um _____ desenho representativo)?
12. Como foi a experiência de ouvir histórias contadas pela pesquisadora principal (quantas estrelas você pode dar essa experiência)?

ESCALA DE LIKERT



**Experiência
desagradável**



**Experiência
agradável**

13. Como você se sente após esse momento de contação de histórias?

ESCALA DE LIKERT

Experiência
desagradável



Experiência
agradável

14. Faça um breve resumo da história que você mais gostou e o que você aprendeu?

15. Na sua opinião, o que poderíamos melhorar nesse momento de contação de histórias?

APÊNDICE H - ROTEIRO DA OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE

Universidade Federal de Pernambuco
Programa de Pós-Graduação em Saúde da Criança e
do Adolescente

1-Ambiente da abordagem:

1.1 Qu

arto

individ

ual()

1.2Enf

ermari

a()

1.3Cor

redor(

)

1.4Bri

nqued

oteca(

)

2- Como está a criança neste ambiente:

2.1 F

eliz

()

2.2

Tri

ste

(

)

2.3

Em

ati

vid

ad

e()

2.4

Co

nv

ers

an

do(

)

2.5 Com brinquedos()

2.6 Em uso de dispositivo móvel()

2.7 Irritado ()

2.8 Raiva ()

2.9 Em

isolamento/prec

aução()

3-Receptividade

Inicial

3.1 Comunicativa()

a()

3.2 Pouco

comunicativa()

va()

3.3 Brincando()

do()

3.4 Conce

ntrado()

3.5 Triste()

3.6 Apático()

3.5 Pouco colaborativo()

3.6 Sem atenção()

4-Fisionomia após a abordagem:

4.1 Comu

nicativa()

4.2 Pouco

comunica

tiva()

4.3 Brinca

ndo()

4.4 Conce

ntrado()

4.5 Triste(

)

4.6 Apático()

5-Organização do ambiente:

5.1 Ambient

e claro()

5.2 Ambient

e escuro()

5.3 Organiz

ação do

leito()

6-

Vestiment

as

6.1 Autocuid

ado

presente()

6.2 Autocuid

ado

ausente()

6.3 Autocuidado diminuído()

7-Níveis de criatividade e imaginação

7.1 A criança permite-se naquele ambiente de hospitalização navegar para outros lugares()

7.2 A criança NÃO permite-se naquele ambiente de hospitalização navegar para outros lugares()

7.3 Usa a criatividade ainda que com recursos limitados()

NÃO Usa a criatividade ainda que com recursos limitados()

ANEXOS

ANEXO A - Parecer consubstanciado do conselho de ética em pesquisa

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE
GOIÁS - UFG



PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP

Elaborado pela Instituição Coparticipante

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA

Título da Pesquisa: PERCEPÇÕES DAS CRIANÇAS HOSPITALIZADAS SOBRE CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS MEDIADAS POR UM APLICATIVO: ESTUDO DE VALIDAÇÃO

Pesquisador: MIRELLY DA SILVA BARROS SOUZA

Área Temática:

Versão: 1

CAAE: 83495924.4.3001.5078

Instituição Proponente: UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio

DADOS DO PARECER

Número do Parecer: 7.327.136

Apresentação do Projeto:

INTRODUÇÃO

A hospitalização infantil é um cenário que reduz as possibilidades da criança de expandir horizontes. Afastada do contexto familiar e escolar sofre impactos no seu crescimento e desenvolvimento, solicitando cuidados direcionados às suas enfermidades e um olhar sensível para suas necessidades enquanto ser em processo de desenvolvimento. Favorecer a escuta a partir da perspectiva das crianças, a respeito do seu processo de adoecimento e enfrentamento de suas dificuldades é essencial para organizar melhor as ações de cuidado. A contação de histórias no ambiente hospitalar é considerada uma ferramenta que pode contribuir para um cuidado sensível, favorecendo a imaginação, a criatividade e entretenimento para as crianças, colaborando para o entendimento de diferentes conteúdos e sobre si, conduzindo a compreensão dos próprios sentimentos e emoções. Ademais, no contexto contemporâneo, sabe-se que o uso de tecnologias por crianças amplia o universo de possibilidades de aprendizado, principalmente, pelo fato de existir no cenário atual o uso predominante de celulares, computadores e tablets. O aplicativo Naveghibook foi criado para ser utilizado por crianças hospitalizadas, e por meio dele, as crianças poderão acessar histórias infantis digitalizadas que abordam temáticas sobre o contexto de hospitalização, para assim, fortalecerem o conhecimento sobre si, o autocuidado, a autonomia, além da redução do

Endereço: Rua 235, nº 285, Hospital das Clínicas/UFG - Edifício de Internação, 16º Andar, Sala 1642
Bairro: St. Leste Universitário **CEP:** 74.605-050
UF: GO **Município:** GOIÂNIA
Telefone: (62)3544-8933 **E-mail:** cep.hcgo@ebserh.gov.br

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE
GOIÁS - UFG



Continuação do Parecer: 7.327.136

estresse e melhoria do enfrentamento da hospitalização. Dessa forma, o objetivo do presente estudo é analisar as percepções das crianças hospitalizadas

sobre seus sentimentos, emoções e participação ativa no cuidado, antes e após a contação de histórias mediada pelo aplicativo Naveghi Book. Para isso será realizado um estudo de validação com delineamento quase experimental, com design de grupo de controle não equivalente, com um grupo controle e um grupo experimental, utilizando instrumentos de avaliação quantitativas e qualitativas.

Para realização deste estudo, as crianças serão abordadas inicialmente, juntamente com seus responsáveis, que serão convidados a participar do estudo através da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e Termo de Assentimento Livre e Esclarecido. Após assinatura, a pesquisadora utilizará a escala de faces de dor (FACES Turma da Mônica) para avaliação inicial, em seguida a criança navegará pelo APP Naveghibook por 20-30 minutos, concluindo esse momento com a aplicação da escala Child Drawing Hospital e posteriormente, realizará uma entrevista semiestruturada. E em 24 horas, será usada escala de faces de dor (FACES Turma da Mônica) para nova avaliação inicial no segundo dia, e a criança usará novamente o APP Naveghi book e será feita uma nova aplicação da escala Child Drawing Hospital. As mesmas etapas supracitadas serão realizadas com o Grupo Controle (GC), porém, eles terão como intervenção a contação de histórias no formato tradicional, mediado pela pesquisadora principal, com livros físicos.

A coleta de dados será realizada no Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Goiás- HC/UFG, que é administrado pela Empresa Brasileira de Serviço Hospitalares (EBSERH). Mais especificamente, a pesquisa será realizada no setor de Clínica Pediátrica, vinculados à Unidade de Pediatria (UNIPED). Os participantes serão crianças de 06-10 anos de idade, internadas na Unidade supracitada. O projeto iniciará somente após aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo seres humanos da Universidade Federal de Goiás.

Hipótese:

A contação de histórias digitais mediada pelo aplicativo Naveghibook através de suas ferramentas de educação estética melhora os aspectos emocionais e a participação ativa de crianças hospitalizadas.

Metodologia Proposta:

Endereço: Rua 235, nº 285, Hospital das Clínicas/UFG - Edifício de Internação, 16º Andar, Sala 1642
Bairro: St. Leste Universitário **CEP:** 74.605-050
UF: GO **Município:** GOIÂNIA
Telefone: (62)3644-8933 **E-mail:** cep.hcgo@ebserh.gov.br

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS - UFG



Continuação do Parecer: 7.327.136

Trata-se de um estudo de validação do aplicativo Naveghibook, a partir da perspectiva das crianças hospitalizadas. Estudos de validação se propõem a verificar se um instrumento é adequado para representar a realidade ou se os resultados obtidos podem ser considerados válidos para o contexto em que serão aplicadas, as validações podem estar relacionadas ao conteúdo, ao construto ou em relação ao critério. Possui delineamento quase-experimental que é um tipo de investigação empírica que mantém elementos de experimentação, permitindo uma melhor organização das informações sobre o campo de pesquisa, ao determinar de forma dinâmica o grupo controle e o grupo experimental. O estudo quase-experimental que possui o design de grupo de controle não equivalente permite que os participantes não sejam definidos aleatoriamente.

O presente estudo utilizará uma abordagem quanti-qualitativa. A abordagem qualitativa permite compreender processos subjetivos de diferentes situações, proporcionando novos olhares para determinado contexto e processos. De modo que, a pesquisa qualitativa possibilita o entendimento de conexões complexas entre elementos. A abordagem quantitativa permitirá observar aspectos objetivos do ambiente de estudo e quantificar dados para melhor compreensão do processo de pesquisa (ZANILLA, 2011).

Para realização deste estudo, as crianças serão abordadas inicialmente, juntamente com seus responsáveis, que serão convidados a participar do estudo através da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e Termo de Assentimento Livre e Esclarecido. Após assinatura, a pesquisadora utilizará a escala de faces de dor (FACES Turma da Mônica) para avaliação inicial, em seguida a criança navegará pelo APP Naveghibook por 20-30 minutos, concluindo esse momento com a aplicação da escala Child Drawing Hospital e posteriormente, realizará uma entrevista semiestruturada. E em 24 horas, será usada escala de faces de dor (FACES Turma da Mônica) para nova avaliação inicial no segundo dia, e a criança usará novamente o APP Naveghibook e será feita uma nova aplicação da escala Child Drawing Hospital. As mesmas etapas supracitadas serão realizadas com o Grupo Controle (GC), porém, eles terão como intervenção a contação de histórias no formato tradicional, mediado pela pesquisadora principal, com livros físicos. Os dois grupos terão acesso as mesmas histórias.

A coleta de dados será realizada no Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Goiás- HC/UFG, que é administrado pela Empresa Brasileira de Serviço Hospitalares (EBSERH). Mais especificamente, a pesquisa será realizada no setor de Clínica Pediátrica, vinculados à Unidade

Endereço: Rua 235, nº 285, Hospital das Clínicas/UFG - Edifício de Internação, 16º Andar, Sala 1642
Bairro: St. Leste Universitário **CEP:** 74.605-050
UF: GO **Município:** GOIANIA
Telefone: (62)3644-8933 **E-mail:** cep.hcgo@ebserh.gov.br

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE
GOIÁS - UFG



Continuação do Parecer: 7.327.136

de Pediatria (UNIPED).

Os participantes serão crianças de 06-10 anos de idade, internadas na Unidade supracitada. Os participantes serão crianças de 6-10 anos de idade, que estejam internadas no setor de Clínica Pediátrica, em condições físicas de manter diálogo, que estejam acompanhadas de seus responsáveis que aceitem participar do estudo através da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (TALE).

Estabelece-se o período de coleta de Fevereiro à Julho de 2025.

Para a análise dos dados o NVivo será essencial para a triangulação dos dados qualitativos com os resultados obtidos pela Escala Child Drawing Hospital (CDH), promovendo uma integração robusta entre os diferentes métodos de coleta. Os níveis de construção do CD:H, testes t serão realizados para determinar se o CD:H diferenciará entre os participantes após o uso do aplicativo Naveghibook ou do momento de contação de histórias com livros físicos, posteriormente, comparará a sua relação com os dados obtidos entre os dois grupos. Serão realizadas as sistematizações dos dados coletados através da Escala Likert, originando tabelas e, por consequência, gráficos com a síntese para a análise e validação do Aplicativo NaveghiBook.

Critério de Inclusão:

- Idade entre 06 à 10 anos;- Está hospitalizado há, pelo menos, 24h;

Critério de Exclusão:

- Limitação referida pelo cuidador ou pela criança que inviabilize a mediação do aplicativo pela pesquisadora;
-Comprometimentos físicos ou mentais que dificultem a aplicação da escala CD:H ou a realização da entrevista;

Objetivo da Pesquisa:

Objetivo Primário:

*Analisar as percepções das crianças hospitalizadas sobre seus sentimentos, emoções e

Endereço: Rua 235, nº 285, Hospital das Clínicas/UFG - Edifício de Internação, 16º Andar, Sala 1642
Bairro: St. Leste Universitário **CEP:** 74.605-050
UF: GO **Município:** GOIANIA
Telefone: (62)3644-8933 **E-mail:** cep.hcgo@ebserh.gov.br

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE
GOIÁS - UFG



Continuação do Parecer: 7.327.136

participação ativa no cuidado, antes e após a contação de histórias mediada pelo aplicativo Naveghi Book;

Objetivo Secundário:

*Descrever as emoções e sentimentos das crianças em cenário de hospitalização sobre a contação de histórias mediadas pelo aplicativo Naveghi Book;

*Identificar as percepções das crianças sobre a sua participação ativa no processo de cuidado a partir da contação de histórias mediadas pelo aplicativo Naveghi Book.

* Validar o aplicativo NaveghiBook com base nas percepções de usabilidade, acessibilidade e impacto emocional das crianças hospitalizadas.

* Comparar as percepções das crianças hospitalizadas no que se refere aos seus sentimentos e emoções antes e depois da contação de histórias mediada pelo aplicativo Naveghi Book em relação ao livro físico tradicional.

Avaliação dos Riscos e Benefícios:

Riscos:

Os riscos são:

- a) A criança se sentir desconfortável em ter seu depoimento gravado e a divulgação de informações sobre você;
- b) A criança se sentir frustrado em não saber responder a alguma pergunta. Nesse caso, as pesquisadoras interromperão a entrevista e lhe perguntarão se você quer continuar usando o aplicativo ou ouvir mais uma história. As pesquisadoras lhe explicarão que não existem respostas erradas e também lhe ajudarão com informações sobre o uso do aplicativo.
- c) Em caso de expressão de alguma vivência emocional negativa, a equipe multiprofissional será comunicada, e de forma colaborativa com a pesquisadora, será realizado um plano de intervenção individual para cuidar da demanda emocional da criança.

Benefícios:

Os benefícios do estudo são: você ter um momento lúdico e de diversão durante o internamento, interagir com outras crianças e com as pesquisadoras. Benefícios adicionais estão relacionados à oportunidade de incentivo ao uso de aplicativos como ferramentas educativas no conhecimento e habilidades das crianças sobre o processo de hospitalização e ter disponível o

Endereço: Rua 235, nº 285, Hospital das Clínicas/UFG - Edifício de Internação, 16º Andar, Sala 1642
Bairro: St. Leste Universitário **CEP:** 74.605-050
UF: GO **Município:** GOIANIA
Telefone: (62)3644-8933 **E-mail:** cep.hcgo@ebserh.gov.br

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE
GOIÁS - UFG



Continuação do Parecer: 7.327.136

acesso ao aplicativo de forma gratuita após sua participação voluntária nesta pesquisa.

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:

Trata-se de um estudo de validação do aplicativo Naveghibook, a partir da perspectiva das crianças de 6 a 10 anos hospitalizadas na Enfermaria de Pediatria do HC UFG Ebserh.

Possui delineamento quase-experimental e utilizará uma abordagem quanti-qualitativa: um grupo de crianças será apresentada a leitura de livro de forma tradicional e outro grupo será apresentado a leitura do mesmo livro por meio de aplicativo.

Os riscos são de cansaço e desconfortável em ter seu depoimento gravado. Em situações de vivências emocionais negativas manifestadas pelas crianças durante a pesquisa, a equipe multiprofissional será imediatamente informada. Em colaboração com a pesquisadora, será elaborado um plano de intervenção individualizado para atender às demandas emocionais específicas da criança. Os benefícios são o fato das crianças poderem acessar histórias infantis que abordam temáticas sobre o contexto de hospitalização, para assim, fortalecerem o conhecimento sobre si, o autocuidado, a autonomia, além da redução do estresse e melhoria do enfrentamento da hospitalização. Somado a isso, levamos também a beleza e a ludicidade, através das histórias que abordam temáticas sobre a saúde, esperança, sentimentos e emoções.

O TCLE apresenta linguagem acessível e compreensível e contém todos os elementos essenciais.

O TALE embora ainda com linguagem excessiva para a faixa etária apresenta figuras ilustrativas que facilitam a compreensão da criança.

Esse projeto foi aprovado pelo CEP da Universidade Federal de Pernambuco.

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:

Todos adequadamente apresentados.

Recomendações:

Suprimir a solicitação de CPF no TCLE (e N identidade no TALE) conforme resoluções éticas e LGPD.

Endereço: Rua 235, nº 285, Hospital das Clínicas/UFG - Edifício de Internação, 16º Andar, Sala 1642
Bairro: St. Leste Universitário **CEP:** 74.605-050
UF: GO **Município:** GOIANIA
Telefone: (62)3644-8933 **E-mail:** cep.hcgo@ebserh.gov.br

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS - UFG



Continuação do Parecer: 7.327.136

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:

Não foram observados óbices éticos nesse projeto de pesquisa.

O relatório final deverá ser apresentado até 30 dias após o encerramento do estudo previsto para maio de 2026.

Considerações Finais a critério do CEP:

Este Protocolo de Pesquisa foi APROVADO COM RECOMENDAÇÃO, de acordo com as Resoluções 466/12 e complementares do Conselho Nacional de Saúde. Os aspectos que foram considerados para que esta decisão fosse tomada constam no parecer. A pesquisa poderá ser iniciada e toda e qualquer alteração no protocolo deverá ser comunicada ao CEP/HC/UFG, assim como relatório parcial e final, notificação de eventos adversos e eventuais emendas ou modificações no protocolo.

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:

Tipo Documento	Arquivo	Postagem	Autor	Situação
Projeto Detalhado / Brochura Investigador	projetoultimaoficial2311final1.docx	23/11/2024 13:59:46	MIRELLY DA SILVA BARROS SOUZA	Aceito
Brochura Pesquisa	projetoultimaoficial2311final.docx	23/11/2024 13:59:12	MIRELLY DA SILVA BARROS SOUZA	Aceito
Outros	CARTADERESPOSTAPENDNCIAS.docx	23/11/2024 13:18:07	MIRELLY DA SILVA BARROS SOUZA	Aceito
TCLE / Termos de Assentimento / Justificativa de Ausência	TALENOVEMBRO.docx	23/11/2024 13:14:16	MIRELLY DA SILVA BARROS SOUZA	Aceito
TCLE / Termos de Assentimento / Justificativa de Ausência	TCLENOV2024.docx	23/11/2024 13:14:00	MIRELLY DA SILVA BARROS SOUZA	Aceito
Outros	editalfomento2022n29.pdf	25/09/2024 11:39:33	MIRELLY DA SILVA BARROS SOUZA	Aceito
Outros	CurriculosLattesMirellydaSilvaBarros.pdf	23/09/2024 23:00:01	MIRELLY DA SILVA BARROS SOUZA	Aceito
Outros	CurriculosLattesSorayaVieiraSantos.pdf	23/09/2024 22:46:04	MIRELLY DA SILVA BARROS SOUZA	Aceito
Outros	CurriculosLattesMariaWanderleyadelav rCoriolanoMarinus.pdf	23/09/2024 22:44:31	MIRELLY DA SILVA BARROS SOUZA	Aceito
Outros	comprovantevinculoppgsca.pdf	23/09/2024	MIRELLY DA SILVA	Aceito

Endereço: Rua 235, nº 285, Hospital das Clínicas/UFG - Edifício de Internação, 16º Andar, Sala 1642
Bairro: St. Leste Universitário **CEP:** 74.605-050
UF: GO **Município:** GOIÂNIA
Telefone: (62)3644-8933 **E-mail:** cep.hcgo@ebserh.gov.br

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE
GOIÁS - UFG

Continuação do Parecer: 7.327.136

Outros	comprovantevinculoppgsca.pdf	22:38:19	BARROS SOUZA	Aceito
Outros	TermoCompromissoConfidencialidade1.pdf	23/09/2024 22:35:51	MIRELLY DA SILVA BARROS SOUZA	Aceito
Outros	SumarioExecutivoProjetoEbserh_2024.docx	19/09/2024 13:28:42	MIRELLY DA SILVA BARROS SOUZA	Aceito
Outros	cartadeanuenciaSEI SEDE42454085CartaSEI.pdf	19/09/2024 13:17:53	MIRELLY DA SILVA BARROS SOUZA	Aceito
Outros	TCUDModeloHCUFG2024setembroassinado.pdf	19/09/2024 13:15:24	MIRELLY DA SILVA BARROS SOUZA	Aceito

Situação do Parecer:
Aprovado

Necessita Apreciação da CONEP:
Não

GOIANIA, 08 de Janeiro de 2025

Assinado por:
Maria Selma Neves Costa
(Coordenador(a))

Endereço: Rua 235, nº 285, Hospital das Clínicas/UFG - Edifício de Internação, 16º Andar, Sala 1642
Bairro: St. Leste Universitário
UF: GO **Município:** GOIANIA
Telefone: (62)3644-8933

CEP: 74.605-050
E-mail: cep.hcgo@ebserh.gov.br

**ANEXO B - Child Drawing: Hospital – Versão Brasileira (Campos, F.V.
Adaptação cultural do instrumento Child Drawing: Hospital. 199 f. Dissertação.
Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2018.)**

CHILD DRAWING: HOSPITAL – VERSÃO BRASILEIRA

O INSTRUMENTO

O material necessário para a aplicação do instrumento **CD:H** consiste em uma folha de papel branco A4 e oito lápis de cor básicos (vermelho, roxo, azul, verde, amarelo, laranja, preto e marrom). A criança é orientada a desenhar a figura de uma pessoa no hospital. Isto é tudo o que é pedido à criança. Os desenhos são obtidos individualmente. A abordagem padronizada sugerida abaixo objetiva facilitar a interpretação e a atribuição da pontuação ao desenho.

A criança deve estar sentada à mesa ou ter uma superfície rígida (ex. mesa de refeição auxiliar) em uma altura apropriada. Entregar à criança a folha de papel e os lápis de cor. A folha de papel é colocada diretamente em frente à criança na diagonal, a fim de permitir que ela sozinha determine a orientação do papel. A caixa de lápis de cor deve ser aberta, expondo todos os lápis. Somente estes lápis de cor devem ser usados para desenhar (ex. lápis grafite não deve ser usado). A criança é instruída: "Por favor, desenhe uma figura de uma pessoa no hospital. Eu ficarei com seu desenho quando você terminar".

A pessoa que aplicar o **CD:H** deve observar a criança para ter certeza de que ela é capaz de executar a tarefa. No caso de a criança ser muito distraída, a orientação pode ser repetida e/ou encorajada a realizar a tarefa. Algumas crianças poderão fazer perguntas quando elas estiverem se sentindo inseguras, coagidas, desconfiadas da situação ou quando o capricho ou o desejo em tornar o desenho muito real interferirem na execução da tarefa. Estas questões devem ser respondidas com a orientação original ou com esclarecimentos que mantenham a essência da instrução e não influenciem a criança a responder de uma ou outra maneira. A criança não deve ser estimulada a adicionar partes ou cores ao desenho.

Após a finalização do desenho, quando a criança indicar verbalmente ou por gestos que ela terminou, o desenho e os lápis serão recolhidos. Não é dado limite de tempo. O desenho deve ser identificado no verso com a idade e data de nascimento da criança, sexo, todos os diagnósticos clínico-cirúrgicos (ex. diagnósticos de admissão e/ou procedimentos, bem como outros diagnósticos), data de admissão no hospital, data da finalização do desenho, número do registro hospitalar.

ATRIBUIÇÃO DE PONTUAÇÃO DO CD:H

A pontuação para cada desenho envolve a utilização do Guia de pontuação do CD:H, a Escala de Classificação e a folha de pontuação do CD:H. A pontuação total é baseada no fundamento teórico dos desenhos como medida projetiva dos estados de ansiedade das crianças.

A pontuação do desenho é dividida em três partes. A **Parte A** contém 14 itens: posição, ação, comprimento, largura e tamanho da pessoa; olhos e expressão facial; cor predominante; número de cores utilizadas; uso do papel; posicionamento no papel; qualidade do traço; inclusão e tamanho do equipamento hospitalar e o nível do desenvolvimento. Cada item é pontuado em uma escala de 1 a 10, sendo 1 o mais baixo

nível de ansiedade e 10 o mais alto. Identificadores específicos são fornecidos no Guia de Avaliação do CD:H e da Escala de Classificação. A pontuação de cada item é anotada no espaço correspondente na folha de Pontuação do **CD:H**.

A **Parte B** consiste em oito itens que presumivelmente podem indicar patologias. A omissão, o exagero e a atenuação de uma parte do corpo recebem cinco pontos. Distorção, omissão de duas ou mais partes do corpo, transparência, perfil da pessoa misto e sombreamento recebem 10 pontos cada. Se o item não estiver presente, a pontuação "0" é anotada.

A **Parte C** é a classificação da forma (*gestalt*) ou impressão do desenho como um todo, exigindo uma resposta global do avaliador para a ansiedade expressada na figura, em uma escala de 0 a 10, usando-se os identificadores específicos fornecidos. A pontuação (1) indica enfrentamento ou baixa ansiedade e a pontuação (10) indica distúrbio ou alta ansiedade.

Em cada item, usando-se a escala de um a 10 para a pontuação, o avaliador determina a pontuação dada. Alguns itens não possuem identificadores específicos. Consequentemente, é o julgamento do avaliador que determina a pontuação de cada item. Por exemplo, o item não se encaixa nos identificadores fornecidos (pontuação três e cinco), mas fica entre esses valores. Assim, o avaliador atribui a pontuação mais adequada (por exemplo, quatro). A pontuação total para cada parte é determinada somando-se os itens individuais presentes em cada parte. A pontuação total do CD:H é determinada pela soma dos totais das Partes A, B e C.

É recomendável o conhecimento do crescimento e desenvolvimento da criança, das respostas à hospitalização e do uso da arte (desenho) como uma medida projetiva para facilitar a aplicação deste instrumento. As referências citadas ao final podem ajudar na compreensão do tema. Além disso, a experiência tem mostrado que é importante: (1) ser conservador e consistente ao dar a pontuação (se em dúvida, escolher a pontuação mais alta), (2) Revisar os identificadores frequentemente (após avaliar vários desenhos, o avaliador tende a ignorar os identificadores escritos, achando que já tem uma boa compreensão deles, porém é uma ilusão) e (3) ficar atento para não cometer erros no registro dos pontos (certifique-se de que a pontuação seja registrada no espaço correto da folha de pontuação e de que cada item seja registrado).

CD:H

GUIA DE PONTUAÇÃO

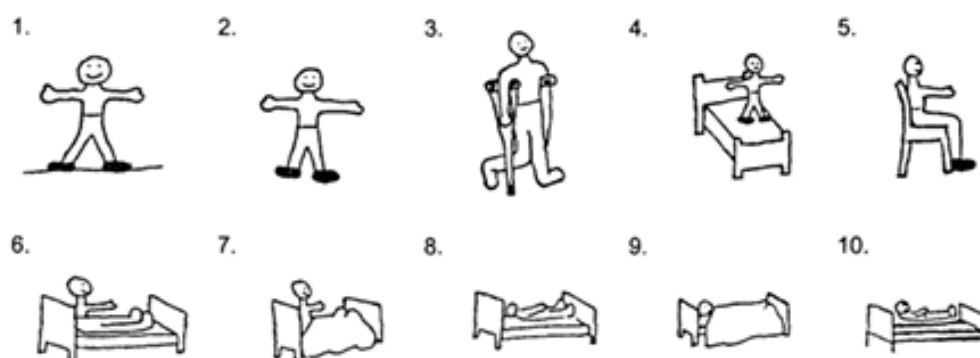
A pontuação do CD:H requer algum julgamento do avaliador. Quando possível, a subjetividade foi reduzida com identificadores e exemplos específicos descritos abaixo. O "paciente" no desenho é o foco principal da avaliação. O paciente é a pessoa na cama, na cadeira de rodas ou com muletas. O paciente pode estar sozinho no desenho ou ser nomeado pela criança. Quando o "paciente" não estiver claramente identificado, utilize a maior pessoa para avaliar.

Parte A

Cada item da Parte A é pontuado em uma escala de 1 a 10, sendo que o avaliador determina a pontuação de 1 a 10.

Item 1: Posição

As crianças tendem a mostrar uma percepção de si mesmas, de segurança e de bem-estar ao desenhar uma pessoa em uma posição independente (por ex. pessoa em pé, ereta), ao contrário de uma posição dependente (por ex., uma pessoa deitada na cama). A necessidade da criança de segurança ou apoio, muitas vezes, reflete-se em uma linha ou grama desenhada sob a figura para proporcionar uma base firme ou a sensação de ter os pés no chão (Klepsch & Logie, 1982). Desenhar a pessoa em posições indefesas indica um aumento da ansiedade e uma percepção de significância, juntamente com a perda de si mesmo e do controle do ambiente. Figuras flutuantes podem ser indicativas de insegurança (DiLeo, 1970). A ausência de pessoas nos desenhos pode significar dificuldade em se ter uma percepção de si mesmo ou dos outros (DiLeo, 1970). Pontuação:



Item 2: Ação

As crianças têm a habilidade de retratar um sentido de “vida” em seus desenhos. Quase todas as figuras desenhadas sugerem algum movimento ou energia, variando da rigidez a extrema movimentação. Movimento é mais frequentemente encontrado nos desenhos infantis (Hammer, 1980). Pessoas em pé e andando ou a inclusão de objetos em movimento demonstram uma criança com senso de controle e manutenção de si mesma. Figuras rígidas são frequentemente desenhadas por crianças que necessitam manter o controle em situações nas quais elas se sentem pequenas. Conforme a ansiedade aumenta, as crianças desenharam pessoas cada vez mais limitadas em ação. Algumas crianças desenharam apenas uma sala vazia, com ausência de pessoas, calor e vida. Pontuação:

1. Visivelmente em movimento: pessoa em movimento. Além disso, cadeiras de rodas, camas, carros, etc. em movimento podem ser desenhados.
3. Pessoa ou desenho cheio de vida: ação claramente demonstrada, por ex.: conversa demonstrada por palavras escritas, tosse, etc. Movimento em todo o desenho, por ex.: sala de operação em atividade.
5. Mostra alguma vida: sentado ou em pé. Braços levantados. Pessoas conversando. Assistindo a TV (Veja se tem figura na tela). Atividade enquanto os tratamentos são realizados, por ex.: estetoscópio no tórax ou enfermeira administrando medicações para a criança.

7. Potencial para movimento: sentado ou semirreclinado. Desenhos têm braços e pernas, mas em posição dependente. Rodas nas camas, veículos, etc.
8. Nenhum movimento, mas com vida: Deitado na cama. Braços para baixo. Nenhuma outra pessoa no quarto. Podem estar sorrindo e estar de olhos abertos.
10. Rigidez, sem vida: sem evidência de vida. Rigidez com braços para baixo ou sem braços. Maior parte do corpo coberta. Sem sorrir. Corpo preto ou desenhado em preto.

Item 3: Comprimento do Corpo

É provável que as crianças que conseguem desenhar uma pessoa com proporções corretas tenham noção de competência e segurança e estejam experimentando menos estresse. Conforme a ansiedade aumenta, as figuras humanas tornam-se menores, minúsculas e insignificantes. Este item deve ser pontuado de acordo com o tamanho da pessoa em comparação com a folha de papel. A pessoa é o "paciente".

Pontuação:

1. Corpo alto, ocupa todo o papel: usualmente com uma só pessoa. Pessoa é predominante e pode tocar as margens do papel.
2. Corpo alto, mas apropriado para o desenho: Pessoas grandes, frequentemente haverá outros objetos desenhados. Todas as partes do desenho são apropriadas em tamanho.
3. Corpo pequeno, mas apropriado para o desenho: A criança desenha as pessoas em relação ao desenho, por ex.: pode desenhara uma criança menor que o adulto.
5. Pessoas pequenas, corpos expostos: Pessoas parecem pequenas para o papel. A pessoa é inteiramente desenhada, mas de maneira pequena.
7. Pessoas muito pequenas, contidas: Pessoas muito pequenas que parecem oprimidas pelo papel.
8. Somente o tronco da pessoa: Pode incluir os braços. Corpo coberto.
9. Somente a cabeça, com o corpo coberto. Somente a cabeça está evidente, mas indica que há um corpo embaixo dos cobertores.
10. Cabeça flutuante, sem corpo: Somente a cabeça é desenhada. Cabeça na cama, sem evidência de corpo sob as cobertas. Pode estar sozinha sem outras partes no desenho.

Item 4: Largura da Pessoa em Relação ao Comprimento.

A largura do corpo em relação à altura fornece algumas indicações sobre o grau de segurança que a criança está experimentando. A largura do corpo está relacionada ao espaço usado no papel. É mais provável que a criança sem ansiedade desenhara pessoas altas que são preenchidas na largura proporcionalmente a altura. À medida que a ansiedade aumenta, os corpos tornam-se mais estreitos e ocupam menos espaço no papel. Alguns corpos são aumentados com roupas. Roupas indicam senso de valor e figuras sem roupas evidenciam o sentimento de exposição da criança. Figuras palito são frequentemente desenhadas por crianças que são hesitantes em revelarem-se a si próprias. Pontuação:

1. Largura do corpo é apropriada ao comprimento. A pessoa é proporcional e vestida com roupas.



2. Largura do corpo é discretamente reduzida em comparação ao comprimento: O corpo está completo e vestido.



3. Corpo é claramente mais magro em comparação ao comprimento, mas está vestido.



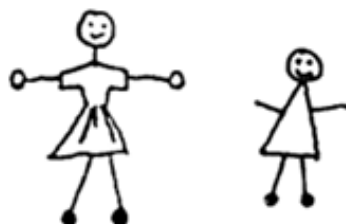
4. Corpo magro, sem roupas.



5. Largura apropriada ao comprimento, porém coberto: A cabeça é claramente ligada ao corpo, que está sob cobertores.



6. Pessoas-palito com roupas.



7. Pessoas-palito sem roupa.



8. Corpo muito magro ou pessoa-palito coberta: frequentemente desenhado como um corpo muito magro sob cobertores.



9. Formato ambíguo do corpo. Crianças muito ansiosas algumas vezes desenham corpos que não têm relação aparente com a cabeça. As cabeças são claramente desenhadas, mas o corpo é uma massa.



10. Não há evidência de corpo: Estas crianças parecem ter perdido o senso de si mesmas no ambiente hospitalar.



Item 5. Expressão Facial

A face é a parte expressiva do corpo. Crianças projetarão seus sentimentos na figura por meio da expressão facial mostrada. Expressões faciais têm sido relatadas como o mais confiável indicador de sentimento (Burns & Kaufman, 1970; Machover, 1949). Um sorriso é considerado representativo de sentimentos positivos enquanto que a cara fechada é considerada um indicador de sentimentos negativos. Falta de expressão facial pode indicar distúrbio emocional. Algumas vezes pessoas sorrindo são desenhadas em posição ameaçadora, indicando a necessidade de negar a realidade ou tentar mascarar os verdadeiros sentimentos diante da situação.

Item 6: Olhos

Crianças são fascinadas por olhos desde a tenra infância e os incluem nos desenhos de pessoas como o primeiro detalhe. O olho não é somente visto como "as janelas da alma", revelando a vida interior das crianças, mas é a base para o contato com o mundo exterior (Machover, 1949). É assim como as crianças "veem" seu mundo. Olhos com pupilas e escleróticas mostradas apropriadamente são considerados como representação de um senso de bem-estar e baixo nível de ansiedade. Olhos servem para avisar os indivíduos sobre ameaças dentro do ambiente. Crianças com a ansiedade aumentada podem desenhar olhos grandes indicando desconfiança ou hipervigilância. Crianças podem omitir os olhos com o significado de negar o problema e recusa em ver o mundo. A omissão da pupila tem um significado mais sutil de "não ver", representado apenas pelo contorno dos olhos.

Item 7: Tamanho da Pessoa em Comparação com o Ambiente

As crianças que têm um senso de controle e de si mesmas desenharão pessoas em relação ao meio ambiente. As crianças que se sentem ameaçadas e oprimidas têm mais probabilidade de desenhar pessoas pequenas em ambientes grandes. Este item deve ser pontuado comparando a pessoa com o meio ambiente identificado. Portanto, a cabeça pode ser pequena, mas o corpo proporcionalmente pequeno, numa cama pequena. Tal situação receberia uma pontuação de 1. Se o ambiente não é incluído, o papel torna-se o ambiente.

Item 8: Cor Predominante

O uso de cores mais claras e vibrantes é considerado indicativo de um grande senso de si mesma e bem-estar, enquanto que o uso de vermelho e preto é considerado indicativo de níveis mais elevados de ansiedade. Este item é baseado na interpretação habitual da cor, a partir das teorias psicológicas e associadas à cultura ocidental. O vermelho e o preto são mais característicos de sentimento intenso de raiva, agressão, ameaça, medo e perda de controle, que são frequentemente encontrados em casos de ansiedade aumentada. O amarelo, o verde e o azul são geralmente consideradas cores otimistas e felizes e são encontradas em desenhos de crianças menos ansiosas. Este instrumento é projetado para ser usada com a caixa de 8 lápis de cor. O avaliador precisa saber se todas estavam disponíveis para interpretar este item adequadamente. Além disso, às vezes uma criança insiste em usar seus próprios lápis. Para fins de coerência, pontue todas as nuances de uma cor como uma cor primária, ou seja, o rosa é pontuado como vermelho. Pontue a cor predominante pelas cores primárias equivalentes. Isso requer o julgamento do avaliador.

Item 9: Número de Cores Usadas

Somente as cores básicas são consideradas neste item. De novo, é importante saber que todas as oito cores estão disponíveis para a criança. A premissa básica é que as crianças com ansiedade aumentada não terão energia para selecionar muitas cores. As crianças que estão se sentindo melhores consigo mesmas no hospital têm maior probabilidade de usar muitas cores em seus desenhos.

Item 10: Uso do Papel

Este item é pontuado de acordo com o espaço que a criança usou do papel. As crianças muito ansiosas tendem a usar somente uma pequena porção do papel (DiLeo, 1973). Algumas crianças tentam compensar sua ansiedade usando somente uma pequena parte do papel, mas distribuem o conteúdo sobre o mesmo, por ex., uma pequena cama no canto inferior direito com uma TV pequena no canto superior direito. A essência do item é estimar a porcentagem de papel coberta pelo desenho.

Item 11: Posicionamento no Papel

As crianças tendem a ser muito específicas sobre o posicionamento do desenho no papel. As crianças que se sentem menos ansiosas tendem a posicionar seus desenhos no centro do papel. O próximo posicionamento mais frequente é um dos lados do papel. O uso do lado direito indica menos ansiedade, já que projeta um sentido de futuro ou esperança, enquanto que o lado esquerdo sugere uma orientação em direção ao passado (Klepsch & Logie, 1982). Posicionamento perto do topo da página ou no alto da página pode indicar otimismo e esforço para alcançar as metas ou o uso da fantasia quando há perda do controle e da segurança pela criança. O posicionamento perto do fim da página pode indicar insegurança ou uma pessoa tentando se tornar mais realista (Klepsch & Logie, 1982; DiLeo, 1973; Machover, 1949).

Item 12: Traços: Qualidade

A pressão, a firmeza e a solidez da linha são consideradas indicadores do senso de si mesma e bem-estar da criança (Machover, 1949). Traços firmes, escuros indicam um senso de convicção e segurança. Da mesma maneira, traços leves, claros indicam insegurança e a necessidade de cautela. Pontuação:

1. Firme, escuro: todo colorido com traços firmes.
3. Escuro com algumas partes claras: maioria escuro, mas pode haver alguns traços claros. Roupas todas escuras, mas partes do corpo com traços claros, por ex., calça escura, mas camisa clara.
5. Médio, com partes iguais de claro e escuro: frequentemente contornos escuros e cores claras para o preenchimento das áreas.
8. Claro: todos os traços são claros. Alguns podem ser mais firmes que os outros, mas nenhum demonstra pressão com o lápis.
10. Muito claro: todos os traços são iguais. Desenho não tem contornos.

Item 13: Presença de Equipamento Hospitalar

As crianças com ansiedade hospitalar têm mais probabilidade de incluir equipamentos hospitalares em seus desenhos. Os itens desenhados frequentemente representam os itens que causam a maior preocupação (por ex. dispositivos intravenosos, seringas). Na pontuação deste item, deve ser lembrado que a cama é um equipamento hospitalar. Pontue todos os equipamentos hospitalares como eles estão relacionados ao tamanho da pessoa. A ausência de equipamentos é entendida como indicativo de que eles não geram ansiedade.

Item 14: Nível de Desenvolvimento

O nível de desenvolvimento regredido mostrado nos desenhos é considerado indicativo de aumento de ansiedade. O desenho da figura humana segue um padrão sequencial de desenvolvimento (Kellogg, 1970; DiLeo, 1970; Harris, 1963; Goodenough, 1926, 1928). A premissa básica é de que, a partir dos 5 anos de idade, toda criança deveria ser capaz de desenhar uma pessoa com seis partes: com cabeça, olhos, boca, corpo, braços e pernas. Nariz, orelhas e cabelos são frequentemente encontrados, mas não são mandatórios até a idade de 7 ou 8 anos. Além disso, os braços devem ter mãos e as pernas devem ter pés. Dedos das mãos e pés são opcionais. Acredita-se que todas as crianças com 5 anos de idade terão alcançado o estágio de desenvolvimento pictórico e desenhariam uma imagem baseada na realidade.

Parte B

Os itens incluídos na Parte B pressupõem serem índices de alta ansiedade e não são encontrados em todos os desenhos. Pontos adicionais (cinco ou 10) são acrescentados quando eles são encontrados nos desenhos. Os itens são mutuamente excludentes. Por exemplo, se uma mão e um pé forem omitidos, dez pontos são atribuídos para o item 19, omissão de duas ou mais partes. Item 15, omissão de uma parte não seria pontuada. Não pontue ambos se houver uma mão e um pé omitidos.

Item 15: Omissão de Uma Parte do Corpo

A omissão de extremidades é encontrada em crianças inseguras (DiLeo 1970, 1973; Machover, 1949). Negação da preocupação com parte do corpo pode ser indicada pela sua omissão. Mãos e pés são frequentemente omitidos por crianças ansiosas, por exemplo, mão desenhada em um lado e não no outro lado. Todas as pessoas devem ter uma face com olhos e boca. O corpo deve ter braços com mãos e pernas com pés. Após os 7 anos de idade, a pessoa deve ter nariz, cabelo e orelhas. Se parte do corpo é claramente indicada sob cobertores, não pontue como parte ausente. Não pontue orelhas como ausentes se estiverem embaixo do cabelo.

Item 16: Exagero de Uma Parte do Corpo

Crianças aumentarão o tamanho de uma parte do corpo que é importante ou emocionalmente preocupante para elas. Burns e Kaufman (1970) sugerem que isto é uma preocupação com a região, por exemplo, uma perna muito maior que a outra.

Item 17: Diminuição de Uma Parte do Corpo

Redução ou diminuição de uma parte do corpo pode significar insegurança ou inadequação da parte do corpo para a criança (Burns & Kaufman, 1970; DiLeo, 1970). Por exemplo, um pé é desenhado muito menor que o outro.

Item 18: Distorção

A distorção ou mutilação de uma figura é altamente relacionada a distúrbios de personalidade (DiLeo, 1973; Burns & Kaufman, 1970). Este item deve ser pontuado se (1) duas ou mais partes do corpo estiverem distorcidas em tamanho (exagero ou diminuição), (2) partes do corpo estão desconectadas do corpo, (3) a cabeça e o corpo não são proporcionais entre si (por ex., cabeça muito grande e um corpo muito pequeno); ou (4) todo o corpo é deformado.

Item 19: Omissão de Duas ou Mais Partes

Este item é pontuado quando duas ou mais partes do corpo são omitidas. Por exemplo, duas mãos são omitidas ou uma mão e um pé são omitidos.

Item 20: Transparência

Crianças em uma sequência normal do desenvolvimento da figura humana pode mostrar parte do corpo através da roupa até o momento em que elas desenvolvem uma realidade visual em seus desenhos, aproximadamente aos 8 ou 9 anos de idade (Machover, 1949). Após os 9 anos de idade, transparência é encontrada nos desenhos de crianças e adultos perturbados. O uso de transparência do corpo indica ansiedade aguda e/ou conflito sobre a imagem corporal. Este item é pontuado se um órgão é desenhado e mostrado através da pele (ossos, coração, estômago) em qualquer idade. Após os 9 anos de idade, este item é pontuado se partes do corpo são mostradas através da roupa ou cobertores, porque transparências são patológicas após os 9 anos de idade.

Item 21: Perfil Misto da Pessoa

Enquanto a criança está aprendendo a desenhar o perfil das pessoas, elas podem desenhar dois narizes, bocas ou olhos na pessoa (DiLeo, 1970). O perfil misto deve ser eliminado a partir dos 9 anos e certamente a partir dos 10 anos de idade. Portanto, este item é pontuado se dois olhos, etc., são encontrados em um perfil desenhado por uma criança com mais de 10 anos de idade.

Item 22: Sombreamento

O sombreamento está sempre relacionado à ansiedade, na medida em que mais tempo e energia são investidos em objetos ou formas que são sombreadas do que aquelas que não estão sombreadas. Se todo o corpo é sombreado, a ansiedade pode ser considerada ansiedade generalizada. Se somente uma parte do corpo específica é sombreada, então a ansiedade pode estar relacionada àquela parte específica (Klepsch & Logie, 1982; Machover, 1949). Sombreamento refere-se a traços que são designados para preencher uma área. Colorir ou rabiscar sobre uma parte do corpo, não indicando roupas ou cor da pele, é considerado sombreamento. Sombreamento também pode ser visto quando a extremidade é pintada de cor diferente. Colorir o todo ou parte do fundo também é considerado como sombreamento (por ex., céu e chão, cobertores).

Parte C

A impressão geral do desenho é importante. Esta impressão global do desenho é a mais importante informação, mais que a informação dada por cada item específico. O avaliador é solicitado a pontuar o sentido global que o desenho tem para eles.

Pontuação:

1. Enfrentamento: Realista, agradável, bem proporcionado, brilhante, feliz, confiante.
5. Estresse leve: menos agradável, alguma distorção de tamanho, menos brilhante e animado.
8. Estressado: Apertado, inibido, fraco, cinzento, triste, assustado.
10. Perturbado: Oprimido, bizarro, desorganizado, sentindo-se triste ou derrotado.

Child Drawing: Hospital – Versão Brasileira

QUADRO PARTE A

PARTE A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Posição da Pessoa	Em pé, no chão	Em pé, sem chão	Em pé, com muletas	Em pé, na cama	Sentado na cadeira	Sentado na cama	Sentado na cama, coberto	Deitado na cama	Deitado na cama, coberto	Flutuando ou sem pessoa
2. Ação - vida	Visivelmente em movimento		Pessoa ou desenho vivo		Mostra alguma vida		Potencial para movimento	Sem movimento, mas vivo		Rígido, sem vida
3. Comprimento da pessoa	Corpo alto, ocupa todo o papel	Corpo alto, apropriado ao desenho	Corpo pequeno, apropriado ao desenho	Corpo fino, sem roupas ou apropriado, mas sem roupas	Pessoa pequena, corpo exposto		Muito pequeno, pessoa contida	Somente o tronco	Somente cabeça, corpo coberto	Cabeça flutuante, sem corpo
4. Largura da pessoa	Largura apropriada ao comprimento	Largura ligeiramente reduzida comparada ao comprimento	Largura fina comparada ao comprimento, vestido	Corpo fino, sem roupas ou apropriado, mas sem roupas	Corpo apropriado em tamanho, coberto	Pessoas palito com roupas	Pessoas palito sem roupas	Corpo muito fino ou pessoa palito coberta	Forma do corpo ambígua	Sem corpo, cabeça flutuante, sem evidência de corpo sob as cobertas
5. Expressão facial	Sorriso 		Meio sorriso 		Neutro			Cara meio fechada 	Cara fechada 	Sem face, sem expressão
6. Olhos/Pupilas						 Penetrante	 Ponto	 Fechados	 Vagos,	Sem olhos

							minúsculo		sem visão	
7. Tamanho da pessoa em comparação com ambiente	Tamanho apropriado		Médio para pequeno		pequeno			Muito pequeno		Minúsculo, oprimido
8. Cor predominante	Amarelo		Verde		Azul	Laranja	Roxo	Marrom	Vermelho	Preto
9. Número de cores utilizadas	8	7	6		5	4	3		2	1
10. Utilização do papel	Todo		$\frac{3}{4}$		$\frac{1}{2}$			$\frac{1}{4}$		Restrito $\frac{1}{8}$
11. Posicionamento no papel										
12. Qualidade do traço	Firme, escuro		Escuro, algum claro		Médio – escuro e claro equivalentes			Claro		Muito claro
13. Equipamento Hospitalar	Nenhum		Proporcional em tamanho		Levemente aumentado em tamanho			Grandes equipamentos		Grandes e ameaçadores
14. Nível de desenvolvimento	Acima do normal		Normal		Levemente abaixo do normal		Abaixo do normal			Acentuadamente abaixo do normal

QUADRO PARTE B

Adicione cinco pontos para cada item a seguir:	
15. Omissão de uma parte	Mão de um lado, mas não do outro. Todas as pessoas devem ter corpo, cabeça com face com olhos e boca, braços com mãos e pernas com pés. Após a idade de sete anos, deve ter nariz, cabelo e orelhas. Se parte do corpo está sob cobertas, não pontue como parte omitida. Não considere a omissão das orelhas se cobertas por cabelo. Não pontue omissão de uma parte se for pontuar a omissão de duas ou mais partes.
16. Exagero de uma Parte do Corpo	Uma perna é muito maior que a outra. Também, pontue se a cabeça ou o corpo está exagerado.
17. Diminuição de uma parte do corpo	Um braço é muito menor que o outro. Também pontue se a cabeça ou o corpo é menor.
Adicione 10 pontos para cada item a seguir:	
18. Distorção	Uma parte do corpo está distorcida ou desconectada. Todo corpo está deformado.
19. Omissão de duas ou mais partes do corpo	Duas mãos, dois olhos, ou uma mão e um pé são omitidos.
20. Transparência	Órgãos mostrados através da pele (ossos, coração, etc.) em qualquer idade. Parte do corpo mostrada através da roupa ou cobertor ou qualquer outra transparência se a criança tem mais de nove anos de idade.
21. Perfil misto da pessoa	Em um perfil da pessoa há dois olhos, duas orelhas se a criança tiver mais de 10 anos.
22. Sombreamento	Colorir parte do corpo que não indique roupas ou cor da pele. Também pode ser vista em extremidades de cores diferentes. Colorir no todo ou em parte o fundo do desenho (por ex., céu, chão, etc.) é pontuado como sombreamento.

QUADRO PARTE C

O <i>gestalt</i> [1] é a impressão que a forma do desenho tem para o avaliador.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Enfrentamento				Estresse leve			Estressado		Perturbado
Realista, agradável, brilhante, bem proporcionado, confiante, feliz.				Menos agradável, alguma distorção de tamanho, menos brilhante e animado.			Restrito, inibido, monótono, triste, assustado.		Oprimido, desorganizado, com sentimento de tristeza e derrota, bizarro.

[¹] (Filosofia, Psicologia) Doutrina que traz em si a concepção de que não se pode conhecer o todo por meio das partes e, sim, as partes por meio do conjunto. Desse modo, a forma total de um objeto constitui uma qualidade percebida de maneira organizada e limitada, não dependendo da natureza própria de cada elemento que o compõe; teoria da forma. Michaelis Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa [Internet]. São Paulo, 2017. [citado 2017 nov 03]. Disponível em: <http://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/gestaltismo/>

FOLHA DE PONTUAÇÃO DO CD:H

Número de Matrícula da Criança:		Diagnósticos:										
Sexo:	Idade:											
PARTE A – PESSOA		Número	PARTE B - Adicione 5 pontos para cada:							Número		
1. POSIÇÃO			15. OMISSÃO DE UMA PARTE									
2. AÇÃO			16. EXAGERO DE UMA PARTE									
3. COMPRIMENTO DA PESSOA			17. DIMINUIÇÃO DE UMA PARTE									
4. LARGURA DA PESSOA			Adicione 10 pontos para cada:									
5. EXPRESSÃO FACIAL			18. DISTORÇÃO									
6. OLHOS			19. OMISSÃO DE DUAS PARTES OU MAIS									
7. TAMANHO DA PESSOA EM RELAÇÃO AO AMBIENTE			20. TRANSPARÊNCIA									
8. COR: PREDOMINANTE			21. PERFIL MISTO DA PESSOA									
9. COR: NÚMERO UTILIZADO			22. SOMBREAMENTO									
10. USO DO PAPEL			TOTAL PARTE B									
11. POSICIONAMENTO												
12. TRAÇO: QUALIDADE			PARTE C									
13. EQUIPAMENTO HOSPITALAR			Circule o número que mais claramente descreve a impressão do desenho (Gestalt)									
14. NÍVEL DE DESENVOLVIMENTO			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
TOTAL PARTE A			TOTAL PARTE C									
PONTUAÇÃO TOTAL CD:H - A + B + C												

